résidanat 2024
80 DA

BLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE UNIVERSITE BLIDA 1 "Saad DAHLEB"
Faculté de médecine "Elmehdi SI-AHMED"
CONCOURS D'ACCES AU RESIDANAT DE MEDECINE
Session Octobre 2024
Le sujet comprend 150 questions pour l'ensemble des trois épreuves.
Ces questions sont numérotées de 01 à 150
La durée totale des trois épreuves est de 04 heures
EPREUVE SCIENCES FONDAMENTALES
50 QUESTIONS

1. **Quel organite est impliqué dans la modification, le tri et l'expédition des protéines ? (Cocher la réponse juste)**
   A. Réticulum endoplasmique rugueux
   B. Appareil de Golgi
   C. Mitochondrie
   D. Lysosome
   E. Réticulum endoplasmique lisse
2. **Quel composant du cytosquelette est responsable du mouvement des cils et des flagelles ? (Cocher la réponse juste)**
   A. Microfilaments
   B. Microtubules
   C. Filaments intermédiaires
   D. Centrioles
   E. Actine
3. **Quel processus cellulaire est principalement responsable de la division du cytoplasme après la mitose ? (Cocher la réponse juste)**
   A. Mitose
   B. Cytocinèse
   C. Méiose
   D. Endocytose
   E. Exocytose
4. **Qu'est-ce que la capacitation des spermatozoïdes ? (Cocher la réponse juste)**
   A. C'est la dernière étape de modification physiologique avant la fécondation
   B. C'est un phénomène qui se déroule dans les tubes séminifères
   C. La capacitation permet la formation d'un sperme riche
   D. La capacitation est une condition préalable à la réaction acrosoinique
   E. C'est la première étape avant maturation.
5. **Le follicule secondaire est constitué de ? (Cocher la réponse juste)**
   A. Fait d'un ovocyte 2 bloqué en prophase
   B. Fait de cellules folliculaires aplaties
   C. Présence de zone glycoprotrique (la zone pellucide) a l'extérieur de l'épithélium folliculaire
   D. Le stroma ovarien se transforme en thèque du follicule
   E. Présence d'une cavité folliculaire (antrum) dans la granulosa
6. **Qu'est-ce que le phénomène de la compaction ? (Cocher la réponse juste)**
   A. C'est la formation d'un amas de cellules jointives qu'on appelle la morula
   B. C'est une modification morphologique et fonctionnelle de la morula
   C. La compaction donne uniquement les cellules trophoblastiques
   D. La compaction permet l'apparition exclusivement des cellules du bouton embryonnaire
   E. C'est un phénomène qui se déroule pendant la seconde semaine du développement embryonnaire

7. **Concernant le corps progestatif : (Cocher la réponse juste)**
    1. **Les cellules de la granulosa deviennent des cellules lutéales**
    2. **Les cellules de la thèque interne élaborent de la progestérone**
    3. **Les cellules de la granulosa élaborent de la progestérone**
    4. **Les capillaires de la thèque interne envahissent la granulosa**
    5. **Les cellules de la thèque interne sont les cellules les plus volumineuses**

    A : 1+2+4 B : 1+3+5 C : 1+3+4 D : 2+4+5 E : 3+4+5

8. **Concernant le tissu endocrinien toutes ces propositions sont justes sauf une. Indiquer laquelle :**
    A. Il peut être composé de quelques amas cellulaires dans un organe
    B. Un tissu endocrine élabore une substance appelée hormone déversée dans un canal excréteur
    C. L'antéhypophyse est une glande endocrine qui agit sur d'autres glandes endocrines
    D. Une cellule endocrine est située à proximité d'une structure vasculaire
    E. Les hormones agissent sur une cellule cible par l'intermédiaire d'un récepteur spécifique
9. **A propos du glomérule de Malpighi : (Cocher la réponse juste)**
    1. **Les capillaires glomérulaires sont fenêtrés**
    2. **La lame basale de la barrière sang/urine est formée d'une lamina densa entourée de deux lamina rara**
    3. **Les podocytes sont les cellules endothéliales des capillaires glomérulaires**
    4. **Les pédicelles sont des cellules mésangiales**
    5. **Les capillaires glomérulaires sont développés entre deux artérioles**

    A : 1+3+5 B : 1+3+4 C : 2+3+4 D : 2+3+5 E : 1+2+5

10. **Parmi les propositions suivantes indiquez la proposition juste :**
    1. **Le polygone de Willis fait communiquer le territoire artériel carotidien et le système vertébro-basilaire**
    2. **Les territoires droit et gauche des artères carotides internes communiquent entre eux grâce à une artère communicante postérieure**
    3. **La perméabilité du polygone de Willis joue son rôle essentiel de suppléance en cas d'accident vasculaire cérébral**
    4. **Les principales branches collatérales de la carotide interne sont l'artère cérébrale moyenne (ou sylvienne) et l'artère chorodienne antérieure**
    5. **Parmi les branches terminales de la carotide interne on cite l'artère hypophysaire et l'artère ophtalmique**

    A : 1+2+3 B : 1+3 C : 2+5 D : 2+4+5 E : 2+3+4

11. **Parmi les propositions suivantes indiquez la proposition juste :**
    1. **Le système postérieur (vertébro-basilaire) assure la vascularisation du tronc cérébral et du cervelet**
    2. **Parmi les branches collatérales des artères vertébrales on cite des rameaux perforants destinés au bulbe et au pont, l'artère cérébelleuse antéro-inferieure**
    3. **Les artères cérébrales postérieures sont des branches terminales du tronc basilaire**
    4. **Les territoires artériels profond et superficiel du cerveau sont indépendants l'un de l'autre**
    5. **L'artère cérébrale antérieure chemine le long de la fissure latérale du cerveau**

    A : 2+4+5 B : 1+3+5 C : 1+3+4 D : 1+4+5 E : 3+4+5

12. **Le duodénum et le pancréas : (Cocher la réponse juste)**
    A. Le duodénum est seulement sous- mésocolique
    B. La muqueuse duodénale est munie de nombreux plis longitudinalx au niveau de la partie supérieure
    C. La tête du pancréas est effilée
    D. Le canal de Santorini parcourt tout le pancréas selon son grand axe
    E. L'ampoule de Water s'ouvre dans le bord latéral de D2
13. **Le nerf médian est : (Cocher la réponse juste)**
    1. **Un nerf exclusivement moteur**
    2. **Un nerf exclusivement sensitif**
    3. **Un nerf mixte sensitivomoteur**
    4. **Une branche collatérale du plexus brachial**
    5. **Une branche terminale du plexus brachial**

    A : 1+5 B : 1+4 C : 2+4 D : 2+5 E : 3+5
14. **Quel est l'examen radiologique indiqué dans le cadre de l'urgence en cas de suspicion d'un AVC ? (Cocher la réponse juste)**
    A. Anglo-scanner cérébral.
    B. IRM cérébrale.
    C. Scanner cérébral sans injection de produit de contraste.
    D. Angiographie cérébrale.
    E. Radiographie du crâne incidence de Blondeau
15. **Un hématome sous dural aigu se présente au scanner comme : (Cocher la réponse juste)**
    A. Collection biconcave hyperdense
    B. Collection biconcave hypodense
    C. Collection en croissant hypodense
    D. Collection en croissant hyperdense
    E. Le plus souvent hyperdense quand il arrive à sa phase chronique
16. **Lorsque les vaisseaux pulmonaires restent visibles au travers d'une opacité sur une radiographie de face : (Cocher la réponse juste)**
    A. C'est une masse médiastinale pathologique
    B. C'est une grosse artère pulmonaire
    C. C'est le signe de convergence hilaire
    D. C'est le signe de la silhouette
    E. Les réponses A et C sont justes
17. **Chez un polytraumatisé, les signes du choc hypocolémique retrouvés au scanner abdomino-pelvien injecté, sont : (Cocher la réponse fausse)**
    A. Petite aorte
    B. Spasme des artères viscérales
    C. Rehaussement accentué de la rate et des surrénales
    D. Dilatation de la veine cave inférieure
    E. Intestins de choc
18. **Parmi les propositions suivantes concernant les amibes parasites du tube digestif de l'homme, une est fausse. Indiquez laquelle :**
    A. Sont des protozoaires se déplaçant à l'aide des pseudopodes appartenant aux genres : *Entameba, Endolimax et Pseudolimax*
    B. *Entameba histolytica* est spécifiquement humaine et est la seule amibe du colon pathogène pour l'homme dont la distinction entre elle et les amibes non pathogènes du genre *Endolimax et Pseudolimax* repose sur la structure microscopique du noyau
    C. *Entameba gingivalis* est une amibe de la bouche se présentant uniquement sous forme végétative, capable d'ingérer les hématies et les globules blancs
    D. *Dientameba fragilis* est une amibe se présentant uniquement sous forme végétative
    E. *Entameba histolytica* est une amibe du colon responsable d'amebose infestation et d'amebose maladie

19. Parmi les propositions suivantes concernant la leishmaniose cutanée retrouvée en Algérie, laquelle est exacte : (Cochez la réponse juste)

1. **Elle peut guérir spontanément en laissant une cicatrice indélébile et inesthétique**
2. **La leishmaniose cutanée à Leishmania major est une forme clinique pouvant se manifester par des lésions ulcérocrouteuses siégeant aux niveaux des parties découvertes du corps**
3. **La leishmaniose cutanée sporadique (du Nord) à Leishmania infantum MON-24 est une zoonose dont le réservoir animal est le rongeur**
4. **La leishmaniose cutanée sèche à Leishmania killicki est une zoonose dont le réservoir animal est le chien**
5. **Le diagnostic repose sur la mise en évidence du parasite sous sa forme amastigote à l'examen des frottis cutanés colorés, ou sous sa forme promastigote en culture des sérosités cutanées ou de l'ADN parasitaire aux niveaux des prélèvements cutanés**

A : 1+2+3 B : 2+3+4 C : 3+4+5 D : 1+2+5 E : 1+3+4

20. Pour une algérienne enceinte de retour du Gabon, ayant un accès palustre à Plasmodium falciparum confirmé (parasitémie modérée), sans aucun signe de gravité et ne vomissant pas, la prise en charge consistera en : (Cochez la réponse juste)

1. **Une administration rapide de traitement spécifique per os.**
2. **Un traitement en ambulatoire avec un contrôle clinique et parasitologique à J3, J7 et J28 après le début du traitement.**
3. **Un traitement en milieu hospitalier avec un contrôle clinique et parasitologique à J3, J7 et J28 après le début du traitement.**
4. **Une interruption médicale de la grossesse.**
5. **Abstention thérapeutique.**

A : 1+2 B : 2+4 C : 1+3 D : 3+4 E : 5

21. **Parmi les propositions suivantes concernant les poux, une est fausse. Indiquez laquelle :**

A. Leur diagnostic est assuré par la mise en évidence de l'ectoparasite adulte et/ou ses lentes ; et leur traitement repose sur le traitement du sujet atteint, de son entourage ainsi que le traitement des vêtements et de la literie

B. La phthiriose est une ectoparasitose cosmopolite due au "Phthirius pubis » dont le traitement du ou des partenaire(s) sexuel(s) n'est pas indispensable

C. La pédiculose de la tête due au "Pediculus humanus capitis" touche essentiellement les enfants d'âge scolaire et se traduit sur le plan clinique par un prurit violent du cuir chevelu à prédominance rétro-auriculaire et/ou occipitale

D. La pédiculose corporelle due au "Pediculus humanus corporis" se traduit sur le plan clinique par un prurit corporel violent et dont la contamination est assurée par les vêtements et/ou la literie contaminés

E. La phthiriose est sexuellement transmissible se manifestant essentiellement par un prurit violent de la région pubienne

22. La pneumocystose est une mycose opportuniste : (Cochez la réponse juste)

1. **Anthroponotique due à un champignon atypique « Pneumocystis jirovecii » contractée par voie aérienne.**
2. **Due à une réactivation d'un foyer pulmonaire latent lors d'une immunodépression.**
3. **Qui se traduit sur le plan clinique chez un adulte immunodéprimé par : une fièvre, une toux sèche et une dyspnée d'intensité croissante.**
4. **Dont la transmission interhumaine est possible et sa prise en charge nécessite l'isolement des malades des sujets réceptifs (immunodéprimés).**
5. **Au cours de laquelle le champignon est recherché essentiellement dans le liquide de Lavage Bronchio-Alvéolaire (LBA) par un examen direct et en culture sur les milieux usuels de mycologie.**

A : 1+2+3 B : 2+3+4 C : 1+3+4 D : 1+2+5 E : 3+4+5

23. Parmi les propositions suivantes concernant les facteurs pouvant entraîner une hyperprotéinémie, indiquez laquelle est juste :

1. **La déshydratation extracellulaire**
2. **L'insuffisance hépatocellulaire**
3. **Le syndrome néphrotique pur**
4. **Le myélome**
5. **Une alimentation riche en protides**

A : 1+2 B : 1+3+5 C : 1+4 D : 4+5 E : 1+3

24. Le glucagon sécrété en réponse à une hypoglycémie provoque : (Cocher la réponse juste)

1. **Une augmentation de la concentration intrahépatocytaire en AMPc**
2. **Une activation de la glycogène phosphorylase**
3. **Une augmentation de la concentration intrahépatocytaire en fructose 2,6-diphosphate (fructose 2,6-bisphosphate)**
4. **Une activation de la triglycéride lipase adipocytaire**
5. **Une inhibition de la gluconéogenèse**

A : 1+2+3 B : 1+2+4 C : 1+2+5 D : 1+3+4 E : 1+4+5

25. Parmi les protéines suivantes, quelle proposition correspond à celles qui migrent au niveau des bétaglobulines lors de l'électrophorèse des protéines sur agarose à pH = 8,6 ? (Cocher la réponse juste)

1. **L'orosomucoïde**
2. **La transferrine**
3. **L'haptoglobine**
4. **La fraction C3 du complément**
5. **Les immunoglobulines M**

A : 1+2 B : 1+4 C : 2+3 D : 2+4 E : 3+4

26. Toutes les entérobactéries sont résistantes naturellement à la : (Cocher la réponse juste)

A. Amoxcilline
B. Cefotaxime
C. Vancomycin
D. Colistine
E. Aminoside

27. La vaccination : (Cocher la réponse juste)

A. Crée une immunité passive
B. Suscite une immunité non protectrice
C. Est un moyen d'immunisation artificielle
D. Consiste à l'injection des anticorps spécifiques de l'agent pathogène
E. Développe chez le sujet une immunité à médiation cellulaire uniquement

28. Un antibiotique peut produire : (Cocher la réponse juste)

A. Un mécanisme de résistance seulement en diminuant la perméabilité par modification des porines
B. Un mécanisme de résistance seulement en diminuant la perméabilité par un système efflux
C. Un mécanisme de résistance seulement par inactivation enzymatique de l'antibiotique
D. Un mécanisme de résistance seulement par modification de la cible
E. Toutes les réponses sont fausses

29. La pénicilline G est un antibiotique : (Cocher la réponse juste)

A. Active sur les BGN et sur les souches productrices de pénicillinases
B. Inactive sur les BGN et sur les souches productrices de pénicillinases
C. Active sur les CGP et sur les souches productrices de pénicillinases
D. Inactive sur les CGP et sur les souches productrices de pénicillinases
E. Active sur les CGN et sur les souches productrices de pénicillinases

30. Les facteurs favorisants l'échappement des virus aux mécanismes de défense de l'hôte sont : (Cocher la réponse juste)

A. La souche virale et la porte d'entrée du virus
B. L'inoculum viral et la porte d'entrée du virus
C. La variabilité génétique des épitopes et la latence du virus
D. Le type de souche et l'inoculum viral
E. La sénescence immunitaire et la latence du virus

31. Les androgènes surrénaliens : (Cocher la réponse fausse)

A. Sont des pro-hormones inactives
B. Se transformer en hormones actives au niveau des organes cibles
C. Leur rôle biologique est négligeable chez l'homme adulte
D. Leur sécrétion est augmentée par l'ACTH hypophysaire
E. Exercent un rétrocontrôle sur l'ACTH hypophysaire

32. **L'administration de la nicotine à forte dose au niveau de la jonction neuromusculaire a pour effet : (Cocher la réponse juste)**

A. Un blocage passif des sites récepteurs cholinergiques pré-synaptiques
B. L'activation de la synthèse de neurotransmetteurs par apport accru de précurseurs
C. Une dépolarisation permanente de la membrane post-synaptique
D. Une libération accrue de neurotransmetteurs, d'où une dépolarisation plus importante
E. Une augmentation de l'entrée de Ca^{++} et donc la libération de beaucoup de transmetteurs

33. **La loi de Franc Starling stipule que : (Cocher la réponse juste)**

A. La dépense énergétique du myocarde est proportionnelle à la tension de la paroi
B. La force de contraction des ventricules dépend de la longueur initiale des fibres musculaires
C. Le débit cardiaque est inversement proportionnel au volume d'éjection systolique
D. Δ =8 J/ 4Δp=8J/πr4
E. La contraction de la fibre myocardique est maximale quelle que soit la stimulation

34. **À propos de la régulation de la pression artérielle : (Cocher la réponse juste)**

A. Le facteur atrial natriurétique (FAN) est un puissant vasoconstricteur
B. Les volorécepteurs sont des mécanorécepteurs qui répondent aux variations brutales de la PA
C. Le réflexe ischémique central est mis en jeu lorsque la PAM < 50mmHg
D. Le système rénine angiotensine baisse la PA par vasodilation et augmentation de la natriurèse
E. La régulation de la volémie est le premier mécanisme mis en jeu pour la régulation de la PA

35. **L'intoxication par l'Amanita Muscarla donne les signes suivants sauf un. Indiquer lequel :**

A. Le myosis
B. La diarrhée
C. Les nausées et vomissements
D. La sudation
E. L'hyperkaliénie

36. **Les effets indésirables des médicaments de type A : (Cocher la réponse juste)**

A. Sont rares mais mortels
B. Sont dose-dépendants
C. Nécessitent l'arrêt définitif du médicament chez le patient
D. Ne sont pas détectés dans les essais pré cliniques et cliniques
E. Surviennent après une prise chronique du médicament

37. **Les myorelaxants curarisants sont indiqués dans les situations suivantes sauf une. Indiquez laquelle** :
    A. Les interventions chirurgicales pour éviter une anesthésie trop profonde
    B. L'intubation endotrachéale
    C. L'ulcère gastrique
    D. Le traitement du tétanos
    E. Chez les patients en ventilation artificielle contrôlée

38. L'activation du système parasympathique donne l'un des effets suivants. Indiquez la réponse juste
    A. Une mydriase
    B. Une augmentation des secrétions digestives
    C. Un relâchement des parois digestives et une contraction des sphincters
    D. Une rétention d'urines
    E. Une accélération du rythme cardiaque

39. Le diagnostic de certitude de l'intoxication au CO repose sur :(une réponse juste)
    A. Une augmentation des taux de créatine kinase
    B. Un taux de carboxyhémoglobine artériel > 5% chez les non-fumeurs
    C. Une acidose lactique
    D. Le scanner cérébral
    E. L'IRM cérébral

40. Un patient recevant 03 litres d'oxygène par voie nasale présente la gazométrie suivante : (Cocher la réponse juste)

- **Ph =7.09**
- **HCO3- = 08 mEq/l**
- **Pa o2 = 98 mmHg**
- **PaCO2 = 15mmHG**
- **Excès de bases= -12**

Parmi les propositions suivantes indiquez celle qui correspond au profil gazométrique du patient :
    A. Alcalose respiratoire
    B. Acidose respiratoire aigue
    C. Acidose métabolique
    D. Alcalose métabolique
    E. Acidose respiratoire chronique

41. Une rétention proportionnée d'eau et du sodium est à l'origine d'une : (Cochez la réponse juste)
    A. Hyperhydratation extracellulaire
    B. Hyperhydratation globale
    C. Hyperhydratation intracellulaire
    D. Déshydratation extracellulaire
    E. Aucune de ces réponses

42. Le choc hypovolémique (relatif) distributif est caractérisé par : (Cocher la ou les réponses justes)

1. Une altération de la redistribution des débits régionaux
2. Une augmentation de l'extraction tissulaire en oxygène.
3. Une augmentation de la perméabilité capillaire
4. Une vasodilatation périphérique
5. Responsable d'une hypovolémie

A : 1+2 B : 2+3 C : 1+4 D : 2+5 E : 4+5

43. Les molécules HLA de classe II : (Cocher la proposition juste)

1- Sont polymorphes, formées par deux chaines β1 et β2.
2- Le polymorphisme est porté par le domaine α1 et β1 pour les molécules DR, DQ et DP
3- Les gènes de la chaine α et β sont localisés au niveau du chromosome 6
4- Présentent le peptide immunogène exogène aux lymphocytes T CD4
5- Sont exprimées par les lymphocytes B

A : 1+3
B : 2+3+5
C : 2+4+5
D : 1+2
E : 3+4+5

44. L'activation du complément a pour effet(s) biologique (s) possible(s) : (Cocher la proposition juste)

1- L'opsonisation des bactéries
2- La solubilisation des complexes immuns
3- L'induction d'une réaction inflammatoire par libération des anaphylatoxines
4- La présentation de l'antigène aux lymphocytes T par le C3b fixé sur la membrane cellulaire
5- La lyse des micro-organismes par le phénomène d'ADCC

A : 2+3+4+5
B : 1+2+5
C : 1+2+3
D : 2+3+4
E : 1+2+5

45. Concernant la réaction d'hypersensibilité de type III : (Cocher la proposition juste)

1- L'activation du système HLA est impliquée dans la survenu des lésions tissulaires.
2- Les bifurcations vasculaires sont fréquemment le siège de dépôts des complexes immuns pathogènes.
3- L'endothélium vasculaire glomérulaire est fréquemment le siège de dépôts des complexes immuns pathogènes
4- Les allo-anticorps anti HLA sont souvent incriminés dans la formation des CIC.

A : 1+2 B : 2+3 C : 3+4 D : 1+4 E : 2+4

46. Les déficits immunitaires combinés sévères DICS sont : (Cocher la proposition juste) :

1- De révélations précoces vues les manifestations cliniques patentes
2- Une BCGite est souvent rencontrée après vaccination
3- Concernant l'immunité cellulaire innée assurée par les macrophage
4- Sont soit précoces soit tardifs selon les cellules touchées (T, B, NK)
5- Une consanguinité ainsi qu'un défaut génétique prédisposant sont fortement impliqués

A : 1+2+5 B : 1+4 C : 2+3+5 D : 2+3+4 E : 4+5

47. Le stroma tumoral : (Cocher la réponse fausse)

A. Est un tissu conjonctivo –vasculaire anormal
B. Joue un rôle de soutien et de nutrition
C. Est plus développé dans les tumeurs malignes épithéliales
D. Peut avoir un rôle diagnostic
E. Peut-être une cible thérapeutique

48. **Parmi les colorations spéciales suivantes, laquelle est étudiée en lumière polarisée : (Cocher la réponse juste)**
    A. Trichrome de Masson
    B. Rouge Sirius
    C. Acide Périodique de Schiff
    D. Rouge Congo
    E. Bleu Alcian
49. **L'examen clinique d'un enfant de 05 ans retrouve une masse rétro-péritonéale. L'étude microscopique de la masse réséquée retrouve 03 composantes cellulaires : blastémateuse, stromale et épithéliale. Sa sœur présentait le même type de tumeur. Cochez parmi les propositions suivantes la mutation impliquée :**
    A. Mutation du gène Rétiinblastome (RB)
    B. Mutation du gène Von Hippel Lindeau (VHL)
    C. Mutation du gène Wilms Tumor (WT)
    D. Mutation du gène de la polypose adénomateuse (APC)
    E. Mutation du gène BRCA1 et BRCA2
50. **L'étude microscopique d'un revêtement cutané retrouve une collection de macrophages contenant dans leur cytoplasme un pigment coloré en bleu par la coloration de Perls. L'étiologie la plus probable de ce pigment est : (Cocher la réponse juste)**
    A. Une accumulation anormale de protéines
    B. Un pigment lipofushinique
    C. Un traumatisme antérieur responsable d'hémorragies
    D. Des résidus de tatouage
    E. Accumulation normale de mélanine

EPREUVE PATHOLOGIE MEDICO-CHIRURGICALE

51. Monsieur Omar, 29 ans, est victime d'un accident de la circulation. Il présente une fracture vertébrale D10-D11 avec paraplégie D10 complète et définitive. Il n'a aucune autre lésion associée. Quelles déficiences pourront être observées d'emblée chez le patient ? (Cocher la réponse juste)

1. **Déficit sensitif**
2. **Déficit moteur**
3. **Déficit de la fonction génito-sexuelle**
4. **Déficit de la fonction vésico-sphinctérienne**
5. **Impossibilité de marche**

A : 1+2+4+5 B : 1+2+3+4 C : 2+4+5 D : 1+3+5 E : 1+2+4

52. Parmi les propositions suivantes, une seule est juste. Indiquez laquelle :

A. Les fractures en bâton de craie surviennent au niveau des métaphyses de l'os en croissance
B. La nécrose aseptique post-traumatique de la tête fémorale, fréquente chez l'adulte, ne se voit pratiquement jamais chez l'enfant après fracture du col du fémur.
C. L'ostéosynthèse d'une fracture épiphysaire (par exemple de type Salter 3) est contre-indiquée car le matériel va interférer avec la croissance.
D. Les fractures diaphysaires sont de bon pronostic surtout si elles sont stables
E. Les fractures diaphysaires sont de mauvais pronostic

53. **Quelle est la complication la plus redoutable des fractures de l'extrémité inférieure du radius chez la femme âgée : (Cocher la réponse juste)**
   A. Local vicieux
   B. Lapseudarthrose
   C. La raideur
   D. Le syndrome neuro-algodystrophique
   E. Toutes les réponses sont fausses
54. **A propos des infections de la main, quelle est la proposition exacte : (Cocher la réponse juste)**
   A- Le phlegmon est traité par une antibiothérapie
   B- Le phlegmon est traité par des antiseptiques locaux
   C- Un panaris peut se compliquer d'un phlegmon de la gaine des fléchisseurs
   D- Le germe le plus fréquent est le streptocoque
   E- Le panaris doit être traité chirurgicalement quel que soit le stade évolutif
55. **Dans quelle circonstance peut-on observer un hydramnios ? (Cochez la réponse fausse)**
   A. Arrésie de l'œsophage
   B. Spina-bifida
   C. Diabète
   D. Grossesse gémeilaire mono choriale
   E. Prééclampsie

56. Les complications possibles lors d'un décollement placentaire prématuré (Cochez la réponse juste)

1. **Mort fœtale**
2. **Troubles de coagulation (CIVD)**
3. **Anurie transitoire**
4. **Le syndrome de COUVELAIRE**
5. **Nécrose tubulaire**

A : 1+2 B : 1+3 C : 1+2+3+4+5 D : 1+5 E : 1+2+3

57. **Le traitement non chirurgical du fibrome utérin comporte : (Cochez la réponse juste)**
    A. L'administration d'œstrogènes
    B. L'administration d'anti-inflammatoires non stéroïdiens
    C. L'administration de progestatifs
    D. Un traitement par radiothérapie
    E. Une association de plusieurs de ces thérapeutiques
58. **Parmi les motifs de consultation en cas de synéchie utérine : (Cochez la réponse fausse)**
    A. Aménorrhée
    B. Infertilité
    C. Dysménorrhée
    D. Ménorragie
    E. Avoûtement à répétition
59. **En cas d'Endométriose à l'HSG on peut retrouver : (Cocher la réponse fausse)**
    A. Image en baïonnette
    B. Image en flocons de neige
    C. Image tuba erecta
    D. Image en boules de gui
    E. Image en corne de taureau
60. **Le diagnostic précoce d'un gliome cérébral peut se faire par : (Cochez la réponse juste)**
    A. Syndrome d'hypertension intra crânienne
    B. Un engagement temporal
    C. Un œdème papillaire bilatéral au fond d'œil
    D. Syndrome frontal
    E. Crise d'épilepsie partielle tardive
61. La maladie de Parkinson idiopathique est caractérisée par : (Cocher la réponse juste)

1. Dégénérescence du striatum
2. Dégénérescence du locus Niger
3. Le diagnostic est clinique
4. Les signes non moteurs peuvent précéder les signes moteurs
5. Bradykinésie est associée à un tremblement d'action et ou rigidité

A : 1+3+4 B : 2+3+4 C : 2+3+5 D : 1+3+5 E : 2+4+5

62. Le syndrome cérébelleux est caractérisé par : (Cocher la réponse juste)

1. **Une asymergie du tronc**
2. **Une dysmétrie aggravée par la fermeture des yeux.**
3. **Une démarche à petits pas**
4. **Une adiadococinesie**
5. **Une dysarthrie avec parole scandée**

A : 1+2+5 B : 1+3+4 C : 1+4+5 D : 2+4+5 E : 4+5

63. **Le syndrome syringomyélique : (Cochez la réponse fausse)**
    A. Respecte la sensibilité profonde
    B. Est secondaire à une interruption bilatérale du faisceau spinothalamique
    C. Traduit une atteinte de la substance blanche centromédullaire
    D. Consiste en une atteinte dissociée de la sensibilité
    E. Responsable d'un territoire d'hypoesthésie ou d'anesthésie suspendu

64. **Quelles sont les contre-indications de la prescription des benzodiazépines : Cocher la réponse juste**
    1. **Insuffisance respiratoire**
    2. **Myasthénie**
    3. **Glaucoma**
    4. **Hypersensibilité aux benzodiazépines**
    5. **Association aux IMAO de seconde génération**

A : 1+2+3 B : 2+3+4 C : 3+4+5 D : 1+2+4 E : 2+4+5

65. **Toutes ces affirmations concernant les œsophagites caustiques sont justes sauf une. Indiquez laquelle.**
    A. Les lésions provoquées par les bases fortes sont les plus graves
    B. La détresse respiratoire est un signe de gravité
    C. L'emphysème sous cutané fait partie des signes cliniques mineurs
    D. Le stade IIa correspond à des ulcérations linéaires ou rondes
    E. Le lavage gastrique à la phase aiguë est contre indiqué
66. **L'installation d'un état fébrile progressif accompagné d'un ictère chez un malade porteur d'un gros kyste hydatique du foie droit fait évoquer : (Cocher la réponse juste)**
    A. Une rupture du kyste dans les voies biliaires
    B. Une infection du kyste
    C. Une rupture du kyste dans la cavité pleurale
    D. Une compression du kyste de la veine porte
    E. Une rupture du kyste dans la cavité péritonéale
67. **La rectocolite ulcéro-hémorragique : (Cocher la réponse fausse)**
    A. Est provoquée par une inflammation chronique de la muqueuse
    B. Atteint exclusivement l'extrémité distale du colon-rectum
    C. Est souvent révélée par une diarrhée glairo-sanglante
    D. Les lésions endoscopiques sont habituellement segmentaires
    E. Elle peut se compliquer de colectasie ou de perforation dans les formes graves

68. **Parmi les examens suivants, indiquez celui qui est utile au diagnostic positif du cancer colorectal : (Cocher la réponse fausse)**
    A. TDM abdominale
    B. Echographie abdomino-pelvienne
    C. IRM pelvienne
    D. Dosage de l'antigène carcino-embryonnaire
    E. Colonoscopie
69. **Toutes ces propositions concernant la fistule anale sont justes sauf une. Indiquez laquelle.**
    A. Proviert de l'infection des glandes d'Hermann et Desfosses
    B. L'abcès et la fistule sont deux stades différents de la même maladie
    C. Est traitée exclusivement par les antibiotiques
    D. Son traitement est le plus souvent chirurgical
    E. Elle peut être liée à une maladie de Crohn
70. **La drépanocytose homozygote est une anémie hémolytique congénitale caractérisée par la présence de l'HbS. L'évolution de la maladie peut être émaillée des complications suivantes (Cochez la réponse fausse) :**
    A. Accident vasculaire cérébral ischémique ou hémorragique
    B. Ostéonécrose des têtes fémorales
    C. Néphropathie chronique
    D. Rétinopathie
    E. Amylose cardiaque

71. **Des résultats suivants obtenus à l'EFR : VEMS : 1620 ml (valeur normale : 3400) ; capacité vitale 2030 ml (valeur normale : 4300) ; capacité pulmonaire totale : 3500 ml (valeur normale : 5500), que pouvez-vous conclure ? (Cocher la réponse juste)**
   A. Syndrome obstructif
   B. Syndrome restrictif
   C. Syndrome mixte
   D. Distension alvéolaire
   E. Bronchite chronique obstructif

72. Un Homme âgé de 34 ans, travaillant en tant que carrossier dans un atelier de mécanique depuis 12 ans où il effectue des activités de tôlerie et de peinture au pistolet (polynréthanes) et ne présentant pas d'antécédents particuliers, consulte pour une toux sèche et une dyspnée nocturne évoluant depuis quelques semaines
Quels sont les examens complémentaires que vous demanderez en première intention ? (Cochez la réponse juste)

1. **Spirométrie**
2. **Téléthorax de face**
3. **Gazométrie**
4. **Scanner thoracique**
5. **Toutes les réponses sont justes**

A : 5 B : 1+2 C : 1+2+3 D : 2+3+4 E : 1+2+4

73. Parmi les missions suivantes du médecin de travail, il y a : (Cocher la réponse fausse)
   A. Evaluation de l'aptitude d'un salarié au poste de travail
   B. Contrôle de l'absentéisme individuel
   C. Surveillance de l'état de santé des salariés exposés à des risques professionnels
   D. Activité de prescription thérapeutique
   E. Conseil technique en matière d'hygiène et de sécurité

74. Le risque de contracter une maladie est mesuré par : (Cocher la réponse juste)
   A. Le taux d'incidence multiplié par la durée moyenne de l'affection
   B. Le taux d'incidence divisé par le taux de prévalence
   C. Le taux de prévalence
   D. Le taux d'incidence
   E. Le taux de prévalence multiplié par la durée moyenne de la maladie.

75. Parmi toutes ces propositions concernant la progression du poids, de la taille et du périmètre crânien (PC) de l'enfant laquelle est juste ? (Cochez la réponse juste)
   A. La taille augmente de 45cm la première année
   B. L'enfant double son poids de naissance à 3 mois et le triple à 12mois
   C. Le PC augmente de 2cm par mois les 3 premiers mois
   D. La taille augmente de 50cm la deuxième année
   E. Le PC augmente de 0,5cm par mois la première année de vie

76. Au cours d'une Glomérulonéphrite aigue on peut observer tous ces signes sauf un, lequel : (Cochez la réponse juste)
   A. Une Oligurie
   B. Un œdème aigu du poumon
   C. Une Hypertension artérielle
   D. Une fraction C3 du complément augmentée
   E. ASLO normaux

77. **Tous ces signes doivent faire évoquer une hypothyroïdie congénitale chez le nouveau –né sauf un. Indiquez lequel ?**
    A. Une hypotonie
    B. Un ictère persistant à bilirubine directe
    C. Une hypothermie
    D. Une hernie ombilicale
    E. Une constipation
78. **Le vaccin anti rougeoleux est contre-indiqué dans toutes ces situations sauf une. Indiquez laquelle :**
    A. Déficit immunitaire
    B. Grossesse.
    C. Administration récente d'immunoglobuline.
    D. Traitement récent par des bolus de corticoides
    E. Encéphalopathie convulsivante

79. **Un nouveau-né de 48 heures né à terme consulte pour ictère. A l'examen on note un poids=3200 gr, une température à 36,6 °c, une pâleur intense, un ictère cutanéo-muqueux. L'examen neurologique est normal. FNS : Hte =20%, Hb = 7 g/dl, Groupage Nné= AB Rh positif, mère= A Rh négatif. Bilirubine totale =140mg/l, Bilirubine indirecte =120mg/l. Le diagnostic le plus probable est : (Cocher la réponse juste)**
    A. Ictère physiologique
    B. Ictère de résorption
    C. Ictère infectieux
    D. Ictère par IFM Rh
    E. Ictère par IFM ABO
80. **Un nourrisson âgé de 6 mois est examiné pour des pleurs incessants, cri et agitation suivies d'accalmies. La mère a constaté des filets de sang dans les selles. Examen clinique retrouve : T° 37°, défense et douleurs provoquées au niveau de la fosse iliaque droite. Le diagnostic que vous évoquez est celui de : (Cochez la réponse juste)**
    A. Invagination intestinale aigüe
    B. Appendicite aigue
    C. RGO avec œsophagite
    D. une méningite
    E. Parasitose intestinale
81. **Toutes les pathologies suivantes peuvent entrainer une hypertension artérielle sauf une, laquelle ?**
    A. Glomérulonéphrite
    B. Sténose de l'artère rénale
    C. Adénome surrénalien
    D. Maladie de Cushing
    E. Maladie de Marfan
82. **Tous ces diagnostics peuvent être évoqués devant une douleur thoracique sauf un. Indiquez lequel** :
    A. Syndrome coronarien aigue sans surélévation du segment ST
    B. Péricardite
    C. Dissection aortique
    D. Reflux gastro-oesophagien
    E. Embolic pulmonaire

83. **Au cours d'un état de choc, la présence de signes d'insuffisance cardiaque droite oriente vers :** (Cocher la proposition juste)
A. Un choc anaphylactique
B. Un choc septique
C. Une embolie pulmonaire
D. Une hémorragie aiguë
E. Une anoxie aiguë

84. **Les anti-inflammatoires non stéroïdiens dans l'érysipèle de la jambe : (Cocher la proposition juste) :**
A. Sont la principale arme thérapeutique
B. Réduisent les phénomènes inflammatoires
C. Sont contre-indiqués dans le traitement de l'érysipèle
D. Doivent être associés aux antibiotiques
E. Préviennent la survenue de récidives

85. **La syphilis secondaire (Cocher la réponse fausse)**
A. Est la phase septicémique de la syphilis
B. Evolue sur une période de deux ans
C. Associe des signes dermatologiques, viscéraux et généraux
D. Est précédée d'une incubation de deux ans
E. Ses manifestations régressent sans séquelles

86. **L'herpès génital : (Cocher la réponse juste)**
A. Ne touche que la femme adulte jeune
B. La primo-infection est souvent asymptomatique
C. La récurrence ne survient que chez l'immunodeficient
D. La récurrence est stéréotypée : la poussée est précédée d'une phase prodromique
E. L'éruption cutanée est faite de lésions papuleuses vulvaires

87. **Toutes ces anomalies biologiques non spécifiques peuvent être retrouvées dans un syndrome de Cushing à l'exception d'une. Indiquez laquelle ?**
A. Une anémie
B. Une hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles
C. Une alcalose
D. Une hypokaliémie
E. Une dyslipidémie

88. **Parmi les vecteurs suivants, indiquez celui qui est responsable de la transmission du paludisme ?**
A. Phlébotome
B. Glossine
C. Anophèle
D. Chrysops
E. Cyclops

89. La transmission du virus de l'immunodéficience humaine ou VIH se fait par : (Cocher la proposition juste)

1. **Voie sanguine**
2. **Voie aérienne**
3. **Voie sexuelle**
4. **Voie maternofœtale**
5. **Par piqure d'arthropodes**

A : 3+4+5 B : 2+3+4 C : 1+2+3 D : 2+3+5 E : 1+3+4

90. **Le SEPSIS est défini par l'association : (Cocher la proposition juste)**
    A. Syndrome de réponse inflammatoire systémique (SRIS) + infection
    B. SRIS + bilan inflammatoire positif
    C. SRIS + Hyperleucocytose
    D. SRIS + VS accélérée
    E. Aucune de ces propositions
91. **Devant une fièvre au retour d'un voyage tropical, quels sont parmi les diagnostics suivants ceux que vous évoquez ? (Cocher la réponse juste)**
    1. **La grippe**
    2. **Le paludisme**
    3. **Le choléra**
    4. **L'amebose hépatique**
    5. **L'ascaridiose**

    A : 1+4 B : 2+3 C : 1+3 D : 3+5 E : 2+4

92. **La Pilocarpine est un collyre : (Cocher la réponse juste)**
    A. Parasympathicomimétique
    B. Parasympathicolytique
    C. Sympathicomimétique
    D. Sympathicolytique
    E. Sans action sur le système sympathique
93. **La rétinopathie pigmentaire : (Cocher la réponse juste)**
    A. Est une affection touchant exclusivement le sujet de race noire
    B. Se manifeste par une héméralopie
    C. Se manifeste au début par une amputation du champ visuel central
    D. Est due à une atteinte des cônes
    E. Nécessite un traitement par laser
94. **Une cataracte peut survenir dans tous ces cas sauf un, lequel ?**
    A. Diabète
    B. Myotonie de Steinert
    C. Hypoparathyroïdie
    D. La prise de corticoides
    E. Maladie de Horton
95. **Parmi les angines suivantes, laquelle est habituellement unilatérale ? (Cochez la réponse juste)**
    A. Angine diphtérique
    B. Angine de la mononucléose infectieuse
    C. Angine de Vincent
    D. Angine streptococcique
    E. Herpangine

96. **Une femme, la quarantaine, présente une surdité de transmission bilatérale progressive, quel est le diagnostic le plus probable ? (Cochez la réponse juste)**
    A. Une maladie de Ménière
    B. Un neurinome de l'acoustique
    C. Un blast articulaire
    D. Une otospongiose
    E. Une surdité oto toxique

97. **L'otite séro-muqueuse se caractérise par : (Cocher la réponse juste)**
    A. Un épanchement purulent derrière un tympan intègre
    B. Une perforation atticale
    C. Des otorrhées franchement purulentes
    D. Un épanchement stérile derrière un tympan intègre
    E. Des otorrhées mucopurulentes
98. **La responsabilité civile du médecin se trouve engagée : (Cocher la réponse juste)**
    A. Lorsque le médecin commet une faute.
    B. Lorsqu'il résulte d'une faute médicale un dommage.
    C. Lorsqu'il existe un lien de causalité entre la faute médicale commise et le dommage subit au patient.
    D. Toutes les réponses sont fausses.
    E. Lorsque le médecin commet une infraction à la loi pénale
99. **Le secret médical : (Cocher la réponse exacte)**
    A. Est une obligation à laquelle sont tenus tous les professionnels de la santé.
    B. Il concerne tout ce que le médecin a vu, a compris ou il lui a été confié durant l'exercice de sa profession.
    C. En cas de non-respect du secret médical, des sanctions sont prévues par la loi.
    D. Peut impliquer des sanctions disciplinaires
    E. Toutes les réponses sont justes
100. **Un des arguments en faveur de la torsion aigue du testicule est : (Cocher la réponse juste)**
    A. Survente uniquement chez le sujet jeune
    B. Biliatéralité des symptômes
    C. Le caractère chronique de la douleur scrotale
    D. La brutalité de l'apparition des symptômes
    E. S'accompagne d'une fièvre.

Dossier clinique n°01 :
Une femme multipare âgée de 36 ans, résidant dans un village rural à vocation d'élevage bovin et ovin, enceinte de 6 mois, est hospitalisée dans le service de gynécologie obstétrique du CHU de Blida pour hyperthermie à 38,5 °C et menace d'accouchement précoce. Dans ses antécédents, on retrouve une consommation régulière de lait de vache et de fromage de chèvre traditionnel (Djben). Le médecin oriente rapidement son diagnostic vers une zoonose.

101. Quel est votre diagnostic ? (Cochez la réponse juste)
A. Fièvre typhoïde
B. Pasteurellose
C. Tuberculose à *Mycobacterium bovis*
D. Leptospirose
E. Listériose

102. Quel examen complémentaire faut-il demander ? (Cochez la réponse juste)
A. Échographie
B. Une IRM
C. Une hémoculture
D. Une sérologie de Martin et Petit
E. Dosages sérologiques

103. Vingt-quatre heures après son admission, la patiente donne naissance à un prématuré présentant des signes de méningite néonatale. L'examen bactériologique du prélèvement du liquide céphalorachidien met en évidence un petit bacille à Gram positif : pensez à ? (Cochez la réponse juste)
A. *Brucella*
B. *Mycobacterium bovis*
C. Une leptospire
D. *Pasteurella multocida*
E. Aucun de ces germes

104. Après une bonne évolution de sa méningite néo-natale, le nourrisson âgé de 5 mois consulte en pédiatrie pour rhinorrhée, éternuements, toux modérée et fébricule à 38 °C. La FNS (bilan biologique) met en évidence une hyperleucocytose à prédominance lymphocytaire. Le pédiatre lui prescrit un traitement à base d'eau physiologique (désobstruction nasale) et préfère adopter une attitude de surveillance. Le malade est revu le lendemain et on constate l'apparition de nouveaux symptômes. Ainsi, en plus de la phase catarrhale, l'état du nourrisson évolue rapidement vers une dyspnée associée à des vomissements, ce qui nécessite son hospitalisation.

Quel est votre diagnostic ? (Cochez la réponse juste)

A. Rhinopharyngite
B. Infection des voies respiratoires inférieures
C. Tuberculose pulmonaire
D. Reflux gastro-œsophagien
E. Diphtérie

105. Quel examen complémentaire faut-il demander ? (Cochez la réponse juste)

A. Scanner du thorax
B. Radiographie du thorax
C. Échographie cardiaque
D. Une IRM du thorax
E. Toutes ces réponses sont exactes

106.Un diagnostic présomptif d'une infection à *Streptococcus pneumoniae* est évoqué. Cette bactérie possède les caractéristiques suivantes sauf une. Indiquez laquelle :

A. C'est un diplocoque à Gram positif
B. Il donne une hémolyse verdâtre sur gélose au sang
C. Il est généralement sensible aux aminosides
D. Il est sensible aux sels biliaires
E. Il est souvent résistant aux macrolides et aux fluoroquinolones

107. Compte tenu des risques neurologiques engendrés par les poussées de fièvre chez un enfant en bas âge présentant une infection virale des voies respiratoires, le pédiatre craint un syndrome de Reye. Il suspecte une prescription abusive de bêta-lactamines. Il prescrira alors :

A. Antiviraux
B. Antibiotiques
C. Acide valproïque
D. Corticoïdes
E. Aucune de ces réponses

108. Au bout de deux jours, la toux s'élève au rythme de quintes (violentes et longues) et tous les essais de traitement échouent. La courbe de température reste modérément élevée (en plateau autour de 38 °C) sans franche élévation leucocytaire. Le diagnostic devient maintenant évident :

Quel est-il ? (Cochez la réponse juste)

A. Coqueluche
B. Bronchiolite
C. Grippe
D. Asthme
E. Diphtérie

109.Quel examen paraclinique allez-vous demander pour diagnostiquer l'étiologie de l'infection ? *(Cochez la réponse juste)***

A. Hémoculture
B. Prélèvement de gorge par écouvillon
C. Prélèvement trachéal
D. Sérologies Mycoplasme / Chlamydiae
E. Prélèvement par aspiration douce des sécrétions nasopharyngées

110.La méthode de choix permettant l'identification du germe se fera par la technique suivante : *(Cochez la réponse juste)***

A. Immunofluorescence directe
B. Sérologie
C. Culture sur milieu Bordet et Gengou
D. PCR en temps réel
E. Coloration de Gram

Dossier n°02

Une femme âgée de 48 ans, secrétaire de profession, hypertendue sous traitement type inhibiteur de l'enzyme de conversion, aux antécédents d'hernie discale opérée il y a 06 ans et d'hystérectomie il y a deux ans, pour fibrome utérin, se plaint depuis trois mois d'une douleur en fin de nuit (à partir de 4 heures du matin), suivie d'une raideur (tous les matins pendant une heure), siégeant principalement aux articulations métatarso-phalangiennes, métacarpo-phalangiennes et interphalangiennes proximales des deux pieds et des deux mains.

L'examen clinique retrouve une patiente à l'état général conservé, température à 37.2°C, fréquence respiratoire à 21 cycles/min, TA à 105/80, poids à 58 kg pour une taille de 1.54 m.

L'examen ostéo-articulaire retrouve une tuméfaction des doigts avec rougeur et chaleur à la palpation au niveau de l'index, du majeur et de l'annulaire (D2, D3, D4) et déformation en col de cygne des doigts. Le reste de l'examen est dans les limites de la normale.

111. Quels diagnostics pouvez-vous évoquer devant ce tableau clinique ?(Cochez la réponse juste)

1. Maladie rhumatismale
2. Rhumatisme articulaire aigu
3. Ostéoporose
4. Polyarthrite rhumatoïde
5. Arthrose isolée

A : 1+2+3 B : 2+3 C : 1+3+4 D : 2+4+5 E: 3+5

112. Qu'attendez-vous de visualiser sur la radiographie standard des mains ? *(Cochez la réponse juste)**

1. Érosions osseuses floues
2. Luxations
3. Pincements articulaires
4. Liseré calcique
5. Géodes

A : 1+2+3 B : 2+5 C : 1+3+4 D : 2+3+5 E : 3+5

113. Quels autres examens complémentaires allez-vous demander ? *(Cochez la réponse juste)***

1. Dosage d'anticorps anti-peptides citrullinés
2. Densité minérale osseuse (DMO)
3. Échographie des mains
4. Dosage des facteurs rhumatoïdes (Waaler rose, réaction au latex)
5. Scanner thoraco-abdominal

A : 1+2+3 B : 2+5 C : 1+3+4 D : 2+4+5 E : 3+5

Les résultats des examens pratiqués sont les suivants :

*** Dosage d'anticorps anti-peptides citrullinés : fortement positifs**
*** Densité minérale osseuse (DMO) : ostéopénie**
*** Échographie des mains : hypertrophie inflammatoire de la membrane synoviale, et pincement articulaire avec des érosions**
*** Dosage des facteurs rhumatoïdes (Waaler rose, réaction au latex) : positif au 160e**
*** Scanner thoraco-abdominal : dans la limite de la normale**

Après avoir posé le diagnostic, la patiente a été mise sous traitement par son rhumatologue.

Elle reconsulte 03 ans après, pour une dyspnée d'effort stade 1 mMRC avec une toux sèche évoluant depuis 06 mois.

_L'examen clinique retrouve une patiente en état général moyen, asthénique, avec une température à 37.2°C, une fréquence respiratoire à 24 cycles/min, une SPO2 à 94%, une TA : 110/70 et un poids de 48 kg pour une taille de 1.54 m.

L'examen pleuro-pulmonaire retrouve des crépitants, type velcro, aux deux bases des deux champs pulmonaires.

La radiographie du thorax montre des opacités réticulo-micronodulaires aux deux bases pulmonaires.

La NFS : GB : 9000 éléments/mm³ (82-1-11-1-0), l'Hb est à 14 g/dL, Taux de plaquettes à 320000 éléments/mm³

114. Les râles crépitants sont caractérisés par :(Cochez la réponse juste)*

1. Émis à la fin de l'expiration
2. Émis à la fin de l'inspiration
3. Atténués lors de la toux
4. Inconstants et variables d'un examen à l'autre
5. Non influencés par la toux

A : 1+3+4 B : 2+3+4 C: 1+3+5 D : 1+4+5 E : 2+4+5

115. Quels diagnostics évoquez-vous en premier lieu ? *(Cochez la réponse juste)***
A. Insuffisance cardiaque hypoxémiante
B. Pneumonie bactérienne hypoxémiante
C. Fibrose pulmonaire
D. Tuberculose
E. Métastases pulmonaires

116:Quels sont les éléments à préciser à l'interrogatoire pour orienter le diagnostic ? *(Cochez la réponse juste)*
A. Prise de méthotrexate
B.Orthopnée
C. Antécédent de COVID-19
D. Exposition aux oiseaux
E. Toutes les réponses sont justes

117: Aucun élément suspect n'est retrouvé à l'interrogatoire. Quels examens complémentaires demander ? *(Cochez la réponse juste)*
1. Dosage de l'enzyme de conversion de l'angiotensine
2. TDM thoracique haute résolution
3. Électrocardiogramme
4. Échocardiographie transthoracique
5. ECBC des crachats
A : 1+2
B : 2+4+3+4+4
C : 4+4+5
D : 3+4+4+4+5
E : 2+4+5

Résultats des examens complémentaires :
- TDM thoracique : Réticulations, lésions sous-pleurales basales, aspect en rayon de miel.**
- ECG : Rythme sinusal normal, axe QRS normal.**
- Enzyme de conversion : 15 U/L.**
- Échocardiographie : Cavités cardiaques normales, FEVG à 70%, PAP à 23 mmHg.**
- ECBC : Absence de flore microbienne.**

118: Quels outils utiliser pour évaluer et suivre l'atteinte respiratoire ? *(Cochez la réponse juste)*
1. Échelle de dyspnée (mMRC)
2. Spirométrie
3. TDM thoracique
4. Polygraphie ventilatoire
5. Gazométrie artérielle
A : 1+2+3 B :1+2+3+4 C : 2+4+3+4+4 D :2+4+3+4+4+5 E : 1+2+3+5

119: La patiente présente une dyspnée stade 1 (mMRC) sans autre anomalie. Quelles mesures non pharmacologiques sont indispensables ? *(Cochez la réponse juste)*
1. Ergothérapie
2. Oxygénothérapie au long cours
3. Psychothérapie
4. Ventilation non invasive
5. Prise en charge nutritionnelle
A : 1+2+3 B : 2+4+3+4+4 C : 3+4+4+4+5 D : 1+3+5 E :1+4+5

120: La patiente consulte à nouveau avec une dyspnée stade 3 (mMRC). Quelle est l'hypothèse diagnostique la plus probable ? *(Cochez la réponse juste)*
1. Apnée du sommeil
2. Infection bactérienne
3. Insuffisance ventriculaire gauche
4. Cancer broncho-pulmonaire
5. Hypertension artérielle pulmonaire
A : 1+2+3 B : 3+4+4+4+5 C : 2+4+3+4+5 D : 1+3+5 E : 2+4+3+4+4

Cas clinique n°01 :

Moussa, un garçon de 6 ans en bonne santé jusqu'à présent, est admis à l'hôpital pour une fièvre persistante évoluant depuis 3 semaines. Il présente une toux sèche diurne et nocturne associée à une fièvre oscillant entre 38°C le matin et 39°C le soir, sans amélioration malgré un traitement antibiotique à base d'amoxicilline (1 g matin et soir pendant 15 jours).

Le carnet de santé indique que les vaccins sont à jour, mais la cicatrice du BCG est absente. À l'examen clinique :

- Poids : 20 kg
- Température : 39°C
- État général altéré
- Polypnée à 60 cycles/min avec léger tirage
- Auscultation pulmonaire sans anomalies
- Examen cardiovasculaire, abdominal, neurologique et ORL normaux
- Absence d'adénopathies périphériques

La radiographie thoracique révèle des opacités micronodulaires régulières, peu denses, bilatérales et symétriques, touchant aussi bien les sommets que les bases pulmonaires. Aucune adénopathie médiastinale, image excavée, bulle ou épanchement pleural n'est observé.

121 : Ce tableau radio-clinique peut évoquer (Cochez la réponse fausse)

A. Une tuberculose pulmonaire
B. Une histiocytose pulmonaire
C. Une maladie de Hodgkin
D. Une hémosidérose pulmonaire
E. Une staphylococcie pleuro-pulmonaire

122 : En plus des données cliniques et radiologiques, quel élément anamnestique est nécessaire pour orienter le diagnostic ? (Cochez la réponse juste)

A. Antécédents personnels d'anémie non explorée
B. Une prise médicamenteuse
C. Notion d'hémoptysie
D. Rechercher une notion d'infection cutanée dans les jours précédents
E. Rechercher un contact étroit avec une personne atteinte de tuberculose contagieuse

123 : Les examens paracliniques montrent :

- GB : 9200 (25-01-01-70-03)
- Hb : 11 g/dl, VGM : 82 μ^2, CCMH : 31 %
- Plaquettes : 159 000/mm^3
- Frottis sanguin : absence de cellules malignes
- VS : 60 mm à la 1ère heure
- CRP : 30 mg/l
- IDR à la tuberculine : 20 mm

Quels autres examens paracliniques vous semblent indispensables ? (Cochez la réponse juste)

A. Tubages gastriques pour examen direct et culture en milieux spécifiques
B. Hémocultures
C. TDM thoracique
D. Recherche de cellules malignes dans le liquide broncho-alvéolaire par endoscopie bronchique
E. Recherche de sidérophages par tubage gastrique

124 : Le traitement que vous envisagez comportera : (Cochez la réponse juste)

A. Oxacilline 200 mg/kg/j en 4 prises IV + Gentamycine 3 mg/kg/j
B. Adresser l'enfant pour chimiothérapie
C. Une corticothérapie à 1 mg/kg/j pendant 15 jours puis décroissance
D. 2 mois ERIJZ / 4 mois RH
E. 2 mois ERIJZ / 4 mois RH + prednisone 40 mg/j

125 : Au 2ème jour de traitement, Moussa présente un rash cutané isolé non prurigineux, sans gêne respiratoire, avec des urines rouges. La FNS est normale, le labstix est négatif. Quelle sera votre attitude ? (Cochez la réponse juste)

A. Arrêter l'oxacilline et prendre le relais par le céfotaxime
B. Arrêter tout traitement et prendre un avis spécialisé
C. Arrêter SRIJZ/RH, donner de la dexaméthasone puis reprendre à doses très progressives
D. Arrêter ERIJZ/RH, donner de la dexaméthasone puis reprendre à doses très progressives
E. Ne pas modifier le traitement initial

Cas clinique n°02 :

Abdelhakim, un garçon de 6 ans, consulte en urgence pour des douleurs intenses de l'extrémité inférieure du fémur droit, apparues depuis 8 heures, suite à une contusion minime.

Examen clinique :

- Fièvre à 39°C
- Tachycardie
- Douleur métaphysaire inférieure du fémur droit, circonférentielle, exacerbée à la palpation
- Mobilité douce du genou conservée
- Ongle incarné infecté du gros orteil gauche

Examens complémentaires :

- Radiographie du genou (face et profil) : normale
- NFS : 15 000 GB (80 % neutrophiles)
- VS : 60/80
- CRP élevée

126. Quel est votre diagnostic ?(Cochez la réponse juste)

A. Ostéomyélite aiguë
B. Rhumatisme articulaire aigu
C. Décollement épiphysaire
D. Arthrite septique du genou
E. Hémarthrose

127. Quel examen vous semble nécessaire en urgence ?(Cochez la réponse juste)

A. Hémocultures et prélèvement bactériologique au niveau du gros orteil
B. Scintigraphie
C. Ponction articulaire
D. Examen tomodensitométrique
E. Arthroscopie

128. Quel traitement préconisez-vous une fois Abdelhakim hospitalisé ?(Cochez la réponse juste)

A. Anti-inflammatoires non stéroïdiens en attendant les résultats
B. Antibiothérapie orale antistaphylococcique
C. Abord chirurgical et trépanation osseuse
D. Antibiothérapie parentérale et immobilisation plâtrée
E. Ponction articulaire

129. Sur quel élément se baser pour surveiller l'efficacité du traitement ?(Cochez la réponse juste)

A. Scintigraphies répétées
B. Scanner
C. Radiographie bi-hebdomadaire
D. Fièvre et syndrome inflammatoire biologique
E. Taux des antistaphylolysines

130. En cas d'évolution favorable, combien de temps sera maintenu le traitement ? *(Cochez la réponse juste)***

A. Jusqu'à l'apyrexie
B. Jusqu'à normalisation de la CRP
C. Six semaines
D. Jusqu'à normalisation des images radiologiques
E. Six mois

Cas clinique n°03 :

Mme Habiba, 39 ans, est amenée en consultation par son mari en raison de difficultés à quitter son domicile. Elle gère normalement les tâches ménagères mais éprouve une peur intense à l'idée de sortir seule. Elle accepte de se déplacer dans son quartier uniquement si elle est accompagnée de sa fille de 12 ans, mais reste limitée au trottoir autour de son immeuble, refusant de traverser la rue. Elle ne peut se rendre plus loin qu'en voiture avec son mari. Interrogée sur ses craintes, elle explique : *"C'est dangereux avec toutes ces voitures... Je sais que je suis peureuse... Ça m'angoisse trop... Je pourrais avoir un malaise et personne ne me porterait secours...".

131. Parmi les symptômes suivants, quel est celui que présente cette patiente ? *(Cochez la réponse juste)**

A. Phobie
B. Obsession-impulsion
C. Obsession phobique
D. Compulsion
E. Délire

132. Comment désigne-t-on la nécessité, pour elle, de sortir accompagnée ? *(Cochez la réponse juste)***

A. Comportement de dépendance
B. Moyen contraphobique
C. Mécanisme fusionnel
D. Comportement de manipulation
E. Agoraphobie

133. Parmi les diagnostics suivants, quel est celui qui peut être envisagé dans ce cas ? *(Cochez la réponse juste)***

A. Trouble obsessionnel
B. Déséquilibre psychique
C. Trouble phobique
D. Délire d'interprétation
E. Trouble anxieux

134. Cet état peut se compliquer de :(Cochez la réponse juste)*

A. D'une psychose paranoïaque
B. D'un état dépressif
C. D'un état démentiel
D. D'une anorexie mentale
E. D'un trouble conversif

135. Parmi les traitements suivants, indiquez celui qui est justifié dans un tel cas : *(Cochez la réponse juste)***

A. Isolement du milieu familial
B. Neuroleptiques
C. Antidépresseurs
D. Lithium
E. Electroconvulsivothérapie

Cas clinique n°04 :

Une femme de 40 ans consulte en urgence pour :

- Épistaxis et gingivorragies spontanées
- Ménorragies (en dehors de toute prise médicamenteuse)

Examen clinique :

- État général : apyrétique, TA 11/6 mmHg
- Signes hémorragiques :
  - Pétéchies diffuses
  - Ecchymoses
  - Bulles hémorragiques buccales
- Absence d'adénopathies ou splénomégalie

136. Quel diagnostic évoquez-vous en priorité ?(Cochez la réponse juste)
A. Maladie de Willebrand
B. Leucémie aiguë
C. Purpura thrombopénique immunologique (PTI)
D. Thrombasthénie de Glanzmann
E. Coagulation intravasculaire disséminée (CIVD)
Examens biologiques (hémogramme) :
- Hb : 9 g/dL (anémie)
- Plaquettes : 5 000/µL (thrombopénie sévère)
- GB : 9 000/µL (formule normale)
- Réticulocytes : 10% (régénération médullaire)
- TP : 75% ; TCK : 49 sec (témoin 40 sec) ; fibrinogène : 2.5 g/L
137. Interprétation des résultats biologiques :(Cochez la réponse juste)
1. Anémie régénérative et thrombopénie sévère
2. Hyperleucocytose et anémie régénérative
3. Anémie arégénérative et thrombopénie modérée
4. TCK allongé et TP normal, fibrinogène normal
5. TCK normal, TP normal, fibrinogène normal
A : 1+2 B : 1+3 C : 3+5 D : 1+5 E : 2+4
138. Parmi ces complications, laquelle est improbable dans ce cas ? *(Cochez la réponse juste)***
A. Hémorragie rétinienne
B. Hémorragies cérébro-méningées
C. Hémorragie digestive
D. Hémarthroses
E. Hématurie
Dossier clinique n°6 :
- Femme de 70 ans
- Antécédents : Diabète, hypertension artérielle, accident vasculaire cérébral non documenté
- Motif de consultation : Douleur thoracique constrictive évoluant depuis 3 heures
Examen clinique :
- État général : Pâleur, œdèmes bilatéraux des membres inférieurs
- Cardiovasculaire :
- Rythme cardiaque rapide et régulier
- Pression artérielle : 170/60 mmHg aux deux bras
- Auscultation cardiaque et pulmonaire normale
- Électrocardiogramme (18 dérivations) :
- Rythme sinusal à 90 bpm
- Intervalle PR allongé (220 ms)
- Sus-décalage du segment ST (4 mm) dans les dérivations V1 à V6, D1 et aVL
146 : Diagnostic ECG:
Indiquez l'association juste parmi les propositions suivantes :
1. Syndrome coronarien aigu sans sus-décalage du segment ST
2. Syndrome coronarien aigu avec sus-décalage du segment ST
3. Trouble de la repolarisation dans le territoire inférieur
4. Bloc auriculo-ventriculaire de 2ème degré type Mobitz 1
5. Trouble de la repolarisation dans le territoire antérieur étendu
A : 1+4 B : 2 C : 1+2+3 D : 2+5 E : 1+5
147 :Quelle est l'association juste :
1. Thrombolyse si angioplastie primaire impossible dans les délais
2. Angioplastie primaire indépendamment des délais
3. Seulement DAPT + héparine
4. DAPT + héparine dès diagnostic posé
5. Pas de contre-indication absolue à la thrombolyse
A : 1+24 B : 2+4 C : 3 D : 1+4+5 E : 1+5

148 :Indiquez l'association juste :
1. Risque accru d'insuffisance cardiaque aiguë
2. Rythme idioventriculaire accéléré comme complication du traitement
3. Réduction du sus-décalage ST ≥2 mm = succès
4. Risque de troubles du rythme ventriculaires
5. Coronarographie obligatoire dans 24h (même pour NSTEMI haut risque)
A : 1+2 B : 1+3+4 C : 1+2+5 D : 1+2+4 E : 5
149 : Complications secondaires:
Après traitement, la patiente présente :
- Retard idéomoteur
- Œdèmes persistants
- Échocardiographie : hypokinésie antérieure, pression PAP 35 mmHg, lame péricardique
- Biologie : Hb 8 g/dL, CRP 30 mg/L, clairance 28 mL/min, TSH 12 mUI/L
Indiquez l'association juste :
1. TSH élevée explique péricardite + œdèmes
2. Transfusion nécessaire
3. Péricardite = syndrome de Dressler
4. Anémie liée à l'insuffisance rénale
5. Hémodialyse urgente
A : 1+4+5 B : 2+3+4 C : 2+4+5 D : 1+4 E : 2+5
150 : Traitement au long cours
Quels traitements administrer ?
1. Aspirine (vie) + clopidogrel (6-12 mois)
2. Statine (12 mois)
3. IEC + bêta-bloquant
4. Carbimazole
5. Réhydratation prudente
A : 1+3+5 B : 2+3+4+5 C : 1+2+5 D : 1+2+3+4+5 E : 2+4+5

Université Saad Dahlab Blida

Faculté de Médecine

Concours de Résidanat Session Octobre 2023

Note d'information

-Ce questionnaire comporte 120 QCM dont les pages sont numérotées de 1 a 22

-les QCM sont réparties de la maniéré suivante.

-les QCM comportent chacune cinq propositions de A a E.

-les candidat soit cocher sur le grille de réponses uniquement une proposition (réponse juste RJ ou réponse fausse –RF)

Epreuve fondamentale

1: Relation Pression/volume Pulmonaire ; (Cochez la réponse juste)

A) Le volume d'une Structure élastique ne dépend pas de là pression transmurale

B) Le volume de relaxation du Poumon est nul

C) La compliance est la capacité du poumon à faire varier son volume, en fonction de la variation de la pression transmurale pulmonaire

D) La Compliance a une Valeur constante qui n'évolue pas avec la pression

E)Une compliance nulle = distensibilité infinie

2- Une P_{50} diminuée : (Cochez la réponse juste)

A) Accompagne une hyperthermie

B) Est associée à l'excès de 2,3 diphosphoglycérate

C) Est observée en cas d'alcalose

D) Traduit une affinité hémoglobine-02 abaissée

E) Survient quand la PCO2 est augmentée

3- Les réserves de CO2 sont de l'ordre de 120 l au niveau : (Cochez la réponse juste)

A) Du poumon

B) Des tissus

C) Du sang

D) Des os

E) De la myoglobine

4- Le débit ventilatoire est, chez l'adulte, au repos de : {Cochez la réponse juste)

A) 0,25 litre/min

B) 0,5 litre/min

C) 8 litre/min

D) 16 litre/min

E) 26 litre/min

5- La durée d'un cycle respiratoire chez le nouveau-né, au repos, est de : (Cochez la réponse juste)

A) 1 minute

B) 20 secondes

C) 10 secondes

D) 4-5 secondes

E) 1-1,5 seconde

6- **La quantité de sodium excrété par le rein, par rapport a la quantité filtre dans les conditions normales ; de l'ordre de (RJ)**

A) 6.5%

B) 26%

C) 6 a 8%

D) 2%

E) 0.1 a 1%

7- au sommet du poumon : (Cochez la réponse juste)

A) Les alvéoles sont distendues

B) La pression pleurale est moins négative qu'au niveau des bases

C) la perfusion est meilleure qu'au niveau des bases

D) la ventilation est moins bonne que la perfusion

E) La ventilation est meilleure qu'au niveau des bases

8- la créatinine : (Cochez la réponse fausse)

A) Est un déchet métabolique

B) sa production et sa concentration plasmatique sont stables d'un jour à l'autre

C) dépend de la masse musculaire

D) Est librement filtrée

E) Est légèrement réabsorbée

copyval

9. En cas d' augmentation de la pression artérielle, tous les mécanismes suivants sont observés, sauf un, lequel ? (Cochez la réponse fausse)

A) L'étirement de la paroi des artérioles afférentes
B) La sortie de calcium
C) Une constriction du muscle lisse vasculaire
D) Une baisse du débit sanguin rénal
E) Une baisse du débit de filtration glomérulaire

10- Le facteur natriurétique auriculaire : (Cochez la réponse juste)

A) Diminue la pression de filtration glomérulaire
B) Stimule la sécrétion de rénine
C) S'oppose aux effets vasoconstricteurs de l'angiotensine II
D) Augmente le débit sanguin rénal
E) Exerce un effet de vasoconstriction de l'artériole afférente

11- Une des catégories de produits suivants subit une réabsorption au niveau du tube contourné proximal: (Cochez la réponse Juste)

A) Les oxalates
B) Les salicylates
C) Les bicarbonates
D) L'adrénaline
E) L'ion H'

12- Concernant les sélectines : (Cochez la réponse fausse)

1) Durant l'inflammation les E sélectines jouent un rôle important dans le recrutement des leucocytes au niveau du site inflammatoire
2) Les P-sélectines sont exprimées à la surface des cellules endothéliales après induction par des allo-anticorps
3) Les L-sélectines sont exprimées d'une manière constitutive a la surface des leucocytes
4) Les sélectines sont des hétérodimères intra-cytoplasmique composes de 2 chaines α et β liées de façon covalente
5) Les sélectines non aucun rôle dans le homing lymphocytaire

A: 2+4+5 B: 2+5 C: 3+4+5 D: 2+3+4 E: 1+4+5

13- Concernant les cytokines pro-inflammatoires : (Cochez la réponse fausse)

1) Ont une action pléotropique agissant sur plusieurs cibles cellulaires
2) Induisent la synthèse des protéines de l'inflammation
3) Les principales cytokines pro-inflammatoires sont : IL2, IL6, INF-y et IL10
4) Entrainent une augmentation de la perméabilité vasculaire et une augmentation de l'expression des molécules d'adhésions par les cellules endothéliales
5) Inhibent la migration des macrophages et des Polynucléaires neutrophiles ce qui favorise l'élimination de l'agent agresseur

A: 3+4+5 B: 3+5 C: 2+4+5 D: 1+3 E: 1+3+5

14-Les cytokines : (Cochez réponse fausse)la

1) Sont des glycoprotéines de faible poids moléculaire
2) Interagissent avec des récepteurs spécifiques au niveau du noyau des cellules immunitaires
3) Peuvent être régulées par des antagonistes compétitifs
4) Sont synthétisées par les cellules Immunitaires même au repos
5) Peuvent agir en synergie pour réaliser Une activité biologique donnée (effet de redondance)

A: 3+4 B: 2+3+5 C: 2+4 D:1+2+5 E: 1+2+4

15- la thymus est un organe lymphoïde : (Cochez la réponse fausse)

1) primaire
2) centrale
3) nécessaire a la maturation des lymphocytes B folliculaires et les lymphocytes NK
4) libère dans le sang circulant des lymphocytes T mature naïfs double positif exprimant les molécules CD4 et CD8
5) constituant un passage oblige des cellules LT aux différents stades de maturation

A: 4 B: 3+4+5 C: 2+4 D:3+4 E: 1+3+4+5

16- l'idiotype est : (Cochez la réponse Juste)

1)définie par un ensemble d'épitopes portés par la partie Fc d'une molécule d'Ig

2) identique chez tous les individus d'une même espèce

3) Le résultat d'une combinaison donnée de gènes codant pour les pariées variable des chaines lourdes et légères des immunoglobulines

4) partagée Par les immunoglobulines d'une même classe chez un individu.

5) partagée Par les molécules de la superfamille des immunoglobulines

A: 1+4 B: 2+3+4 C: 2+3+4+5 D:3 E:1+3

17-Les régions constantes des chaînes H portent des structures conservées qui assurent diverses fonctions : (Cochez la réponse juste)

1) L'adhérence aux antigènes HLA.

2)Le transfert placentaire

3) La fixation et l'activation du complément par voie classique.

4) Le phénomène d'ADCC pour les cellules NK.

5) La fixation spécifique aux épitopes

A: 1+2+3 B: 2+3+5 C: 2+3+4+5 D: 1+2+3+4 E: 2+3+4

18-Le paratope : (Cochez la réponse fausse)

1) Est le site de reconnaissance de l'antigène

2) Est constitué des domaines variables des chaines lourdes des immunoglobulines

3) Est le site de liaison spécifique au C1q du complément

4) Exprime des déterminants idiotypiques

5) N'est pas impliqué dans le passage trans-placentaire des immunoglobulines

A: 2+3 B: 2+3+4 c:2+5 D: 3+4 E: 1+3+4+5

19- Les œdèmes lésionnels : (Cochez la RF)

A) Sont riches en protéines plasmatiques

B) Sont dus à une augmentation de la perméabilité endothéliale

C) Sont la conséquence d'une augmentation de la pression hydrostatique

D) Surviennent dans la phase algue de l'Inflammation

E) S'accompagnent d'une congestion active

20- Tous ces facteurs favorisent la survenue d'une thrombose sauf un lequel ?

A) L'exercice physique excessif

B) La compression vasculaire

C) Les artérites

D) Les coagulopathies

E) L'athérosclérose

21- Les infarctus rouges : (Cochez la réponse fausse)

A) S'observent dans le rein

B) Sont dus à une oblitération artérielle

C) Sont infiltrés de sang

D) Ne peuvent être distingués macroscopiquement et microscopique d'un infarcissement

E) S'observent dans le poumon

22- Les cellules épithélloïdes : (Cochez la réponse fausse)

A) Ressemblent aux cellules épithéliales

B) Sont des cellules d'origine histiocytaire

C) Sont des cellules très activées

D) Ont une activité sécrétoire importante

E) Ont une activité phagocytaire élevée

23- Concernant le granulome a corps étrangers : (Cochez la réponse fausse)

A) Il est extrêmement fréquent

B) il n'a pas de disposition particulière en follicule

C)le corps étranger peut être endogène ou exogène

D) il est plus riche en cellule épithélloïdes qu'en cellules géantes

E)il peut donnée naissances a des pseudotumeurs

24- concernant les lésions cellulaires élémentaires : (Cochez là réponse fausse)

A)peut trouve une atrophie physiologique cellulaire dans la maladie d'Alzheimer
B) les RGO peuvent être source de métaplasie cellulaire
C) l'hypertrophie musculaire est physiologique chez les grands sportif
D) un excès hormonal peut provoquer une hyperplasie cellulaire
E) un excès hormonal peut être responsable de lésions de dystrophie

25- parmi les affirmations suivantes concernant l'étude Immun histochimique : (Cochez là réponse fausse)

A)est basée sur une réaction antigène-anticorps
B) elle permet l'identification et la localisation de protéines
C) peut permettre d'identifier une cible thérapeutique
D) elle peut mettre EN évidence des séquences connues d'ADN ou d'ARN
E) peut mettre en évidence un virus

26- concernant ces complications, laquelle n'est pas due à l'athérosclérose ?

A) perte d'élasticité de la paroi artérielle
B) embolie pulmonaire
C) la formation d'anévrismes
D) sténose de la lumière artérielle
E) obstruction thrombotique de l'artère

27- Cochez la réponse juste :

1) Au niveau de l'ampoule rectale, les valvules de Houston sont des plis transversaux
2) Le rectum fait suite au sigmoïde au niveau de S1
3) La partie pelvienne du rectum est oblique en bas et en avant
4) Le rectum est situé en avant de L4, LS et le sacrum
5) Colonnes anales de Morgani sailies verticales situées au niveau du canal anal

A :1+2+3 B:2+3+5 C:1+4+5 D:3+45 E:1+3+5

28- Cochez la réponse Juste

1) La glande thyroïde est une glande Impaire mixte
2) Le fascia thyroïdien est une dépendance de la gaine viscérale du cou
3) Le lobe thyroïdien est fixé à la trachée par le ligament médian de Gruber
4) La glande thyroïde est plus développée chez l'homme que chez la femme
5) La glande thyroïde est innervée par les nerfs vague

A:2+5 B:4+5 C:3+5 D:1+4 E: 3+4

29- Cochez la réponse juste

1) Les vaisseaux iliaques internes représentent les rapports latéraux du rectum pelvien
2) L'espace retro-rectal contenant les vaisseaux sacres moyens ;sympathique sacres et les uretères
3) La séreuse péritonéale, recouvre seulement là partie supérieure des faces
Antérieure et postérieures du rectum
4) Le coccyx est le rapport postérieur du rectum
5) Par l'intermédiaire du sphincter externe, le canal est en rapport en avant avec l'urètre chez l'homme

A:1+3+4 B:1+3+5 C:2+3+5 D:1+4+5 E: 2+4+5

30- Cochez la réponse Juste

A) La glande thyroïde répond à l'aponévrose cervicale moyen engainant le muscle sterno thyroïdien
B) La pyramide de L'alouette est un prolongement émis du lobe thyroïdien
C) L'isthme répond aux veines thyroïdiennes antérieures en haut
D) La face médiale du lobe thyroïdien répond au nerf vague
E) La glande thyroïde est de surface lisse

31- Cochez la réponse juste

1) Les artères rectales supérieures, sont des branches terminales de l'artère mésentérique inférieure
2) Les pédicules lymphatiques rectaux inférieurs se drainent dans les nœuds hypogastriques
3) Les veines rectales supérieures sont tributaires du système cave inferieur
4) Les pédicules lymphatiques rectaux supérieurs, se drainent dans les nœuds de la chaine mésentérique inférieure
5) Les artères rectales supérieures assurent la quasi-totalité de la l'ampoule rectale

A : 1+2+4 B : 3+4+5 C:1+4+5 D : 1+2+3 E : 2+4+5

Copy Val

32- Cochez la réponse juste

A) La veine thyroïdienne supérieure se Jette dans le tronc thyro-linguo-facial.

B) L'artère thyroïdienne moyenne se termine par trois branches.

C) L'artère thyroïdienne inférieure nait de la carotide externe.

D) Les veines thyroïdiennes antérieures se Jettent dans la veine Jugulaire interne

E) Les lymphatiques se drainent latéralement dans les lymphonoeuds pré laryngés.

33- au cour de l'amœbose maladie :(Cochez ta réponse juste)

A) Amoebose hépatique est due a l'entamoebahistolytica type minuta , ce traduit sue le plan clinique par une hépatomégalie douloureuse et fébrile

B) Amoebose hépatique est une forme clinique extra intestinal dont le diagnostic est essentiellement coproparasitologique

C) Amoebose intestinal aigu est une forme clinique intestinale dont le diagnostique assure essentiellement par la recherche d'anticorps spécifique dans le sérum

D) Amoebose intestinal aigu Amœbose intestinale aiguë due à Entamæbahistolytica type histohytice, se traduit sur le plan clinique par un syndrome dysentérique associant :des epreintes ,des tenesmes et des crachats rectaux glairo-sanglants

E) le traitement fait appel uniquement aux antiamibiens de contact

34-la conduite à tenir chez une femme enceinte non immunisée pour la toxoplasmose consiste a : (Cochez la réponse juste)

1)un dernier contrôle sérologique négatif le jour de l'accouchement permet d'écarter le risque de toxoplasmose congénitale pour l'enfant.

2) Mettre des gants pour jardiner et bien se laver les mains ensuite.

3) prescrire UNE surveillance sérologique mensuelle pendant toute la durée de la grossesse

4) Ne pas consommer de crudités crus mal lavées ou de la viande saignante insuffisamment cuite.

5)Eviter tout contact direct avec un chat parasité car il constitue un facteur de risque principal d'acquisition de la toxoplasmose.

A: 1+2+3 B:2+3+4 C:3+4+5 D: 1+2+4 E:2+3+5

35- Chez les femmes enceintes qui s'infectent par Toxoplasmagondii pendant la grossesse, laquelle de ces propositions suivantes est inexacte : (Cochez la réponse fausse)

A) La toxoplasmose congénitale est grave en cas de contamination maternelle en début de grossesse

B) Le risque de passage du parasite au fœtus est minimum en début de grossesse

C) La gravité de l'atteinte fœtale augmente avec l'âge de la grossesse

D) Le risque de passage du parasite au fœtus augmente avec l'âge de la grossesse

E) En cas de contamination maternelle tardive survenue au cours du troisième trimestre de la grossesse, la toxoplasmose congénitale est le plus souvent asymptomatique (infra clinique, latente)

36- La reprise évolutive (réactivation) d'une toxoplasmose latente peut se voir en cas: (Cochez la réponse Juste)

A) D'une greffe de moelle osseuse à un receveur séropositif Pour la toxoplasmose en pré greffe

B) D'un simple contact des mains avec de la viande crue Parasitée

C) D'un contact avec la litière d'un chat parasité

D) D'une hygiène insuffisante des mains après un contact avec du sol contenant des Oocystes sporulés

E) D'une transplantation cardiaque provenant d'un donneur séropositif pour la toxoplasmose à un receveur séronégatif pour la toxoplasmose en pré greffe

37- Un accès palustre survenu chez un voyageur non immunisé ayant séjourné en zone d'endémie palustre, est évoqué devant toutes ces situations suivants sauf une, laquelle .

A) Une fièvre au retour de zone d'endémie palustre

B) Une Chimioprophylaxie antipaludique non adaptée au pays visite

C) Une adénopathie

D) La non prise de Chimioprophylaxie antipaludique

E) Une thrombopénie précoce

38- À propos des cestodes parasites de l'homme, laquelle de ces propositions suivantes est inexacte : (Cochez la réponse fausse)

A) Tænia saginata est un ver nu responsable de téniasis et/ou de cysticercose

B) Tænia solium est un ver armé qui peut être responsable de téniasis et/ou de cysticercose

C) Tænia saginata est responsable d' une cestodose intestinale dont le diagnostic est assuré essentiellement par un scotch test anal « test de Graham » qui met en évidence des embryophores caractéristiques au niveau de la marge anale

D) Tænia saginata est un ver solitaire dont la larve est« Cysticercusbovis »

E) Les anneaux gravides sont illimines passivement au moment de la defecation pour taenia soliumet activement en dehors de la defecation pour taenia saginata

39- une femme obese de 54ans avec un diabète type 1 ce présent au consultation avec une glycémie a 5.8g /l ; puis est hospitalisée , le lendemain un prélèvement sanguin est réalisé a jeun , le sérum est fortement lactescent ; l'enchantellent a été conserve au frais pendent tout la nuit ; il présent un surnagent crémeux la partie inferieur demeure trouble, Cet aspect du sérum serait-t-il évocateur de :(RJ)

A) Hypercholestérolémie familiale

B) Hypertriglycéridémie Majeure Type V

C) Hypertriglycéridémie Majeure Type IV

D) Dyslipidémie mixte Type III

E) Dyslipidémie mixte II-b

40- suite a une intervention chirurgical un patient a eu une complication présente par une accumulation d'un liquide d'épanchement au niveau du péritoine due a une rupture du canal lymphatique mésentérique ce liquide sera-t-il : (RJ)

A)riche en low density lipoproteins

B) riche en enzyme pancréatique

C)riche en chylomicron

D)pauvre en triglycéride

E) riche en acide lactique

41-parmi les suivants concernant le peptide C quel est la fausse affirmations

A) La production endogène de peptide C est équimolaire a la sécrétion insulinique

B) Dans le diabète insulinodépendant son taux urinaire est fortement abaisse

C) Le peptide c est constitutif de la pro insuline et de la pré pro insuline

D) Son dosage sanguin n'est pas affecte par l'administration d'insuline exogène

E) Son taux sanguin est abaisse en cas d'insuffisance rénale

42- quel signe clinique ou biologique ne peut pas être associe a une cholestase

A) Steatorrhee

B) Présence dune lipoprotéine a au lipidograme

C) Selles décoloré

D) Prurits

E) Elévation de taux sanguin de sels biliaires

43-Parmis les propositions suivants concernant le métabolisme des lipoprotéines lequel est exact

A) Apo lipoprotéine B48 est principalement synthétisé par le foie

B) ABC1 est une protéine de transport de TG

C) LPL est essentiellement localise dans le tissu hépatique

D) L'apolipoproteine C III est le principale activateur de la LPL

E) La LCAT a comme principale substrat le cholestérol des HDL

<u>44-45 illisible !</u>

46-Streptococcus pneumonie (cocher la réponse juste)

A.est un cocci a gram négatif.

B.peut étre responsable de pneumonie et d'otite

C.est bêta-hémolytique sur gélose au sang fails

D.est résistant a l'optochine

E.est une bactérie non exigeante.

47. Neisseriagonorrhae:RJ

A) est responsable de la blennorragie
B) Est une bactérie aeroanaërobie facultative AAF
C) Cultive sur milieu ordinaire
D) Est un bacille Gram positif
E) Est oxydase négative

48- Pseudomonas aeruginosa : (Cocher la réponse Juste)

A) Est un Cocci Gram positif
B) Est une bactérie pathogène spécifique
C) Est incapable de produire du biofilm
D) Est naturellement sensible à la vancomycine
E) Est souvent impliquée dans les Infections associées aux soins

49) Le choléra : (Cocher la réponse juste)

A) Est causé par une bactérie Gram positif microaérophile.
B) Est suspecté devant une diarrhée glairrosanglante.
C) Est une maladie à transmission hydrique engendrant une diarrhée aqueuse
D) Est causée par V.choleraë sérogroupe O4,
E) Touche uniquement l'enfant de moins de 2 ans.

50- Leglonellepneumophila: (Cochez la réponse Juste)

A) Est responsable de la fièvre de Pontiac
B) N'a pas la capacité de produire un blofllm
C) Est une bactérie microaérophile
D) Est l'agent de la tularémie
E) Est une bactérie non exigeante de culture aisée

Epreuve médico-chirurgicale

51- Devant un œil rouge, un des signes suivants n'est Pas en faveur du diagnostic de conjonctivite. Lequel ? (Cochez la réponse fausse)

A) Sécrétions
B) Larmoiement
C) Baisse d'acuité visuelle
D) Rougeur diffuse
E) Sensation de sable

52- Ces propositions concernent la cataracte : (Cochez la réponse juste)

1) La corticothérapie générale au long cours peut induire une cataracte
2) Une cataracte secondaire peut se développer en post opératoire
3) Un traumatisme oculaire peut se compliquer de cataracte
4) L'échographie en mode B est nécessaire en cas de cataracte blanche totale
5) L'échographie en mode A n'est pas nécessaire avant la chirurgie de la cataracte

A : 1+2+5 B : 2+3+4 C:1+2+3+4 D: 1+4+5 E:1+2+3

53- Le diagnostic de l'arrêt cardiocireulatoire doit se faire en : (Cochez la réponse juste)

A) 60 secondes
B) 30 secondes
C) Moins de 30 secondes
D) Plus de 30 secondes
E) 3 minutes

54- Le premier geste de réanimation à réaliser est ! (Cochet la réponse juste)

A) L'intubation nasotrachéale
B) La mise en place d'un cathéter central
C) La défibrillation précoce
D) La mise en place d'une sonde
E) L'injection intracardiaque d'adrénaline

Copy Wal

55- Dans la péritonite aigue, l'examen clinique peut retrouver une défense abdominale localisée ou généralisée correspondant à : (Cochez la réponse juste)

A) Une réaction abdominale à la douleur spontanée
B) Une réaction abdominale à la douleur provoquée
C) Une réaction permanente et involontaire
D) Une réaction permanente et volontaire
E) Une réaction éphémère et involontaire

56- La cholécystite aiguë : (Cochez la réponse fausse)

A) impose une intervention d'urgence
B) Est traitée par cathétérisme rétrograde de la papille
C) Est la cause de toutes les douleurs biliaires
D) Est généralement d'origine lithiasique
E) Provoque une défense de l'hypochondre droit

57- Quelles sont les séquences cliniques compatibles avec le diagnostic d''Hématome extra dural post traumatiques : (Cochez la réponse juste)

1) Perte brève de connaissance lors du traumatisme. Trois heures après apparition d'hémiplégie et coma
2) Coma d'emblée sans perte de connaissance.
3) Obnubilation durant quelques heures puis aggravation de l'état de conscience et hémiplégie,
4) Examen neurologique normal au moment du traumatisme puis apparition des troubles de la conscience deux heures plus tard.
5) Examen neurologique normal au moment du traumatisme puis apparition de crise bravais Jacksonienne droite quatre heures plus tard.

A : 1+2+5 B : 2+3+4 C:1+5 D : 1+3+4 E:1+2+3

58: Lors d'un traumatisme crânien quelles sont les situations qui justifient la réalisation d'un TDM cérébrale an urgence : (Cocher la RJ)

1) Sensation de vertige
2) Trouble de l'équilibre ot de la marche,
3) Perte de Connaissance Initiale
4) Coma avec signe de focalisation
S) Coma sans signe de focalisation.

A : 1+2+3 B : 2+3+4+5 C:3+4+5 D : 1+4 E:1+2+4

59- SI 400 nouveaux cas de maladie ont été recensés en deux ans parmi une population de 100 000 personnes, le taux d'incidence de la maladie est de : (Cochez la RJ)

A) 800 pour 100000 personnes année.
B) 400 pour 100000 personnes année,
C) 20 pour 100000 personnes année.
D) 200 pour 100 000 personnes années.
E) 2000 pour 100000 personnes années.

60- Si 300 cas d'une maladie M sont survenus en trois ans au sein d'une a
estimée à 3000000, le taux de densité d'incidence est : (Cochez la réponse Juste)

A) 330 pour 100000 personnes années.
B) 3300 pour 100000 personnes années.
C) 3.3 pour 100 000 personnes années.
D) 33 pour 100 000 personnes années.
E) 3.3 pour 100 0000 personnes années.

61- Quels signes clinico-biologiques sont évocateurs de néphrite Interstitielle chronique (Cochez la réponse juste)

1) Polyurie
2) Acidose tubulaire
3) Leucocyturie aseptique
4) Œdème des membres inferieurs
5) Hypo albuminémie

A:1+2+4 B : 2+4+5 C:2+3 D:1+2+3 E:1+5

62- parmi les proposions suivantes quels sont celles qui ne constituent pas des causes de néphropathies vasculaires aigus : (RJ)

A) Sténose de l'artère rénale
B) Nephroangeosclerose maligne
C) Syndrome des anti phospholipides
D) Péri entérite noueuse
E) Syndrome des micro angiopathie thrombotiques

63- les céphalées au cour de migraine sont (RF)

A) Pulsatile
B) Hémicrâniene
C) S'aggravent aves l'âge
D) Débutant dans enfance ou l'adolescence
E) Sont plus fréquent chez les femme

64- la SEP est caractérisé par (RF)

A) Un processus inflammatoire chronique touchant exclusivement le cerveau
B) Un processus inflammatoire chronique de cerveau et la moelle
C) Généralement un âge de début entre 20 ans et 40 ans
D) Une évolution par pousse et rémission
E) Des hyper signaux a IRM de l'encéphale disséminées dans la substance blanche

65- le diagnostique de hypertrophie bénigne de prostate repose sur l'interrogatoire qui recherchera les signes urinaires en rapport avec l'obstruction (RF)

A) Dysurie
B) Retard de démarrage
C) Jet en pomme dérisoire
D) Jet faible
E) Pollakiurie

66- le carcinome a cellule claire du rein (RF)

A) Est la tumeur maligne la plus fréquente de rien
B) Se présente comme une mass jaune bigarrée
C) Est compose exclusivement de cellule claire
D) Se grade avec le grade de furhman
E) Peut être bilatérale dans la maladie de von hippel lindeau

67- Parmi ces signes cliniques lequel inaugure la maladie dans le cancer du cœvum ?(RJ)

A) Dysphonie
B) Dyspnée
C) Adénopathie cervicale
D) Otalgie
E) Gingivorragie

68- Le diagnostic de certitude du cancer du pancréas est Posé Par lequel des marquer tumoraux suivants ?(Cocher la réponse juste)

A) CA 125
B) CA 15-3
C) CA 19-9
D) ACE
E) Aucune réponse juste

69- Le souffle de rétrécissement aortique est : (Cochez la réponse juste)

A) Rude râpeux, irradiant en écharpe, maximal au foyer aortique
B) En jet de vapeur, maximal au foyer aortique
C) Doux, humé, aspiratif, maximal au foyer aortique
D) Son intensité témoigne de sa sévérité
E) Le B2 aortique est aboli dans le rétrécissement aortique serré SOUS aortique

70- Le double souffle crural de Duroziez : (Cochez la réponse juste)

A) Est physiologique
B) Est retrouvé dans l'insuffisance mitrale modérée
C) Est retrouvée dans l'insuffisance aortique massive
D) Est un signe d'insuffisance ventriculaire gauche
E) Est un signe d'insuffisance cardiaque droite

71- Une imperforation hyménale chez une jeune fille peut se compliquer de ? (Cochez là réponse fausse)

A) Hématometrie
B) Hématocolpos
C) Hématosalpinx
D) Endométriose péritonéale
E) Hématome du ligament large

72)la cause la plus fréquente de la stérilité d'origine féminine est (RJ)

A) tubaire
B) Ovarienne
C) Pelvienne
D) Synéchie utérine
E) Psychogène

73-le syndrome de PEUTZ- JEGHERS est compose de (RJ)

A) Cirrhose +mélanodermie +diabète
B) Cirrhose +trouble neurologique
C) Pollypose colique +ostéome +alopécie
D) Pollypose colique+mélanose péri orificiel
E) Aucun de ces éléments

74- Parmi les causes d hyperkaliémie(RF)

A) Exercice physique Intense
B) iatrogènes
C) Rhabdomyolyse
D) Insuffisance rénale
E) Diarrhée et syndromes dysentérique

75. L'un de ces toniques peut être à l'origine de leucose professionnelle, lequel

A) Benzene
B) Arsenic
C) Cadmium
D) Organo phosphoré
E) Mercure

76- Parmi les examens complémentaires suivants, lequel est utilisé couramment pour la surveillance médicale des manipulateurs en Radiologie (RJ)

A) L'amylasèmie
B}Les transaminases
C)La glycémie
D) la numération et formule sanguine
E) le dosage de l'urée sanguine

77- Parmi les principes Généraux de la spondylarthrite laquelle est fausse

A) La spondyloarthrite est une maladie chronique potentiétiement sévère
B) L'objectif de la prise en Charge est d'améliorer la qualité de vie.de contrôle les symptômes et l'inflammation et de prévenir les dommages structuraux
C) L'objectif de la prise en charge devrait être la rémission clinique ou a défaut un faible niveau d'activité
D) L'évaluation et le suivi des spondyloarthrite par imagerie (IRM) sont recommandé
E) L'arrêt du tabac devrait être Proposé puisque son usage est associe a une activité et une sévérité plus marquée de la maladie

78- Dans les spondyloarthrite, parmi ces éléments, lequel n'est pas prédictif d'u évolution sévère de la maladie (Cochez la réponse juste)

A) Coxite
B) VS inférieure à 30 mm
C) Faible efficacité des AINS
D) Oligoarthrite
E) Début inférieur à 16 ans

79- Le segment mobile rachidien est constitué des éléments suivants sauf un, le quel ? (Cochez la réponse fausse)

A) Ligament jaune
B) Disque intervertébral
C) Ligament vertébral commun postérieur
D) Ligament supra-épineux
E) Apophyses articulaires postérieures

80- Un accidenté de la circulation présente une attitude vicieuse du membre inférieur en adduction, rotation interne, flexion évoque : (Cochez la réponse juste)

A) Luxation iliaque
B) Luxation pubienne
C) Luxation Ischiatique
D) Luxation obturatrice
E) Fracture de l'extrémité supérieure du fémur

81- La maladie de waldentrom se définit par (RJ)

1) Pic polyclonale en position gamma globuine
2) Pic monoclonal à IgG lambda
3) Une infiltration lymphoplasmocytaire au niveau de la moelle Osseuse
4) Un pic monoclonal à IgM
5) Un infiltrat plasmocytaire atypique > 20% au niveau de la moelle osseuse

A:1+3 B : 2+3 C:3+4 D:4+5 E:2+4

82- Les facteurs de la coagulation vitamine K-dépendants sont : RJ

A) II, VI, IX, X, C, S
B) II, VI, X, XI, C
C) V, VII, X, XI, S
D) II, VII, VIII, X
E)I, II, VII, X

83- Concernant le traitement de l'insuffisance cardiaque gauche Systolique ; quel est l'association juste : RJ

1) Les bêtabloquants sont contre indiqués en cas de fraction d'éjection inférieure cause de leur effet inotrope négatif.
2) Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion sont un traitement de première intention
3) Les anti aldostérone peuvent être prescrits même en cas d'insuffisance rénal terminal
4) Le furosémide peut être prescrit même en cas d'insuffisance rénal terminal
5) La tachycardie doit être respectée en cas d'insuffisance cardiaque gauche

A:1+2+5 B:1+3+5 C:2+4 D :2+4+5 E :3+5

84- Concernant le rétrécissement aortique ; quel est l'association juste : RJ

1) un RAO calcifie doit être opéré même quand il est lâche
2) un gradient aorte VG a 40mmhg est le panage de RAO moyenne serre
3) Une surface aortique inferieure à 1cm2 est l'apanage du rétrécissement aortique serré
4) Un patient porteur d'un rétrécissement aortique serré qui se plaint d'un angor d'effort doit être opéré
5) la syncope fait partie de la symptomatologie

A:1+2+4 B:1+3+4 C:2+3+5 D :2+3+4 E :3+4+5

85- Les Mycoses superficielles ; (Cochez la réponse fausse)

A) Peuvent être transmises par des animaux
B) Touchent la peau et épargnent les muqueuses
C) se voient chez l'adulte et l'enfant
D) Sont causées par des dermatophytes ou des levures
E) Régressent sous traitement antifongique

86- L'intertrigo candidosique se caractérise par : (Cochez la réponse fausse)

A) Une atteinte élective des espaces Interdigitaux,
B) Le fond du pli est le siège d'une fissure.
C) Le fond du pli est recouvert d'un enduit blanchâtre
D) Le fond du pli est recouvert d'un enduit verdâtre
E) La plaque érythémateuse est limitée par une collerette desquamative.

87- l'intolérance au glucose est définie par (Cochez la réponse juste) :

A) HbA 1c > 7%
B) HbA1c > 6,5%
C) Glycémie aléatoire> 2g /1
D) Glycémie> 2g /| après une HGPO
E) Toutes les réponses sont fausses

88- Les biguanides sont caractérisés par : (Cochez la réponse fausse)

A) Inhibent la néoglucogenèse hépatique
B) Insulino sensibilisateurs
C) Prise de poids
D) Contre indiquer en cas d'insuffisance rénale sévère
E) Peuvent se compliquer de troubles digestifs

89- L'exophtalmie simple de la maladie de basedow présente habituellement tous les caractères suivants, sauf un, lequel ? (Cochez la réponse fausse)

A) Bilatérale
B) Symétrique
C) Axile
D) Réductible
E) Douloureuse

90-devant un syndrome de cushing ; quel examens sont utiles au diagnostique étiologique (RJ)

1) dosage de l'ACTH plasmatique
2)dosage basal de cortisol plasmatique
3) dosage isole de cortisol libre urinaire
4)test de freinage fort par dexamethasone
5)examen TDM des surrénales

A:1+4+5 B:1+2+3 C:2+3+4 D :1+2+5 E :3+4+5

91-l'angio fibrome nasopharyngien est (RJ)

A) Plus fréquent chez le sujet âgé.
B) Se manifeste par une adénopathie cervical
C) Une tumeur de la puberté féminine
D) Le diagnostic est fait par l'imagerie.
E) Développé au niveau de la cloison nasal

92- Au cours d'un syndrome vertigineux périphérique (RJ)

A) Le gaz nystagmus est présent.
B) Le nystagmus est vertical pur
C) le nystagmus est diminue ou aboli par la fixation oculaire
D) L'atteint est Disharmonieuse.
E) Les signes neurovégétatifs sont absents.

Copyval

93- Les idées délirantes : (Cochez la réponse juste)

A) Sont pathognomoniques des troubles de l'humeur
B) Correspondent à une erreur corrigible
C) Correspondent à un trouble du cours de a pensée
D) Sont toujours soumises à la preuve et à la démonstration
E) sont un trouble de contenu de la pensée non rectifiable par le raisonnement

94- la délire érotomaniaque (RJ)

A) correspond a une conviction de préjudice dans les suites d'une intervention
B) correspond a une conviction délirant d'être issue dune ascendance illustre
C) correspond a un délire de revendication hypochondriaque
D) correspond a une illusion délirante d'être aimée généralement par une personnage jouissant d'un prestige avec le quel la patiente n'a que des relations lointaine voire aucune
E) est un trouble délirant de persécution

95- Dons le cancer de l'estomac, la tumeur de KRUKENBERG traduit : (Cochez le RJ)

A) un envahissement par contigüité du pancréas
B)une extension par voie lymphatique aux ganglion péri-gastriques
C)une extension Par vole sanguine au poumon
D) Un envahissement du ganglion sus claviculaire gauche
E) une extension par voie Péritonéale aux ovaires

96- En présence d'une hématémèse grave Par ulcère duodénal l'importance de hémorragie sera au mieux apprécié par. (Cochez la réponse juste)

A) quantité de sang rejetée
B)l'importance de la quantité de sang nécessaire pour rétablir et maintenir une tens1oncorrecte
C) l'agitation du sujet
D) La soif
E) Le taux d'hématocrite

97-parmi tout ses propositions Concernant la progression du poids, de la taille et du périmètre de l'enfant laquelle est juste : (Cochez la réponse juste)

A) La première année, la taille augmente de 25 cm année
B) L'enfant double son poids de naissance à 12 moi et le triple à 24 mois
C) Le PC augmente de 0,5 cm par mois les 12 premiers mois
D) La taille augmente de 30 cm la deuxième année
E) Le PC augmente de 1 cm par mois les 3 premiers mois

98- Un nourrisson pesant 5 Kg présente une déshydratation sur diarrhée aigüe. La fontanelle antérieure est déprimée, les globes oculaires sont excavés, il a un pli cutané net de déshydratation, la fréquence respiratoire est normale.

Vous administrez durant les 2 premières heures le soluté suivant : (Cochez la réponse juste)

A) 100 cc de sérum bicarbonaté à 14/°°
B) 100 cc de sérum salé isotonique à 9/°°
C) 250 cc de sérum bicarbonaté à 14/°°
D) 250 cc de sérum salé isotonique à 9/"*
E) 250 cc de soluté de réhydratation

99- L'examen radiologique de référence qui permet le diagnostique de l' hémorragie sous arachnoïdienne spontanée est : (RJ)

A) Angiographie cérébrale numérisée.
B) Angio-scanner cérébral.
C) Scanner cérébral sans produit de contraste
D) Scanner cérébral avec produit de contraste.
E) IRM cérébrale.

100- Le Neurinome rachidien : (RF)

A) Est une tumeur rachidienne bénigne des nerfs rachidiens
B) L'élargissement du Formen intervertébral est caractéristique
C) La douleur est de type « à dormir debout ».
D) Se développe dans le compartiment intra dural intra médullaire.
E) La chirurgie précoce permet une récupération des signes cliniques

Cas clinique n° 01 :

Patiente de 37 ans, mariée et mère de deux enfants, agent de la poste , expose aux tabagisme passif, sans antécédents pathologiques, consulte pour gène respiratoire depuis 5 jours avec toux quinteuse et crachats purulents et fièvre non chiffrée. elle rapporte le même tableau en périodes hivernales depuis son jeune âge. L'examen clinique retrouve une patiente consciente coopérative, parle avec des pauses, elle est bien colorée, FR : 32c/mn, FC : 126 batt/mn, TA : 110/60 mm He .T/ 38.5°c. Poids : 80 kB T : 1.63 m. À l'examen physique : tirage sus sternal et intercostal, avec des sueurs frontales.

L'examen pleuropulmonaire : présence de râles sibilants diffus aux deux champs

101- Quels sont les examens para cliniques à demander en priorité ? (Cochez la réponse juste)

1) Radiographie thoracique standard de face.
2) Débit expiratoire de pointe (DEP)
3) Gaz du sang
4) FNS + hémocultures
5) ECG.

A:1+2 B:2+3 C:2+4 D :3+4 E:4+5

Les résultats des examens complémentaires montrent :

- **Radiographie du thorax montre des signes de distension thoracique.**
- **DeP 200 l/mn pour Un DEP théorique de 480 l/ mn**
- **Gaz du sang : Pa O2 à 60 mmHg, PacO2 à 44 mmHg, pH à 7,38, bicarbonates 25meq/l**
- **FNS :GB 13000 elts/mm (PN : 92%, L : 8%, M : 1%, E ; 1%), GR à 4.8M, Hb à 12g/dl ;plaquette à 180000 elts/mm*, Hémocultures négatives**
- **ECG: Rythme régulier sinusal, pas de trouble de la repolarisation ni de la conduction.**

102- il S'agit d'un (e) : (Cochez la réponse Juste)

A) crise d'asthme bénigne
B) crise d'asthme modérée
C) crise d'asthme sévère
D) arrêt respiratoire imminent
E) exacerbation d'une crise d'asthme

103- En plus de l'oxygénothérapie et de l'antibiothérapie, vous décidez d'instituer le traitement suivant : (Cochez la réponse juste)

1) salbutamol en nébulisation
2) salbutamol en chambre d'inhalation
3) Corticoïdes per os
4) corticoïdes en IV
5) Corticoïdes inhalés à forte dose.

A :1+3 B :2+3 C:1+4 D: 2+4 E:1+5

Deux heures après la malade est toujours consciente, bien colorée, FR : 26 c/mn, FC 120 batt/mn, TA : 130/70 mm Hg.

A l'examen pleuro-pulmonaire retrouve un discret tirage sus sternal, des râles sibilants diminué d'intensité par rapport à l'examen antérieur. DEP : 320 |/mn.

104- Cette évolution incite à : (Cochez la réponse juste)

A) Transférer le malade dans un service spécialisé
B) Transférer le malade en soins intensifs
C) Augmenter les doses de corticoïdes
D) Maintenir le même schéma thérapeutique
E) Faire la sortie du malade

105: Quel est l'antibiotique de première intention a prescrire chez cette malade (RJ)

A) Amoxicilline
B) Amoxicilline + acide clavulanique
C) Erythromycine
D) Céfotaxime
E) Doxycycline

Cas clinique n° 02 :

M Samir âgé de 50 ans consulte pour toux productive persistante accompagnée de crachats sanguinolents et une chute pondérale. Les examens médicaux effectuée mettant en évidence une formation tumorale maligne de haut grade de poumon gauche .une indication chirurgicale est posée et le patient est hospitalisé.

106- L'information du patient doit porter sur : (RJ)

A) Le diagnostic et le traitement indiqué.
B) Le diagnostic, le traitement indiqué et les risques encourus par le patient
C) Aucune information ne doit être communiquée au patient de ce cas
D)il appartient au médecin traitant de décider des informations à communiquer en fonction de la situation et au cas par Cas.
E) Réponses b) et d) sont justes.

Quelques mois après l'intervention chirurgical et traitement institue ;le patient est reconduit à l'hôpital suite à l'apparition des complications métastatique en rapport avec sa pathologie. il se trouve en mauvais état générale mais conscient et coopérant .l'échec thérapeutique est constaté après prise en charge médicale ; sa maladie se trouve alors au dessus de toute possibilité thérapeutique curative.

107- Quelle doit être alors la conduite à tenir de l'équipe soignante au regard de La loi et de la déontologie ? (Cochez la réponse Juste)

A) L'abstention thérapeutique dans ce Cas, car la poursuite des soins correspondrait a un acharnement thérapeutique
B) La mise en place d'un Protocole de soins palliatifs,
C) La décision dans ce cas doit être Prise conjointement avec la famille
D) Prévoir la sortie du patient après la signature d'une décharge par le patient
E) la décision de l'arrêt des soins est conditionné par la décision de patient

Etat général du patient se dégrade brusquement par la survenue d'une péritonite post occlusive ;il présente des signes de choc avec trouble hémodynamique ,il est évacué vers L'Hôpital public le plus proche ; une intervention chirurgical en urgence s'impose alors

108- quels Sont les conditions légales Préalables à l'intervention chirurgical dans ce cas (RJ)

A) L'information et l'obtention de consentement éclairé du patient
B) L'obtention de consentement de la famille du patient
C) L'intervention doit être réalisée dans ce cas sans aucune condition
D) AetB juste
E) Aucun réponse juste

Par la suite et dans le post-opératoire immédiat, le patient est Victime d'une chute du lit de réanimation. Un hématome sous-dural aigue et une fracture temporale gauche sont constate au scanner .

Le patient décède alors le lendemain des suites de ce traumatisme.

109-la responsabilité médicale engagée dans ce cas est : (Cochez la réponse juste)

A) responsabilité médicale pénale
B) Responsabilité médicale administrative
C) responsabilité médicale civile
D) Responsabilité médicale disciplinaire
E) Réponses b} et c) sont justes

un mois après le décès du patient, son frère se présente pour demander au médecin traitant un compte rendu médical d'hospitalisation détaillé qui servira selon ses dires à l'obtention de certains droits.

110- Quelle doit être la conduite à tenir du médecin traitant face à cette demande ?(Cochez la réponse juste)

A) Répondre favorablement à cette demande ; le secret médical étant aboli après le décès du patient.
B) S'abstenir dans ce cas de remettre tout document aux membres de la famille du patient en vertu de la loi pénale.
C)Ce document ne peut être remis qu'au seul conjoint du patient décédée vertu de la loi.
D)Un compte rendu médical peut être établi et remis à la demande du juge
E) Réponses b) et d) sont justes.

Cas clinique n° 03 :

Monsieur M 45ans qui présent au urgence pour des idéations suicidaires il présent un sentiment de Mal être profond, se sent découragé, incapable de remplir les taches de son travail .les bilans ainsi que les examens complémentaires sont sans anomalies ; il souffre d'un trouble digestive difficile a décrire ; il ne peut pas alimenté ; présente une perte de poids importante ; il souffre de réveil fréquent très tôt le matin ; actuellement il est convaincue qu'il a un cancer puisque son estomac ne digère plus rien et que sa maladie est incurable . au fond il souhaite mourir pour mettre fin a sa souffrance

111: Quels sont les éléments sémiologiques de cette observation (RJ)

1) Insomnie Matinale
2) Syndrome Confusionnel
3) Syndrome de Cotard
4) Automatisme mental
5) Ralentissement Psychomoteur

A : 1+3+5 B: 1+2+3 C: 3+4+5 D: 2+4+5 C:1+4

112- Quel est votre diagnostic ? (Cochez la réponse juste)

A) Dépression masquée
B) Trouble à expression somatique.
C) Dépression mélancolique
D) Trouble de stress post traumatique,
E) Schizophrénie.

113- Le risque Suicidaire chez ce patient est élevé, étant donnée : (Cochez la réponse juste)

1) Le réveil très tôt le matin,
2) L'isolement affectif
3) L'âge du patient
4) Les idées d'incurabilité
5) La douleur morale

A: 1+2+3 B : 1+2+4 C:2+3+4 D :4+5 E: 3+4+5

114- quel est le traitement de choix chez cette durant les 2 premiers semaines (RJ)

A) Cure de perfusion de clomipramine (anafranil)
B) Benzodiazepine
C) Inhibiteur spécifique des capture de sérotonine et noradrénaline
D) Antipsychotiques
E) Thymoregulateur

115- quel est le risque a craindre chez ce patient le 2 premiers semaines (RJ)

A) Risque suicidaire
B) Virage de l'humeur
C) Levée d'inhibition
D) Hypotension artériel
E) Tout ces propositions

Cas clinique n° 04 :

Mr MT âgé de 65ans diabétique, hypertendu et tabagique, hémiplégique à la suite d'un accident vasculaire cérébral ischémique remontant à huit mois, consulte pour une douleur thoracique par épisodes évoluant depuis 24h, dont le dernier n'a pas cédé depuis 2h. À l'examen le patient est pale, le rythme cardiaque est rapide mais régulier, sans anomalies auscultatoires, les champs pulmonaires sont libres, la pression artérielle est à 170/60 au deux bras, le reste de l'examen est sans anomalies.

L'électrocardiogramme dix-huit dérivations retrouve un rythme sinusal régulier à 90 bpm, un PR à 220ms, un courant de lésion sous épicardique dans les dérivations DII AVf et DIII,V7 V8 V9.

116 Quelle est l'association juste : (Cochez la réponse juste)

1)Le patient présente un syndrome coronarien algue sans sus décalage du segment ST
2)Le patient présente un syndrome coronarien algue avec sus décalage du segment ST
3) Le trouble de la repolarisation est localisé dans le territoire inférieur
4)Le patient présente un bloc auriculo-ventriculaire du 2% degré type Mobiz 1
5)Le trouble de la repolarisation est localisé dans le territoire antérieur étendu.

A: 1+4 B:2 C:1+2+3 D:2+4 E:1+5

117-quel est l'association juste (RJ)

1) Une thrombolyse doit être réalisée chez le patient si une angioplastie primaire
Ne peut être réalisée dans les délais recommandés
2) Une angioplastie primaire doit être réalisée si elle peut être obtenu dans les 6h
3) Une double anti agrégation plaquettaire en plus d'un traitement par l'héparine sont les seuls traitements à proposer
4) Une double anti agrégation plaquettaire en plus d'un traitement par héparine sont les traitements à administrer dès que le diagnostic est posé
5) Selon l'anamnèse, le patient ne présente pas de contre-indication absolu a la thrombolyse

A : 1+2+4 B : 4+5 C:3 D:1+4+5 s E:1+5

118- Quelle est l'association juste : (Cochez la réponse juste)

1) Le territoire atteint présente un risque accru de survenue de troubles de la conduction
2) Le territoire atteint présente un risque accru de survenue de trouble du l'excitabilité
3) La survenue d'un rythme idio-ventriculaire accéléré est une complication de traitement proposé
4) La survenue d'une tachycardie ventriculaire est un signe de succès du traitement même si elle nécessite une cardioversion
5) Il s'agit d'un syndrome coronarien aigu sans sus décalage du segment ST classé à haut risque, une coronarographie doit donc être réalisée dans les 24 heures.

A:1+2 B : 1+2+3 C : 1+2+5 D : 1+2+4 E:5

Pendant que vous organisez la prise en charge de votre patient, votre Infirmier vous signale que votre patient fait un malaise. A l'examen le patient est conscient coopérant mais se plaint de vertiges, l'examen est inchangé mis à part une pression artérielle à 110/70 mmHg, l'électrocardiogramme retrouve une fréquence cardiaque à 35 bpm, une dissociation auriculo-ventriculaire avec la persistance du trouble de la repolarisation.

119- Quelle est l'association juste : (Cochez la réponse Juste)

1) Le trouble de la repolarisation s'est aggravé en bloc auriculo ventriculaire du 2eme degré type Mobitz 2
2) Il s'agit d'un bloc auriculo-ventriculaire du troisième degré
3) Le patient doit recevoir de l'adrénaline en intra veineuse lente
4) Le meilleur traitement reste l'angioplastie couplé à la sonde de stimulation temporaire
5) L'atropine et l'isoprénaline représentent le traitement pharmacologique d'attente.

A : 1+4+5 B:2+3+4 C:2+4+5 D :1+3 E: 2+5

Votre traitement est couronné de succès, quelques jours plus tard vous décider la sortie de votre patient .

120-concernant le traitement de sortie ; quel est l'association juste (RJ)

A) L'aspirine devrai être maintenue 12 mois
B) Le clopidogrel doit être maintenue 12mois
C) L'objectif des β bloquants est une FC < 50 BPM
D) IEC doivent être administre si le patient grade une dysfonction systolique de VG
E) Les statines doivent être administré a dose maximale tolérée

A : 1+2+3+4+5 B:2+3+4+5 C:1+2+5 D :3+4+5 E: 2+4+5

<u>Cas clinique n° 05 :</u>

Un homme âgé de 52 ans, aux antécédents personnels d'allergie respiratoire saisonnière, splénectomie il ya 30 ans suite à une contusion abdominale ;thrombophlébite il ya 3mois ; sur le plan familiale en retrouve :

- **père décédé d'un cancer colorectal**
- **frère décédé d'un cancer colorectal**

il a consulte pour une anémie, associée à un amaigrissement de 25 kg dans les derniers 6 mois ; L'examen retrouve en plus de la pâleur Cutanéo-muqueuse, un BMI à 19, une ebouche d'un pli de dénutrition et une cicatrice d'intervention chirurgicale abdominale.

121-sur le plan épidémiologique à quel groupe à risque appartient ce malade ? (Cochez la réponse juste)

A) Groupe à risque très élevé
B) Groupe à risque élevé
C) Groupe à risque moyen
D) Groupe à risque peu élevé
E) A aucun de ces groupes

122- Pour étayer le diagnostic, quel est le premier examen complémentaire à demander ?(Cochez la réponse juste)

A) Echographie abdominale
B)TDM abdominale
C) Coloscopie
D)Rectoscopie
E)Fibroscopie oeso-gastrique

123- Cet examen réaliser quel est celle qui permet devancer dans le diagnostic(RJ)

1) Rectoscopie
d) Coloscopie
3) Endoscopie basse
4) Echographie abdominale
5) TDM abdominale

A : 1+2 B:1+2+3 C:3+4+5 D :2+3 E: 4+5

Un volumineux processus tumoral ulcero-bourgeonnant infranchissable de la charnière recto sigmoïdienne a été mis en évidence .

L'étude hystopathologique des biopsies réalisés a ce niveau a conclu a un ADK bien différencié de type liberkuhnien.

124. Quel bilan d'extension réalisez-vous chez ce patient ? Cocher La RF

A) Coloscopie
B) Colo-scanner
C) IRM pelvienne
D) TOM Thoraco-abdomino-pelvien
E) Marqueurs tumoraux

Ce bilan a permis de diagnostiquer : en plus du processus néoplasique de la CRS, étends sur une longueur de 66 mm et une épaisseur maximale de 28 mm, avec discrète infiltration de la graisse du méso-transverse, un second processus néoplasique du colon ascendant, étendu sur une longueur de 70 mm et une épaisseur maximale de 22 mm, avec infiltration de la graisse mésocolique à ce niveau. Des Adénopathies locorégionales, le plus volumineuse mesure 10 mm de grand axe, un épanchement péritonéal de faible abondance. Absence de localisations secondaires hépatiques, pulmonaires ou osseuse

125- Que proposez-vous pour la suite de la prise en charge ? (Cochez la réponse Juste)

A) Adresser le patient au chirurgien
B) adresser le patient a l'oncologue
C) adresser le patient au radiothérapeute
D) adresser le patient au médecin anesthésiste
E) discuter le dossier du malade en réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP)

<u>Cas clinique n° 06 :</u>

Un jeune homme de 40 ans, SANS antécédents, pesant90 kg pour 1,74m consulte pour douleur épigastrique post prandiale a irradiations retro sternale ascendante rebelle au traitement médicale type inhibiteur de pompe a proton ; elle s'accompagnent de régurgitations et toux nocturne aux décubitus dorsal ; l'examen clinique est négative

126- le diagnostic retenu est (RJ)

A) Perforation d'un ulcère gastrique
B) Un méga œsophage
C) Un RGO
D) Cholécystite chronique
E) Œsophagite caustique

127- quel est l'examen para clinique de 1er intention devant ce tableau (RJ)

A) Manométrie œsophagienne
B) ASP
C) Endoscopie œsogastroduodénale
D) PH metrie œsophagienne
E) Transit œsogastroduodénal

128- quel sont les objectifs de cette examen para clinique (RF)

A) Le retentissement de cette pathologie sur la muqueuse œsophagienne
B) Traitement des lésions
C) Réaliser des biopsies
D) Un examen normal n'élimine pas les diagnostic
E) Evaluation de traitement médical an appréciation la cicatrisation des lésions

129- quel exploration fonctionnelle demandez vous pour confirme le diagnostic (RJ)

A) Fibroscopie
B) Manométrie œsophagienne
C) Echo endoscopie
D) Scanner thoracique
E) PH metrie

130- Vous indiquez les conseils hygiéno-diététiques suivants sauf : (RF)

A) Cure d'amaigrissement
B) S'allonger un quart d'heure après les repas
C) Surélever légèrement la tête du lit
D) Eviter les vêtements serrés
E) Fractionner son alimentation et supprimer le café et chocolat

Dossier clinique n° 01 :

un enfant de 08 ans consulte pour polydipsie et polyurie évoluant depuis 20 jours,
l'enfant aurait présenté une infection virale il y a 15 jours.
A l'examen : Poids 24kg Taille 129 cm T° 37.5 TA=110/50 mm Hg
FC90/mn FR 35/mm. Le reste de l'examen est strictement normal
Le diagnostic de diabète type | est évoqué

131- Pour établir le diagnostic positif vous demandez en priorité ? (RJ)

A) Glycémie à jeun
B) Chimie des urines
C) Bilan lipidique
D) Fonction rénale
E) Densité urinaire

132- Le bilan à réaliser en Première intention après avoir posé le diagnostic comporte tous ces examens sauf un: lequel ? (Cochez la réponse fausse)

A) Hémoglobine glyquée
B) Bilan lipidique
C) Sérologie de a maladie cœliaque
D) Gazométrie
E) Chimie des urines

133-136 illisible !

137- La mère nous interroge quant a la pratique du sport ; parmi tous les reponces que vous allez lui apporter laquelle est fausse ? (RF)

A) Tous les sports sont permis
B) Les sports à risques sont contre indiqués
C) L'activité physique est autorisée mais avec une bonne surveillance de l'insulinothérapie
D) Une hypoglycémie peut survenir 2H à 12h âpres l'effort
E) L'activité sportive est bénéfique pour l'enfant

138- Quelques jours après sa sortie, l'enfant consulte pour des sueur ;Une glycémie faite à l'aide d'une bandelette réactive est de 0.35g/1. Quel est votre conduite à tenir ? (Cochez la réponse Juste)

A) Surveiller le malade
B) Faire un appoint d'insuline
C) Donner un morceau de sucre et refaire la glycémie
D) Donner un morceau de sucre et du pain et refaire la glycémie
E) Doser l'hémoglobine glyquée en urgence

139- La complication présentée par cet enfant peut être due à : (Cochez le réponse juste)

A) Omission d'un repas
B) Exercice physique inhabituel
C) Doses de l'insuline excessives
D) A et C sont justes
E) Toutes ces réponses sont justes

140- Parmi toutes ces mesures de surveillance de la maladie, toutes ces réponses sont justes sauf une : laquelle ? (Cochez la réponse fausse)

A) Auto surveillance de la glycémie quotidiennement
B) Hémoglobine glyquée tous les mois
C) Bilan lipidique annuel
D) Micro albuminurie annuelle
E) Examen clinique complet tous les 03 mois.

Dossier clinique n° 02 :

Une femme âgée de 42 ans , consulte pour des douleurs aux poignet et aux pied évoluant depuis 4 mois ces douleurs ont tendance a s'aggraver progressivement et a provoquer 3 a4 réveils nocturnes associer a une raideur matinale d'environ 1h

Ces douleur sont peu calme par du diclofenac 150mg/j et paracétamol 2g/j, la patiente ce plainte de ne plus pouvoir allez faire ces courses comme avant .

Le bilan biologique objective : VS a 58 mm a la 1er h, CRP a 30mg/l, Hb 11g/dl ,

Plaquette a 500000/mm, Gb 7000/mm

141- devant ce tableau Clinique et biologique le diagnostic de PR est évoqué ; quel sont les examens a demander (RJ)

1) Bilan immunologique
2) Bilan radiologique des articulations touchées .
3) Echographie des poignets et des pieds
4) IRM des articulations touchées
5) Scintigraphie osseuse

A : 1+4+5 B:1+2+4 C:1+2+3 D :1+3+4 E: 1+3+5

142- parmi les examens immunologiques suivants lequel est le plus spécifique de PR
(cochez la réponse juste)

A) Anticorps anti-nucléaires
B) Facteurs rhumatoïdes
C) Anticorps anti mitochondries.
D) DRM anti-peptides citrullinés cycliques (anti-ccp)
E) Anticorps anti Scl7

143- Parmi les radiographies suivantes lesquelles sont utiles à l'évaluation des destructions ostéo-articulaires chez cette patiente ? (Cochez la réponse juste)

1)Radiographie des 2 poignets de face
2)Radiographie des 2 mains de face
3) Radiographie des 2 genoux face et profil
4)Radiographie des 2 pieds face et 3/4
5) Radiographies des deux coudes

A :1+2+5 B:2+3+4 C: 1+2+4 D :1+3+4 E 2+4+5

144- Parmi les explorations d'imagerie suivants lesquels permettent de mettre en évidence des lésions précoces au cours d'une PR débutante ? (RJ)

A) Echographie des articulations touchées
B) TDM des poignets
C) Scintigraphie osseuse
D) Radiographies standards des 2 mains
E) Arthro-scanner des 2 poignets

145- Le diagnostic de PR étant retenu, quelle est la possibilité thérapeutique de 1er intention ? (Cochez la réponse juste)

A) Anti-inflammatoires non stéroïdiens
B) Antalgiques
C) Méthotrexate associé ou non aux anti-inflammatoires stéroïdiens
D) Traitement biologique
E) Corticoïdes à forte dose

Copyval

146- Avant de débuter le traitement préconisé un bilan est demandé, lequel ? (Cochez la réponse juste)

1) Radiographie du thorax
2) Bilan rénal
3) Bilan hépatique
4) Examen ophtalmologique
5) L'IDR à la tuberculine

A: 1+2+5 B: 2+3+4 C: 1+2+3 D: 1+3+4 E: 2+4+5

147- A partir de quel délai allez-vous faire l'évaluation de la réponse au traitement ?(Cochez la réponse juste)

A) 6 mois
B) 12 mois
C) 3 mois
D) 1 mois
E) 9 mois

148- quel sont les éléments de surveillance à demander a la 1er évaluation (RJ)

1) TDM des mains et des pieds
2) Bilan immunologique comportant facteur rhumatoïde ; anticorps anti CCP
3) Bilan biologique comportant VS CRP NFS bilan hépatique et bilan rénal
4) Radiographie systématique de tout articulation douloureuse
5) Examen clinique complet

A: 1+2+5 B: 2+3+4 C: 1+3+4 D: 3+4+5 E: 2+4+5

149- âpres 6 mois de traitement et après optimisation du traitement de fond, la patiente présente une intolérance au traitement (vomissement et diarrhée) ce qui à amené la patiente a arrêter le traitement. Quelle est votre conduite à tenir ? (Cochez la réponse juste)

1)reprendre le même traitement à la même dose
2) changer de voie d'administration
3) instaurer un autre traitement
4)diminuer la dose du premier traitement
5) mettre la patiente sous corticoïdes

A :1+2+3 B:l+2+4 C:2+3+4 D: 2+3+5 E: 3+4+5

150- Après 9 mois de traitement la maladie reste active avec apparition de quelques érosions au niveau des 2 métacarpo-phalangiennes du 3ème doigt des deux mains. Quelle est votre conduite à tenir ? (Cochez la réponse Juste)

1) Changer de molécule
2) Associer plusieurs traitements de fond
3) instaurer un biologique
4) Associer une corticothérapie à forte dose
5) Associer une corticothérapie à faible dose

A: 1+2+3 B: 2+3+4 C:3+4+5 D: 1+3+5 E: 1+4+5

CT Sujet Résidanat octobre 2023

Qst	Rpns	Qst	Rpns	Qst	Rpns	Qst	Rpns	Qst	Rpns
1	**C**	31	**C**	61	**D**	91	**D**	121	**B**
2	**C**	32	**A**	62	**A**	92	**C**	122	**D**
3	**D**	33	**D**	63	**C**	93	**E**	123	**D**
4	**C**	34	**B**	64	**A**	94	**D**	124	**A**
5	**E**	35	**C**	65	**E**	95	**E**	125	**E**
6	**E**	36	**E**	66	**C**	96	**B**	126	**C**
7	**A**	37	**C**	67	**C**	97	**A**	127	**C**
8	**E**	38	**A**	68	**E**	98	**D**	128	**C !**
9	**B**	39	**B**	69	**A**	99	**C**	129	**B**
10	**C**	40	**C**	70	**C**	100	**D**	130	**B**
11	**C**	41	**E**	71	**E**	101	**B**	131	**A**
12	**A**	42	**B**	72	**B**	102	C	132	D
13	**B**	43	**E**	73	**D**	103	A	133	E
14	**B**	44	**E**	74	**E**	104	D	134	C
15	**B**	45	**C**	75	**A**	105	A	135	A
16	**D**	46	**B**	76	**D**	106	E !	136	B
17	**E**	47	**A**	77	**D**	107	B	137	A
18	**A**	48	**E**	78	**B**	108	C	138	D
19	**C**	49	**C**	79	**E**	109	E !	139	E
20	**A**	50	**A**	80	**C**	110	E	140	B
21	**A**	51	**C**	81	**C**	111	A	141	C
22	**E**	52	**C**	82	**A**	112	C	142	D
23	**D**	53	**C**	83	**C**	113	D !	143	C
24	**A**	54	**A**	84	**E**	114	C	144	D !
25	**D**	55	**BE**	85	**B**	115	E	145	C
26	**B**	56	**ABC**	86	**D**	116	B	146	C
27	**E**	57	**D**	87	**E**	117	D	147	C
28	**A**	58	**C**	88	**C**	118	B	148	D !
29	**D**	59	**D**	89	**E**	119	C	149	D
30	**A**	60	**C**	90	**A**	120	E	150	A !

Université Saad Dahlab Blida
Faculté de Médecine

Concours de Résidanat Session Décembre 2022
Durée de l'épreuve : Trois heures

Note d'information

-Ce questionnaire comporte 120 QCM dont les pages sont numérotées de 1 a 22
-les QCM sont réparties de la maniéré suivante.
-les QCM comportent chacune cinq propositions de A a E.
-les candidat soit cocher sur le grille de réponses uniquement une proposition (réponse juste RJ ou réponse fausse –RF)

copyWal

1. La vessie : (RJ)

A. La vessie vide est abdomino-pelvienne
B. La base est mobile
C. Le col se prolonge par l'ouraque
D. Les Ostiums Urétéraux sont situés à 1 cm l'ostium urétral
E. L'artère Vésicale Supérieure est issue de l'artère ombilicale

2. A Propos de l'innervation du membre pelvien :(RJ)

A. Chaque nerf spinal est formé par une racine dorsale motrice est une racine ventrale sensitive
B. Le plexus nerveux se forme à partir des rameaux postérieurs des nerfs spinaux
C. Les nerfs spinaux émergent par els foramens intervertébraux
D. Le plexus lombaire innerve les organes génitaux internes
E. Le nerf sciatique constitue une branche collatérale du plexus sacral

3. Parmi les propositions suivantes, laquelle est juste :(RJ)

A. L'estomac occupe la plus grande partie de la loge sous-phrénique gauche
B. L'incisure angulaire est juste en arrière de l'origine du tronc coeliaque
C. La musculeuse de l'estomac est entourée de deux feuillets de péritoine viscéral
D. La pars flaccida est le ligament hépato-duodénal contenant le pédicule hépatique
E. L'espace semi-lunaire de Traube est limité par deux lignes courbes et est en rapport avec la face postérieure de l'estomac

4. Concernant la mitochondrie : (RF)

A. La membrane externe laisse passer les molécules de petite taille
B. Elle comporte son propre ADN et ribosomes
C. Les membranes interne et externe ne sont jamais en contact
D. Le nombre de crêtes varie selon l'activité mitochondriale
E. Les mitochondriopathies sont le résultat d'un déficit dans la chaîne respiratoire

5. Les lysosomes :(RJ)

A. Présentent une double membrane
B. Sont Dérivés de la membrane de l'appareil de Golgi
C. Présentent des oligosaccharides sur la face externe
D. Ont un site de dégradations d'origine endogène uniquement
E. Sont très nombreux dans les globules rouges

6. Les hépatocytes :(RF)

A. Sont riches en peroxysomes
B. Présentent une surface vasculaire impliquée dans la sécrétion de la bile
C. Sont séparés de l'endothélium des sinusoides par l'espace de Disse
D. Contiennent du glycogène
E. Reposent sur un grillage réticuline

7. L'activité d'une gastrite chronique à Hélicobacter Pyloriest mise en évidencepar la présence de: (RJ)

A. Glandes atrophiques
B. Lymphocytes
C. Polynucléaires neutrophiles
D. Métaplasie intestinale
E. Mastocytes

8. Parmi ces colorations, laquelle met en évidence la mucine? (RJ)

A. Le trichrome de Masson
B. Le bleu alcian
C. Le rouge Congo
D. Les Sels d'argent
E. Le Perls

9. Les phénomènes d'adaptation cellulaire sont : (RF)

A. L'atrophie
B. L'hypertrophie
C. Les mitoses
D. L'hyperplasie
E. La métaplasie

10. La détersion : (RJ)

A. Est la résorption des tissus nécrosés au cours de l'inflammation
B. S'effectue uniquement par mécanisme physiologique
C. Permet une bonne cicatrisation même si elle est incomplète
D. Se Fait dans la circulation sanguine
E. Est obligatoirement chirurgicale

11. Un abcès le distingue d'un phlegmon par : (RJ)

A. La richesse en polynucléaires neutrophiles
B. La Présence de nombreux polynucléaires altérés
C. L'aspect bien circonscrit du pus
D. L'étendue des thromboses veineuses
E. L'intensité de l'œdème

12.Un des éléments cellulaires suivants participe à la constitution du granulome tuberculoïde, lequel ? (RJ)

A. Les polynucléaires neutrophiles de type Langhans
B. Les cellules géantes multinucléées
C. Les mégacaryocytes
D. Les mastocytes
E. Les lymphoblastes

13. Toutes ces inflammations sont spécifiques sauf une : (RF)

A. La tuberculose
B. La sarcoïdose
C. Le botriomycome
D. La lèpre
E. La maladie des griffes du chat

14. Une fragmentation deal chromatine correspond à:(RJ)

A. Une mitose
B. Une cytolyse
C. Une pycnose
D. Une caryolyse
E. Une caryorrhexis

15. L'amylose est :(RJ)

A. Une accumulation tissulaire de graisse animale
B. Une Accumulation anormale de glycogène dans les cellules
C. Un dépôt tissulaire interstitiel de protéines anormales
D. Un dépôt de complexe immuns
E. Un dépôt tissulaire interstitiel de fibrine.

16. Les mécanismes génétiques intervenant dans la carcinogenèse sont : (RF)

A. L'expression de gènes appelés oncogènes
B. La perte d'activité de gènes suppresseurs.
C. Les anomalies des gènes de réparation de l'ADN
D. Les télomèrases
E. La méthylation de l'ADN

17.Parmi les protéines suivantes, lesquelles sont synthétisées dans le foie ? (RJ)

1. L'albumine
2. Le facteur II de la coagulation
3. La CRP
4. La pro érythropoïétine
5. L'angiotensinogène

A: 1,2,3 B: 1.2,3,4 C: 1,2,3,5 D: 1,2,3,4,5 E: 1,3,5

18. Quel est le signe biologique spécifique qui confirme le diagnostic de cirrhose hépatique ? (RJ)

A. Une albuminémie basse
B. Une bilirubine totale élevée
C. Des C-ALAT élevées
D. Un bloc bêta-gamma à l'électrophorèse des protéines sériques
E. Des phosphatases alcalines élevées

Copywal

19. La galactosémie congénitale : (RF)

A. Est une enzymopathie
B. Est de transmission autosomique récessive
C. Est responsable d'hyperglycémie avec retard mental
D. Peut être due à un déficit en galactokinase
E. Est due à un déficit en galactose 1P-uridyltransférase

20. La gammapathie monoclonale dite bénigne est caractérisée par: (RJ)

1. Une douleur osseuse
2. Une VS peu augmentée
3. Un taux pondéral inférieur à 20 g/| s'il s'agit d'IgG
4. Une hyperlymphocytose au myélogramme
5. Une biopsie osseuse normale

A: 1,2,5 B:4 C: 1,3,4 D: 4,5 E 3,5

21. Parmi les complications du myélome, lesquelles sont dépendantes de l'Ig monoclonale : (RJ)

1. L'allongement du temps de thrombine
2. L'insuffisance rénale
3. L'ostéolyse
4. L'amylose
5. Les géodes osseuses

A: 1,2,5 B: 4 C: 1,2,4 D: 4,5 E. 5

22. Parmi les indications thérapeutiques des gammaglobulines humaines par voie parentérale, on retiendra : (RJ)

1. La maladie de Bruton
2. Les déficits sélectifs en IgA1
3. Les morsures faciales par un chien suspect
4. Les thrombopénies auto-immunes
5. L'hypogammaglobulinémie physiologique et transitoire du nourrisson

A: 1,2,5 B: 3,4 C: 1,3,4 D: 4,5 E: 1,3;5

23. La présence de bacille à Gram négatif isolé d'un liquide articulaire d'un enfant drépanocytaire évoque: (RJ)

A. Le staphylococcus aureus
B. La kingella kingae
C. La klebsiella pneumoniae
D. La salmonella sp
E. Le pseudomonas aeruginosa

24. Les dermatophytes : (RJ)

A. Peuvent être responsables d'onyxis avec un périonyxis
B. Peuvent être responsables de sycosis qui sont des atteintes des cheveux
C. Sont responsables essentiellement des atteintes profondes
D. Leur diagnostic est assuré par la recherche des anticorps spécifiques dans le sérum
E. Sont responsables essentiellement des atteintes superficielles

25. Le sphincter oesophagien inférieur se relâche sous l'effet des facteurs suivants, sauf un: (RJ)

A. Les graisses
B. L'acétylcholine
C. Les prostaglandines
D. La nicotine
E. Le VIP (Vasoactif Intestinal peptide)

26. La somatostatine inhibe la sécrétion gastrique acide en agissant sur : (RJ)

A. Un récepteur H2 de la cellule bordante
B. Un récepteur CCKb de la cellule bordante
C. La cellule ECL ou H à histamine
D. La cellule de L'antre gastrique
E. La cellule à sécrétine

27. Le réflexe myotatique inverse : (RJ)

A. Est un réflexe monosynaptique
B. Se traduit par une extension de la jambe sur la cuisse
C. Est mis en oeuvre par la simulation au bord externe de la plante du pied
D. Sollicite les récepteurs tendineux de Golgi
E. Est accompagné par un écartement en éventail des gros orteils

28. L'incoordination motrice avec tremblement, dysmétrie et hypermétrie caractérisent : (RJ)

A. Les lésions du spinocervelet
B. Les lésions du cervelet médian
C. Le syndrome paravermien
D. L'atteinte de la boucle dentato-rubro-olivo cérébelleuse
E. Les lésions du néocervelet

29. La lésion des noyaux sous-thalamiques se traduit par : (RJ)

A. Une akinésie
B. Des mouvements brusques du gesticulations (hémiballisme)
C. Des mouvements rapides, continus et incontrôlables
D.. Une impossibilité de maintenir la posture
E. Un tremblement intentionnel

30. Un choc hypovolémique peut être dû à : (RF)

A. Un syndrome néphrotique
B. Un hémothorax
C. Une augmentation de la précharge du ventricule gauche
D. Une levée d'obstacle
E. Une fracture du bassin

31. Parmi les étiologies de l'hypertension portale intrahépatique :(RF)

A. les cirrhose
B. La fibrose hépatique congénitale
C. L'hyperplasie nodulaire régénérative
D. Le syndrome de BUDD CHIARI
E. La sclérose hépato portale

32. Parmi les causes de l'alcalose métabolique : (RF)

A. Les apports massifs d'alcalins
B. La destruction massive osseuse
C. Les pertes digestives d'acides
D. Les pertes rénales d'acides
E. Le défaut d'élimination de phosphates

33. L'état de choc par hémorragie digestive : (RJ)

1. Est la manifestation la plus grave d'une hémorragie digestive
2. Le pronostic vital est mis en jeu
3. Se manifeste quand la perte sanguine est entre 750 et 1500 ml
4. Peut-être révélateur d'une hémorragie digestivo cataclysmique
5. Peut-être dû à une rupture de varices oesophagiennes

A: 1,2,4,5 B: 1,3,5 C:2,3,4 D:1,2,3,4 E:3,4,5

34. Le phénomène de redistribution : (RJ)

A. Intéresse les substances hydrosolubles
B. Est égal au rapport de la quantité administrée sur la concentration plasmatique
C. Peut conduire à une baisse de l'effet du médicament
D. Aucun médicament n'échappe à cet effet
E. Correspond à l'élimination totale d'un médicament après métabolisme hépatique

35. Les substances qui peuvent traverser les membranes cellulaires doivent-être : (RJ)

A. Hydrosolubles et ionisées
B. Liposolubles et non ionisées
C. Liposolubles
D. Ionisées
E. Toutes ces propositions sont fausses

36. Une des réactions suivantes fait partie des réactions de métabolisme de phase deux (II) : (RJ)

A. L'hydrolyse
B. L'acétylation
C. Décarboxylation
D. La réduction
E. L'oxydation

37. L'Apnée respiratoire sous succinylcholine résulte d'un déficit enzymatique : (RJ)

A. Hémoglobine réductase
B. Choline Transférase
C. Glucose-6-phosphate déshydrogénase
D. Cholinestérase
E. N.Acétyl-transférase hépatique

38.En IRM cérébrale, quelle est la séquence la plus sensible dans la détection des hémorragies intracrâniennes: (RJ)

A. La séquence T2*
B. La séquence de diffusion
C. La séquence en pondération T2 FLAIR
D. La séquence T1 avec saturation de la graisse
E. La séquence T1 avec injection de gadolinium

39. La visibilité des vaisseaux pulmonaires au travers d'une opacité sur une radiographie de face témoigne :(RJ)

A. D'une masse médiastinale pathologique
B. D'une grosse artère pulmonaire
C. D'un signe de convergence hilaire
D D'un signe de la silhouette
E. Les réponses A et C sont justes

40. Les signes précoces d'un AVC ischémique sur un sont : (RF)

A. L'effacement du noyau lenticulaire
B. Le signe de Delta
C. La dédifférenciation substance blanche-substance grise
D. L'effacement du ruban insulaire
E. L'hyperdensité spontanée d'un vaisseau intracrânien

41. Dans une toxi-infection alimentaire collective (TIAC) Aux toxines de Staphylococcus aureus, le laps de temps séparant l'apparition des symptômes chez le premier cas de ceux du dernier cas : (RJ)

A. Est égal à 11 heures
B. Est égal à 3 heures
C. Est égal à 24 heures
D. Est égal à 72 heures
E. Peut varier de 3 à 48 heures

42. La réaction sérologique de référence de la leptospirose est :(RJ)

A. La sérologie de Wright
B. La sérologie de Widal et Felix
C. La sérologie de Weil et Felix
D. La sérologie de Martin et Petit
E. Le test au Rose Bengale

43. Quel test hépatique faut-il utiliser pour apprécier la sévérité d'une hépatite virale aiguë ? (RJ)

A. Les transaminases
B. La bilirubine
C. Les phosphatases alcalines
D. La Gamma GT
E. Le taux de prothrombine ou taux du facteur V

44. Le traitement à la tuberculose pulmonaire jamais traitée chez un cirrhotique est le suivant : (RJ)

A. 2 RHZE / 4 RH
B. 2 RHZ/ 4 RH
C. 2 REZ/ 7 RE
D. 2 SRHZE /1 RHZE/ 5 RHE
E. 2 HEZ / 7 HE

45.Tous ces critères indiquent la mise en route d'un traitement systémique d'une sarcoïdose, sauf un, lequel ? (RJ)

A. La sarcoïdose médiastino-pulmonaire stade II
B. L'uvéite postérieure
C. La neuro-sarcoïdose au LBA
D. L'alvéolite lymphocytaire
E. L'hypercalciurie.

46. Quelle situation est en rapport avec un index de pression systolique supérieur à 1.3 : (RF)

A. Le diabète type 1
B. Le diabète type 2
C. L'insuffisance rénale
D. Les sujets âgés
E. L'insuffisance cardiaque

47. L'apparition brutale d'un oedème du membre inférieur avec tension importante du molette et refroidissement de l'extrémité doit faire évoquer : (RJ)

A. Une phlébite banale
B. Un érysipèle artérielle
C. Une embolie
D. Une phlegmatia coerulea sur lymphœdème chronique
E. Une poussée de lymphangite

48. La corticothérapie générale est fréquemment utilisée en dermatologie. Dans quelle affection est-elle contre-indiquée? (RJ)

A. Le pemphigus
B. Le psoriasis pustuleux
C. La dermatomyosite aiguë
D. La pemphigoïde bulleuse
E. Le lupus érythémateux aigu

49. Les diagnostics différentiels d'une urticaire sont :(RF)

A. Un eczéma aigu du visage
B. Une pemphigoïde au stade des placards urticariens pré-buleux
C. Une toxidermie maculo-papuleuse
D. Un exanthème bactérien
E. Une maladie de Still

50. Dans une des affections suivantes, il existe une microcytose avec fer sérique normal. Laquelle ? (RJ)

A. La sphérocytose héréditaire
B. La maladie de Biermer
C. La thalassémie
D. Les anémies hémolytiques auto-immunes
E. Les leucémies aiguës

51. Parmi ces symptômes, lequel évoque une hémolyse aiguë intra vasculaire ?(RJ)

A. Une dysurie
B. Des urines foncées
C. Une pâleur d'installation chronique
D. Une pollakiurie
E. Une hématurie massive.

52.L'encéphalopathieurémique est caractérisée par : (RJ)

A. Des signes neurologiques peu sévères
B. Une augmentation de la créatinine sanguine
C. Son Apparition au cours de l'insuffisance rénale chronique et jamais en insuffisance rénale aiguë
D. Une aggravation lors de la dialyse
E. Une amélioration des signes neurologiques par les séances de dialyse.

53. Une baisse persistante du complément sérique(CH50) est rencontrée au cours : (RJ)

A. D'une hyalinose segmentaire et focale
B. D'une glomérulonéphrite aiguë post-infectieuse
C. D'une glomérulonéphrite membrano-prolifération
D. D'une amylose
E. D'une néphrose lipoïdique

54. La myasthénie auto-immune est caractérisée par : (RJ)

A. Un bloc pré-synaptique des récepteurs de l'acétylcholine
B. Une fatigabilité musculaire permanente surtout le matin au réveil
C. Un signe de Gowers caractéristique
D. Un ENMG mettant en évidence un bloc post-synaptique avec décrément
E. Un traitement de première intention basé sur les immunosuppresseurs.

55. Dans la sclérose latérale amyotrophique (SLA) : (RF)

A. La dégénérescence touche les neurones moteurs centraux et les motoneurones alpha de la corne antérieure de la moelle
B. La forme à début brachial est la plus fréquente.
C. L'amyotrophie et les fasciculations sont caractéristiques
D. L'ENMG confirme l'atteinte de la corne antérieure
E . Les formes avec atteinte sensitive sont les plus graves

56. Dans l'aphasie de Broca : (RJ)

A. Le langage est pauvre et le patient ne comprend pas les consignes
B. La lésion se situe à gauche chez le droitier
C. Le langage est fluide et le patient ne comprend pas les consignes
D. La lésion concerne le lobe temporal
E. Aucune de ces réponses n'est juste

57. L'épilepsie absence petit mal : (RF)

A. Se traduit par une rupture de contact avec soi-même et avec le monde extérieur
B. Est une épilepsie idiopathique
C. S'accompagne de pertes de connaissance avec chutes brutales
D. Répond bien au traitement médical
E. Est caractérisée par des anomalies EEG à type de PO à 3 cycles/s bilatérales et synchrones

58. Les perturbations en cas de coma acido-cétosique sont : (RF)

A. La déshydratation et l'élévation de l'hématocrite
B. L'hyperosmolarité et l'hypernatrémie
C. Le pH sanguin < 7,20
D. L'hyperglycémie avec une osmolarité modérée < 320 mmol/l
E. L'insuffisance rénale aiguë.

59. Une femme peut présenter des ménorragies en cas de : (RF)

A. Fibrome sous muqueux
B. Fibrome sous séreux
C. Polype muqueux endocavitaire
D. Hyperplasie de l'endomètre
E. Adénomyose.

60. Parmi toutes ces propositions concernant le développement psychomoteur de l'enfant, laquelle est pathologique pour l'âge : (RJ)

A. Ne tient pas sa tête à l'âge de 2 mois
B. Ne marche pas à 12 mois
C. N'a plus ses réflexes archaïques à l'âge de 5 mois
D. Ne tient pas assis sans appui à l'âge de 07 mois
E. N'a pas la préhension pouce-index à 12 mois.

61. Dans le programme élargi de vaccination algérien ,la vaccination anti-pneumococcique doit se faire: (RJ)

A. A la naissance, 2 mois, 4 mois, 12 mois
B. A la naissance, 4 mois, 12 mois
C. A 1 mois,2 mois, 4 mois
D. A 2 mois, 4 mois, 12 mois
E. A la naissance, 1 mois, 4 mois, 11 mois.

62. Parmi les propositions suivantes, lesquelles représentent une amétropie sphérique : (RJ)

1. La myopie
2. La presbytie
3. L'hétérophorie
4. L'hypermétropie
5. L'astigmatisme

A: 1,4 B: 3,4,5 C:1,2,3 D:4,5 E: 3,4

63. Parmi les propositions suivantes, quelles sont celles retrouvées dans le trachome cicatriciel ? (RJ)

1. Les lignes d'ARLT.
2. Le trichiasis
3. Les follicules
4. Les ocelles limbiques
5. Les opacités cornéennes

A: 3,4,5 B: 2,3,5 C: 1,2,4,5 D: 1,4,5 E:1,3,5

64. Au cours d'un syndrome vertigineux périphérique: (RJ)

A. Le gaz nystagmus est présent
B. Le nystagmus est vertical pur
C. Le nystagmus est diminué ou aboli par la fixation oculaire
D. L'atteinte est dysharmonieuse
E. Les signes neurovégétatifs sont absents

65. L'étiologie d'un trismus peut être: (RF)

A. Un carcinome du bord latéral de la langue mobile
B. Un carcinome de la face interne de la joue
C. Un phlegmon de l'amygdale
D. Un carcinome de la commissure intermaxillaire
E. Une péricoronarite de désinclusion de dent de sagesse

66. Dans un traumatisme de la face, parmi les lésions suivantes, laquelle reste une urgence thérapeutique (dans les 12 heures)(RJ)

A. Une plaie du canal de Sténon ?
B. Une disjonction crânio-faciale ou fracture Lefort III
C. Une fracture bilatérale des condyles mandibulaires
D. Une plaie du globe oculaire
E. Une plaie du nerf facial.

67. Les lésions précancéreuses dans le cancer de l'estomac sont :(RF)

A.Les lésions dysplasiques et les polypes adénomateux
B. La gastrite hypertrophique de Ménétrier
C. La gastrite atrophique sur maladie de Biermer
D. Le moignon gastrique (lors d'une gastrectomie partielle il y a deux ans)
E . L'ulcère gastrique

68. La hernie crurale : (RJ)

A. Se rencontre souvent chez l'adolescent
B. Est une hernie congénitale
C. Est la forme anatomo-clinique qui se complique le plus d'étranglement
D. Se rencontre surtout chez l'homme
E. Peut-être oblique ou externe.

69. Les conséquences à court et à long terme de la splénectomie sont : (RF)

A. La thrombose des membres inférieurs
B. La thrombose spléno-portale
C. Le risque de carcinogenèse
D. Les altérations de la fonction immunitaire
E. Le risque infectieux

70. Le traitement de référence du carcinome épidermoïde du canal Anal localement avancé est : (RJ)

A. L'amputation abdominopérinéale
B. La Radiothérapie
C. La radiochimiothérapie
D. La chimiothérapie
E. La radiothérapie suivie de la chirurgie.

71. L'attitude clinique évocatrice d'une luxation de hanche post-traumatique dans sa forme ischiatique est : (RJ)

A. Flexion, rotation interne, abduction
B. Flexion, rotation externe, abduction
C. Flexion, rotation interne, adduction
D. Extension, rotation externe, adduction
E. Extension, rotation interne, raccourcissement.

72. Deux complications majeures et immédiates peuvent survenir lors d'une fracture de jambe : (RJ)

1. Une infection cutanée et osseuse
2. Des lésions vasculaires
3. Une embolie graisseuse
4. Une pseudarthrose de jambe
5. Un syndrome des loges

A: 1,2 B: 3,4 C : 4,5 D: 3,5 E: 2,4

73. L'examen clinique d'une sciatique comporte la recherche de ces signes clinique, sauf un, lequel ? (RJ)

A. L'attitude scoliotique antalgique
B. Le signe de rabot
C. Le signe de la sonnette
D. Le signe de la cassure
E. Le signe de Laségue

74. Les manifestations suivantes peuvent être retrouvées au cours d'un rhumatisme psoriasique, sauf une, laquelle ? (RJ)

A. L'arthrite du genou.
B. Les talalgies inflammatoires
C. L'arthrose digitale
D. La sacroillite
E . Le doigt en saucisse

75. Le signe pathognomonique de la brûlure du 2 eme degré est : (RJ)

A. L'érythème
B. La phlyctène
C. La pustule
D. La peau cartonnée
E. La tâche de Jelinek.

76. Les travaux comportant un risque de développer des troubles musculo-squelettiques de la région cervico-scapulaire sont : (RJ)

1. Le travail sur écran
2. Le travail avec les mains au-dessus des épaules
3. Le métier de carreleur.
4. Le port de charges lourdes
5. La station debout prolongée

A: 1,2,3,5 B: 1,3,4,5 C: 1,2,4 D: 1,4,5 E: 2, 3 , 4

77. Les sources d'exposition professionnelle au plomb sont : (RF)

1. La fabrication et récupération des accumulateurs de batteries,
2. La production de colle et de lubrifiants.
3. La fabrication d'appareils de mesure de température
4. La fabrication d'écrans anti radiation
5. La fabrication de munitions

A: 2,3 B: 1,3 C: 4,5 D: 1,5 E:1,4,5

78. Les troubles du spectre autistique associent : (RF)

A. Des troubles du langage
B. Un répertoire d'intérêts restreints et d'activités répétitives
C. Un déficit dans les interactions sociales
D. Des aptitudes à communiquer
E Des manifestations telles une insomnie, des phobies, des crises de colère et de l'agressivité

79. Les éléments métapsychologiques de la structure de la personnalité sont : (RF)

A. La nature du conflit
B. L'état de régression du Moi
C. La nature de l'angoisse
D. La place sociale de la personnalité
E. Les mécanismes de défenses spécifiques.

80. La déontologie médicale : (RJ)

A. Est l'ensemble des principes, règles et usages que doit respecter l'exercice de sa profession médicale médicale

B. Est totalement indépendante de l'éthique

C. Est un droit disciplinaire pénal

R. A Des implications d'ordre

E. Réponses A et C

Cas clinique N°01:

sur la fièvre typhoïde et les connaissances sur les Une étude cas-témoins d e celle-ci a donné les résultats suivants :

Statut	Connaissances sur les modes de transmission		Total
	Non	Oui	
Cas	37	51	88
Témoins	46	119	165
Total	83	170	253

81. La proportion transmission de la fièvre typhoïde est respectivement pour les cas et les témoins : (RJ)

A. 42 % e t 28 %

B. 45% et 30%

C. 55% et 70%

D. 48% et 52%

E. 58% et 72%

82. Le Risque de contracter une fièvre typhoïde pour ceux qui n'ont pas de connaissances, par rapport à ceux qui en ont, est multiplié ponctuellement par: (RJ)

A. 1.09

B. 1.88

C. 1.49

D. 1.59

E. 3.88

83. Si l'intervalle de confiance à 95% de la mesure d'association épidémiologique mesurant l'intensité de la relation est de (1.09 - 3.23), la relation entre la fièvre typhoïde et les connaissances sur les modes de transmission : (RJ)

A. N'est pas significative au risque 95%

B. Est significative au risque 5%

C. N'est pas significative au risque 5%

D. Est une relation dont l'étude ne permet pas de déterminer la probabilité auquel le hasard puisse expliquer les résultats

E. Est une relation dont l'étude ne permet pas de déterminer les mesures d'association épidémiologique

84. Le Surcroît d'incidence de contracter la fièvre typhoïde par les sujets qui n'ont pas de connaissances sur les modes de transmission est de: (RJ)

A. 14%

B. Ne peut pas être déterminé

C. 15%

D. 140%

E. 150%.

85. S'il y a une relation de causalité entre les connaissances sur les modes de transmission et la fièvre typhoïde, la proportion des cas de fièvre typhoïde qu'on pourrait prévenir en inculquant ces connaissances à ceux pas est de : (RJ)

A. 57%
B. 37%
C. 27%
D. 47%
E. Ne peut pas être déterminée

Cas clinique N°02 :

Une femme âgée de 72 ans,originaire et demeurant à Blida diabétique sous antidiabétiques oraux, consulte en urgence pour dyspnée aiguë et douleurs thoraciques droites apparues depuis hier.

Le début des troubles remonte à une semaine marquée par l'apparition d'une toux avec expectoration purulente dans un contexte fébrile.

L'examen clinique retrouve une malade en état général moyen pále, T°: 39°,5 C, Pouls : 120 Batt/min, FR : 32 cycles/min, TA : 90/06 mm Hg

L'examen du thorax retrouve une submatité

vésiculaire au niveau de la base gatele. droite et diminution du murmure vésiculaire au niveau de la base droite

La radiographie standard du thorax de face objective une opacité de la moitié inférieure de l'hémi-thorax droit, dense homogène effaçant la coupole diaphragmatique, comblant les deux culs de sac, à limites supérieures floues.

86. Ce tableau radio-clinique évoque en premier lieu : (RJ)

A. Un abcès du poumon droit
B. Une tuberculose pulmonaire
C. Une pleuropneumonie droite
D. Une pleurésie droite
E. Une pneumonie alvéolaire droite

87. La patiente a été hospitalisée en urgence. Parmi les critères suivants, quels sont ceux qui expliquent cette décision : (RJ)

1. L'apparition brutale des symptômes
2. La fièvre à 394,5 C
3. La TA: 90/06 mm Hg
4. La présence d'épanchement pleural liquidien
5. La fréquence respiratoire à 32 cycles/min.

A: 1,4 B: 3,5 C: 2,5 D: 3,4 E:1,2

88. Quels sont les examens paracliniques à demander en priorité ? (RJ)

1. Recherche de BK dans les crachats
2. FNS + hémoculture
3. IDR à la tuberculine
4. ECB des crachats
5. Glycémie

A: 1,2 B: 3,4 C: 4,5 D:1,5 E:2.5

Les résultats des examens complémentaires vous parviennent.

- La NFS :GB: 24000 elts/mm3 (81-01-00-17-01)
- GR : 3.8 millions elts/mm3 Hb : 9.5 g/dl Pt :169 000 elts/mm
- Hémoculture : négatif
- Recherche de BK dans les crachats négative
- IDR tuberculine:8mm
- L'examen cytobactériologique des crachats : Flore polymorphe.
- Glycémie : 2.40 g/l

89. Quel est l'antibiotique à prescrire en première intention chez cette patiente ? (RJ)

A. L'azithromycine
B. L'amoxicilline
C. Le cotrimoxazole
D. L'amoxicilline +acide clavulanique
E. Le lévofloxacine.

90. En plus de l'antibiothérapie, votre conduite à tenir d'urgence doit être complétée par : (RJ)

1. Un antipyrétique + antalgique
2. Des ponctions pleurales évacuatrices itératives
3. Des corticoïdes per os
4. Une kinésithérapie respiratoire
5. Une insulinothérapie

A:4,5 B:2,5 C:1,2 D:2,4 E:1,4

Cas clinique N°03 :

Une Patiente âgée de 35 ans, enseignante, présente une otorrhée fétide minime, une hypoacousie progressive évoluant depuis 4 ans. Dans ses antécédents, on note un traumatisme au coton-tige de l'oreille malade. L'examen retrouve une perforation marginale sous ligamentaire postérieure et un magma blanchâtre au fond de la perforation.

91. Quel est le diagnostic le plus probable ? (RJ)

A. Une otite moyenne chronique simple
B. Une otite moyenne chronique tuberculeuse
G. Un cancer de l'oreille moyenne
D. Une otite moyenne chronique cholestéatomateuse
E. Une otite atélectasique.

92. Le processus pathogénique retenu est : (RJ)

A. La migration épidermique à travers une perforation
B. L'inclusion épidermique
C. La rétraction de la membrane de Schrapnell
D. La destruction tympanique post-traumatique
E. L'infection tuberculeuse remontant à l'enfance.

93. Quel est l'élément indispensable pour poser le diagnostic positif ? (RJ)

A. L'examen au microscope ou à l'auto endoscope peut être confirmé par l'examen histologique
B. La recherche de BK par prélèvement de pus de l'oreille malade
C. La radio de Schüller
D. Le scanner du rocher
E. L'examen histologique

94. La malade présente depuis 02 semaines une paralysie périphérique progressive qui ne régresse pas sous traitement médical. A quoi pensez-vous ? (RJ)

A. L'infiltration du nerf facial par le processus néoplasique de l'oreille moyenne
B. La paralysie faciale d'origine tuberculeuse
C. L'effet ototoxique des gouttes auriculaires cholestéatomateuse
D. La complication de l'otite moyenne chronique
E. La paralysie faciale périphérique essentielle

95. L'exploration chirurgicale a été décidée, quel est l'élément qui ne fait pas partie des complications per-opératoires habituelles ?

A. La mastoïdite
B. La dénudation du nerf facial
C. L'envahissement du nerf facial par le processus néoplasique
D. La dénudation du canal semi-circulaire latéral
E. La dénudation des méninges.

Cas clinique N°04:

Un patient sportif amateur , âgé de 30 ans, consulte pour une kératodermie palmo plantaire, érythémato-squameuse et prurigineuse évoluant depuis des mois.

Ces lésions recouvrent les plantes des pieds avec extension sur la cheville droite et partiellement la paume de la main droite.

Son pharmacien lui prescrit de la bétaméthasone qu'il améliore puis récidive à l'arrêt de traitement.

96. Votre Interrogatoire recherchera :(RF)

A. L'histoire de la maladie.
B. Les antécédents personnels
C. Les différents médicaments utilisés avant et après apparition des lésions
D. L'activité professionnelle
E. Les caractéristiques du prurit

97. À l'examen clinique ce patient doit comporter :(RF)

A. L'examen des différentes articulations
B. L'examen des muqueuses, notamment buccale
C. L'examen des ongles
D. L'examen du cuir chevelu
E. L'examen des aires ganglionnaires

98. Les diagnostics pouvant être évoqués sont : (RF)

A. Un psoriasis
B. Un eczéma de contact de l'adulte
C. Une dermatite atopique
D. Ine épidermomycose
E. Une dermite irritative.

L'examen de ce patient, retrouve une hyperkératose sous-unguéale du gros orteil droit.

99. Quel est l'examen de première intention pour confirmer votre diagnostic ?(RJ)

A. Une biopsie cutanée sur la lésion de la cheville
B. Des patch-tests avec,la batterie standard internationale
C. Un Dosage des IgE sériques
D. Un examen mycologique sur les squames des différentes lésions
E. Aucune exploration n'est nécessaire

100. Votre diagnostic posé, quelle va être votre attitude thérapeutique ? (RJ)

A. Corticothérapie injectable retard: 1 injection par 15 j pendant 2 mois
B. Des antifongiques locaux pendant une semaine
C. Un dermocorticoïde pendant 15jours puis dégression lente
D. Eviction de l'allergène en cause
E. Antifongique local et oral jusqu'à amélioration

Dossier clinique N°01 :

Homme âgé de 49 ans consulte pour céphalées, asthénie et syndrome polyuropolydipsique, dans ses antécédents tabac actif, suivi pour goutte.

L'examen clinique est sans particularité.

Poids:88 kg, taille : 1m70,tour de taille 104 cm, TA =140/90 mmHg

Biologie:

-Glycémie à jeun :1,60 g/l retrouvée à 1,40 g/| (02mois auparavant). -CT: 2,9 g/l,TG :3g/l, LDL :1,80 g/1, HDL: 0,30 g/l.

101- Le patient présente :(RF)

A. Un diabète type 2
B. Un syndrome métabolique
C. Une dyslipidémie
D. Un trouble de la tolérance du glucose
E. Un IMC > 30 kg/m2

102. Critères diagnostic du syndrome métabolique : (RF)

A. Le tour de taille
B. La pression artérielle
C. Le LDL-C
D. L'HDL-C
E. La glycémie à jeun.

103. Quels examens complémentaires demandez-vous ? (RF)

A. L'ECG
B. La créatininémie
C. Le fond d'œil .
D. La protéinurie des 24 H
E. L'épreuve de charge orale en glucose.

104. Quelle serait votre prescription dans l'immédiat ? (RJ)

A. Une insuline retard
B. Un sulfamide hypoglycémiant
C. Un inhibiteur de l'alpha-glucosidase
D. Un glinide
E. Des règles hygiéno-diététiques

105. Sur quels éléments jugez-vous l'efficacité thérapeutique ? (RF) A. La pesée

B. L'HbA1c

C. Les triglycérides

D. L'insulinémie

E. La glycémie à jeun et post prandiale

A son prochain RDV de consultation, patient asymptomatique. Examen clinique normal, TA: 16/9,6, HbA1c:7,5%, créatinine:15 mg/l , bilan lipidique inchangé, protéinurie des 24h: 250mg.

106. Quel traitement instaurez-vous ?(RF)

A. La metformine

B. L'ARA ll

C. Les diurétiques

D. Une statine

E. L'aspirine

107. Le patient est considéré comme niveau de risque cardiovasculaire (RJ) :

A. Très élevé

B. Elevé

C. Modéré

D. Faible

E. Sans risque cardiovasculaire

Le patient a présenté il y a 03 mois un SCA ST(+) compliqué d'une dysfonction VG sévère nécessitant un réajustement thérapeutique.

108. Quel est votre schéma thérapeutique : (RJ)

A. Insuline lente +Metformine

B. NPH + Metformine

C. Insuline Rapide +Metformine

C. Insuline mixte +Metformine

E. Insulinothérapie

Après réajustement thérapeutique, au contrôle trimestriel, le patient présente : TA : 130/80 mm Hg, HbA1c : 7,5 %, IMC : 36 kg/m2,

urée: 0,85 g/l et créatinémie : 28 mg/l.

109. Le patient présente :(RF)

A. Un objectif tensionnel correct

B. Un objectif glycémique acceptable

C. Une obésité classe 2

D. Une clairance à la créatinine à 39 ml/mn

E. Insuffisance rénale terminale.

110. Le patient présente une neuropathie des membres inférieurs avec accès goutteux; il a été mis sous traitement, lequel est contre indiqué :

A. Les AINS

B. L'aspirine

C. Le Paracétamol

D. La zyloric

E. Le neuroleptique

<u>Dossier clinique N°02:</u>

Madame AZ agée de 35 ans, mariée depuis trois ans , consulte dans le cadre de suivi de sa grossesse, elle est à 28 SA , l'examen clinique ne retrouve rien de particulier en dehors d'une hauteur utérine insuffisante à 20 cm, l'échographie retrouve un retard de croissance harmonieux.

111. Dans le cadre d'une enquête étiologique, quels compléments pourraient être utiles au diagnostic? (RJ)

1. La sérologie CMV
2. Le test HPV
3. La sérologie anti COVID
4. La sérologie rubéolique
5. La sérologie anti Chlamydia.

A : 1,2 B: 1,3,5 C : 1,4 D:4,2 E:1,2,4

L'interrogatoire retrouve une notion d'éruption cutanée avec fébricule qui remonte au tout début de la grossesse,

112. Quel est le diagnostic le plus probable : (RJ)

A. RCIU en rapport avec CMV
B. RCIU en rapport avec une rubéole congénitale
C. RCIU en rapport avec une COVID
D. RCIU en rapport avec une rougeole
E. RCIU idiopathique.

113. Parmi ces propositions, laquelle présente le résultat sérologique obtenu chez cette patiente à 28 SA : (RJ)

A. Présence IgM anti-rubéolique et Absence IgG anti-rubéolique
B. Absence IgM anti-rubéolique et Présence IgG anti-rubéolique
C. Présence IgM anti-CMV et Présence |igG anti-CMV
D. Présence des Ig Totaux anti Sars-Cov-2
E. Présence IgG anti-Chlamydia.

114. Parmi ces propositions, laquelle confirmera votre diagnostic: (RJ)

A. Le dosage des IgG anti-CMV entre deux sérums de deux semaines d'intervalle
B. Le dosage des IgM anti-rubéolique chez le nouveau-né à la naissance
C. La mesure de l'avidité des IgG
D. La recherche de l'ADN du CMV dans la salive du nouveau-né à la naissance
E. La recherche de l'ARN du virus de la rubéole dans le liquide amniotique.

Huit semaines après l'accouchement, la patiente se présente à la consultation vous demandant de lui prescrire un somnifère pour ses

troubles du sommeil: "Depuis deux mois, je dors très mal, je me réveille plusieurs fois au milieu de la nuit et j'ai du mal à retrouver le sommeil". Lors de l'entretien, ses gestes sont rares et son discours est pauvre. Elle dit se sentir incapable et inutile pour son foyer et son bébé. Elle n'a plus aucun plaisir à faire les choses. L'examen clinique est sans particularités.

115. Quels sont les symptômes présentés par la patiente ?(RJ)

1. Une insomnie initiale
2. Une insomnie de maintien
3. Un ralentissement psychomoteur
4. Une anhédonie
5.Une auto-dévalorisation.

A:2,3,5 B: 1,3,5 C: 1,3,4,5 D: 1,2,3,4,5 E: 1,2,3,5

116.Quels sont les autres symptômes que vous recherchez ?(RJ)

1. Une perturbation de l'appétit
2. Un sentiment de tristesse avec des idées noires
3. Un trouble de la concentration
4. Une fatigue
5. Un trouble de l'attention.

A: 1,2,4 B:1,2.3,5 C: 1,2,3,4,5 D:1,2,3,4 E: 1,2,4,5

117. Pour explorer les idées suicidaires, vous décidez de :(RJ)

A. Poser la question secrètement au mari
B. Poser la question directement à la patiente
C. Poser la question à la patiente au prochain RDV d'elle-même
D. Ne Pas poser la question car la patiente est venue consulter
E. Orienter immédiatement la patiente en consultation de psychiatrie.

118. Un score de 22 points au test questionnaire PHQ-9, indique: (RJ)

A. Une absence de dépression
B. Une dépression légère
C. Une dépression modérée
D. Une dépression modérément sévère
E. Une dépression sévère

En parcourant les antécédents de la patiente , vous noter un épisode similaire à la naissance de son premier enfant et deux épisodes de très courte durée où elle était joyeuse et très dynamique

119- Quel diagnostic retenez-vous ? : (RJ)

A. Une dépression récurrente
B. Une dépression résistante
C. Une dépression chronique
D. Un Trouble bipolaire type 2
E. Un trouble bipolaire type 1

120. Quel est la prise en charge de cette patiente ? (RJ)

A. Une hospitalisation, un arrêt d'allaitement, un antidépresseur et une sismothérapie
B. Un antidépresseur et une sismothérapie sansarrêt d'allaitement
C. En ambulatoire, un thermorégulateur et une sismothérapie avec arrêt d'allaitement
D. Une hospitalisation, un arrêt d' allaitement, prescription d'un antidépresseur et un thermorégulateur associé à une psychothérapie de soutien avec des surveillances des grossesses suivantes
E. Toutes ces réponses sont fausses

.

CT Résidanat Décembre 2022

Question	Réponse	Question	Réponse	Question	Réponse	Question	Réponse
1	**E**	31	**D**	61	**D**	91	D
2	**C**	32	**E**	62	**A**	92	A
3	**A**	33	**A**	63	**C**	93	D
4	**C**	34	**C**	64	**C**	94	D
5	**B**	35	**B**	65	**A**	95	C
6	**B**	36	**B**	66	**D**	96	E
7	**C**	37	**D**	67	**D**	97	A
8	**B**	38	**A**	68	**C**	98	E
9	**C**	39	**E**	69	**D**	99	D
10	**A**	40	**B**	70	**E**	100	E
11	**C**	41	**B**	71	**C**	101	D
12	**B**	42	**D**	72	**A**	102	C
13	**C**	43	**E**	73	**B**	103	E
14	**E**	44	**C**	74	**C**	104	E
15	**C**	45	**E**	75	**B**	105	D
16	**E**	46	**E**	76	**C**	106	C
17	**C**	47	**D**	77	**A**	107	A
18	**D**	48	**B**	78	**D**	108	A
19	**C**	49	**A**	79	**B**	109	E
20	**E**	50	**C**	80	**E**	110	B
21	**C**	51	**B**	81	**E**	111	C
22	**C**	52	**E**	82	**B**	112	B
23	**D**	53	**C**	83	**B**	113	B
24	**E**	54	**D**	84	**B**	114	E
25	**B**	55	**E**	85	**D**	115	D
26	**C**	56	**B**	86	**C**	116	C
27	**D**	57	**C**	87	**B**	117	B
28	**C**	58	**B**	88	**E**	118	E
29	**B**	59	**B**	89	**D**	119	D
30	**C**	60	**E**	90	B	120	D

Université Saad Dahlab Blida
Faculté de Médecine

Concours de Résidanat Session Février 2022
Durée de l'épreuve : Trois heures

Note d'information

-Ce questionnaire comporte 120 QCM dont les pages sont numérotées de 1 a 22
-les QCM sont réparties de la maniéré suivante.
-les QCM comportent chacune cinq propositions de A a E.
-les candidat soit cocher sur le grille de réponses uniquement une proposition (réponse juste RJ ou réponse fausse – RF)

CopyWal Pavillon-18
-a l'interieur de la fac usdb (Pavillon-18)
-en face des amphis médecine (pav-29)

1. A propos du trigone fémoral : (RJ)

A) Est appelé aussi région inguino - fémorale latérale

B) La base est limitée par le ligament inguinal

C) Le plancher est limité par le muscle long adducteur bordé par le muscle gracile

D) L'arcade crurale , est une bandelette fibreuse formée par les fibres inférieures de l'aponévrose des muscles larges de l'abdomen

E) La paroi externe est formée par le bord interne du muscle pectiné

2. A propos de la paroi antéro - latérale de l'abdomen : (RJ)

A) Elle forme à elle seule la majeure partie des parois de l'abdomen

B) En profondeur , elle s'étend jusqu'au péritoine pariétal inclus

C) Superficiellement : un cadre squelettique représenté en arrière par les apophyses transverses de la colonne vertébrale dorsale et lombaire

D) Les repères cutanés sont représentés par le sillon médian antérieur , l'ombilic , en bas par le pli inguinal qui forme la racine de la cuisse

E) Le muscle oblique externe de l'abdomen est le plus profond de la paroi abdominale

A(1.2.3). B(2.4.5). C(1.3.5). D(2.3.5). E(1.2.4).

3- Les mitochondries ont les fonctions suivantes : (RF)

A) Métabolisme oxydatif

B) Cétogenèse

C) Synthèse des hormones stéroïdiennes

D) Bloquent l'apoptose (mort cellulaire programmée)

E) Interviennent dans la fertilité masculine et féminine

4- Les peroxysomes : (RJ)

A) Assurent la détoxification cellulaire

B) Sont composés d'une double membrane

C) Sont de petite taille dans les cellules hépatiques et rénales

D) Renferment des hydrolases et des produits de dégradation

E) Libèrent du H202 qui n'est pas toxique

5. Concernant le corpuscule de Malpighi du rein , toutes ces propositions sont justes , sauf une laquelle ? (RJ)

A) Les capillaires sanguins sont de type fenêtré

B) Le feuillet viscéral de la capsule de Bowmann est formé de podocytes

C) L'appareil juxta glomérulaire s'identifie au pôle vasculaire du corpuscule de Malpighi

D) La lame basale des capillaires sanguins est discontinue et elle constitue l'élément principal de la filtration glomérulaire .

E) Le conjonctif du glomérule associe une matrice conjonctive amorphe et des cellules mésangiales

6.La muqueuse colique se caractérise par tous les éléments suivants , sauf un lequel ? (RJ)

A) L'absence de villosités intestinales A

B) La présence des glandes de Lieberkühn

C) L'absence d'entérocytes

D) La présence des cellules caliciformes

E) La présence de nodules lymphoïdes

7) Tous ces anticorps permettent de définir l'origine cellulaire d'une tumeur sauf un , lequel ? (RJ)

A) Pancytokératine

B) Vimentine

C) Chromogranine

D) Her2

E) Myogénine 18

8) Parmi ces anticorps , un seul est à visée double : diagnostique et thérapeutique , lequel ? (RJ)

A) PS100

B) Synaptophysine

C) CD20

D) Myogénine

E) TTF1

9. Dans une inflammation aiguë virale , tous ces éléments peuvent s'observer sauf un , lequel ? (RJ)

A) L'œdème
B) La congestion vasculaire
C) Les lymphocytes
D)Les histiocytes
E) Les polynucléaires

10. Le score de Gleason dans le cancer de la prostate est basé sur : (RJ)

A) La désorganisation architecturale
B) Le grade histologique le plus élevé
C) Les atypies cytonucléaires
D) L'index mitotique
E) La disparition de l'assise basale C

11. Le grade nucléolaire de Furhman :

A) N'est appliqué que pour les carcinomes à cellules claires et carcinomes papillaires
B) Ne prend pas en compte le type cellulaire
C) Se base sur les atypies cytonucléaires
D) A une valeur pronostique
E) Est évalué sur les zones les plus atypiques

12. Le carcinome à cellules claires du rein :

A) Est d'architecture papillaire
B) La composante sarcomatoide est de bon pronostic
C) Se voit souvent chez l'enfant
D) Est une tumeur mésenchymateuse
E) S'associe à une anomalie du gène VHL dans 60 % des cas

13. L'Espèce avec une résistance naturelle au Céfotaxime est : (RJ)

A) Proteus mirabilis
B) Enterococcus faecalis
C) Morganella morganii
D) Streptococcus pneumoniae
E) Staphylococcus aureus

14. Cette espèce bactérienne est pathogène stricte :

A) Acinetobacter baumannii
B) Chlamydia trachomatis
C) Pseudomonas aeruginosa
D) Streptococcus pneumoniae
E) Streptococcus agalactiae

15. La présence d'un risque de rubéole congénitale est associée à ce profil

A) Absence des IgG antirubéoliques avant 20 S. A (semaine aménorrhée)
B) Présence des IgG antirubéoliques avant la grossesse
C) Absence des IgG antirubéoliques après 20 S.
D) Test d'avidité des IgG supérieur à 70 % avant 20 S. A
E) Test d'avidité des IgG inférieur à 30 % avant 20 S.A

16. Pour faire le diagnostic bactériologique d'un cas clinique suspect de légionellose , il faut , en priorité : (RJ)

A) Prescrire dans l'immédiat une antibiothérapie bactéricide
B) Effectuer des prélèvements chez le patient et mise en culture sur milieu BCYE .
C) Effectuer des prélèvements dans une alimentation en eau chaude
D) Faire un séro - diagnostic de la légionellose .
E) Rechercher l'antigène urinaire à l'aide d'un test immuno - chromatographique Op

17. A propos de Listeria monocytogenes : (RJ)

A) C'est un Bacille à Gram positif , responsable de méningites et de septicémies
B) C'est une bactérie commensale de l'oropharynx
C) Le diagnostic sérologique est spécifique de la listériose
D) Une bactérie pathogène dont le réservoir de germes est strictement humain
E) Est sensible aux céphalosporines de 3ème génération

Copyval

18. Parmi les espèces bactériennes suivantes , laquelle est une bactérie à pouvoir pathogène non spécifique ? (RJ)

A) Legionella pneumophila

B) Staphylococcus aureus

C) Salmonella typhi

D) Treponema pallidum

E) Mycobacterium tuberculosi

19 La cryptococcose est une mycose :

1 Opportuniste due à une levure encapsulée « Cryptococcus neoformans »Semanifestant essentiellement par un syndrome dysentérique

2) Opportuniste due à une levure encapsulée « Cryptococcus neoformans » qui a un neurotropisme , se manifestant essentiellement par une atteinte neuro - méningée Grave

3)Dont recherche d'antigène circulant « glucuronoxylomannane » est plus rentable au diagnostic que celle des anticorps une levure encapsulée « Cryptococcus neoformans » , se

4) Opportuniste due traduisant sur le plan biologique par une anémie hémolytique

5) Qui touche surtout les sujets infectés par le VIH ayant'un taux de CD4 inférieur à 100 éléments / mm^3

A(1.3.5). B(2.3.5). C(1.4.5). D(3.4.5) . E(1.2.3.4.5)

20. La pneumocystose humaine est une mycose opportuniste : (RJ)

A . Qui se traduit essentiellement sur le plan clinique par un syndrome neuro méningé grave .

B. Due à un champignon atypique spécifique à l homme (pneumoćstis jirovecii).

C.Qui peut se traduire sur le plan chinique chez un adulte immunodéprimé par la triade classique associant: une flèvre ,une toux sèche et une dyspnée d'intensité croissante.

D) Dont transmission interhumaine est possible .

E) Qui touche essentiellement les sujets infectés par le VIH ayant un taux de CD4 infenieur a200 éléments/mm^3

A(1.2.5). B(1.3.4). C(1.4.5) D.(1.2.3.4.5) E.(2.3.4.5)

21. Parmi les propositions suivantes , laquelle est incompatible avec le diagnostic de diabète insipide central polyurie ? (RJ)

A) Sodium plasmatique à 152 mmol

B) Urée plasmatique à 0,59 g / l

C) Protides totaux à 88 g / l

D) Osmolalité urinaire à 822 mOsmol / kg après 8 H de restriction hydrique

E) Perte de poids de 2 % par rapport au poids initial après 8H derestriction hydrique

22. L'examen clinique d'un enfant de 5 ans de sexe masculin , montre à la palpation , l'absence de testicule droit au niveau du scrotum . Dans le but de poser un diagnostic différentiel entre cryptorchidie et anorchidie , quel test proposeriez - vous ? (RJ)

A) Un dosage statique de la testostérone

B) Un test de stimulation à la ß HCGC

c) Un spermogramme

D) Un dosage de la FSH et LH

E) Un test de stimulation au Tamoxifène

23. Un enfant de 7 ans présente des hypoglycémies entre les repas , l'exan clinique montre des signes d'hépatomegalie . Un bilan biochimique a été réal et qui révèle une hyperlactacidémie et une hyperuricémie . Ces signes sont faveur de quelle perturbation enzymatique : (RJ)

A) Déficit total en hypoxanthine guanine phosphoribosyl transferase

B) Déficit en xanthine oxydase

C) Déficit partiel en hypoxanthine guanine phosphoribosyl transferase

D) Déficit en glucose 6 phosphate déshydrogenase

E) Déficit en glucose 6 phosphatase

24. Les pathologies suivantes font partie des hypersensibilités de type II :

A) L'anémie hémolytique auto - immune .

B) La thrombopénie auto - immune .

C) Les alvéolites allergiques extrinsèques :

D) Les cytopénies médicamenteuses .

E) Le syndrome de Good Pasture .

25. Les signes suivants peuvent être révélateurs d'un caviion lome multiple : (RF)

A) Une protéinurie .

B) Un taux des immunoglobulines polyclonales sérique

C) Une plasmocytose médullaire supérieure à 10

D) Une vitesse de sédimentation très accélérée . E) Une hypercalcémie ..

26. Le Syndrome de Wiskott Aldrich : (RF)

A) Est transmis par le chromosome 14 .

B) Est dû à des mutations du gène codant la protéine WASP (Wiscott aldrich syndrome protéin.

C) Touche les lymphocytes , les plaquettes , les monocytes et la peau .

D) Se traduit cliniquement par des ecchymoses , pétéchies , épistaxis , eczéma et des infections bactériennes récurrentes .

E) Le taux des IgM est bas , les IgA sont parfois élevées , les IgG sont dans les normes .

27. Le système antéro - latéral ou système extraleminiscal véhicule l'information relative : (RJ)

A) Au tact protopathique

B) Au tact épicritique

C) A la sensibilité proprioceptive

D) A la sensibilité de la face

E) A la sensibilité inconsciente

28. Au cours du sommeil paradoxal , il est retrouvé tous ces signes sauf un , lequel ? (RJ)

A) Des mouvements oculaires rapides

B) Une augmentation de la fréquence respiratoire

C) Une augmentation de la fréquence cardiaque

D) Des ondes lentes à l'EEG

E) Un relâchement musculaire

29) Une des hormones suivantes Interagit avec un récepteur transmembranaire à domaine enzymatique : (RJ

A) La FSH

B) L'ADH

C) Le glucagon

D) L'adrénaline

E) L'insuline

30. L'adipocyte sécrète un facteur de sensibilisation à l'insuline , lequel ? : (RJ)

A) L'interleukine - 6

B) La résistine

C) L'adiponectine

D)Le plasminogen activator inhibiteur -1 (PAI - 1)

E) L'acylation stimulating protein (ASP)

31. Les signes ECG d'une hyperkaliémie sont : (RF)

A) Onde T haute , pointue et symétrique .

B) Un affaissement de l'onde T

C) Des anomalies de la conduction auriculaire

D) Des anomalies de la conduction intraventriculaire

E)Une tachycardie ventriculaire

32. Les déterminants majeurs de la pression artériell sont :

A)Le débit cardiaque

B) Les résistances périphériques totales

C)La fréquence cardiaque

D)Le volume d'éjection systolique

E)La fréquence rerespiratoire

33. L'hypernatrémie traduit un trouble de l'hydratation , lequel : (RJ)

A)Une hyper hydratation extracellulaire
B)Une déshydratation intracellulaire
C) Une hyperhydratation intracellulaire
D) Une déshydratation extracellulaire
E) Un état d'hydratation normale to no

34. Dans la dépendance physique aux médicaments , le malade présente : (RJ)

A) Un syndrome de sevrage en cas d'arrêt du médicament ,
B) Une sensation de bien - être sans augmenter les doses
C) Une bonne condition physique
D) Une dépendance psychique uniquement
E) De bonnes relations avec son entourage

35. Les médicaments sympatholytiques sont indiqués dans les pathologies suivantes sauf une . Dites laquelle : (RJ)

A) Hypertension artérielle
B) Cardiopathies ischémiques
C)Phéochromocytome D)Glaucome
E)Choc anaphylactique

36. La myorelaxation pharmacologique curarisante est indiquée pour :

A) Permettre un acte opératoire
B) Faciliter l'intubation endotrachéale
C) Diminuer les convulsions lors d'un électrochoc
D) Bloquer la transmission au niveau de la jonction neuromusculaire
E)Traiter les contractures lors d'affections ostéo - articulaires

37. Un des médicaments suivants n'est pas un inducteur enzymatique : (RJ)

A) Rifampicine
B) Phénobarbital
C) Griséofulvine
D) Tolbutamide
E) Phénylbutazone .

CopyWal Pavillon-18
-a l'interieur de la fac usdb (Pavillon-18)
-en face des amphis médecine (pav-29)

38. Quel est l'examen radiologique indiqué dans le cadre de l'urgence en cas de suspicion d'un AVC ? (RJ)

A) Angio - scanner cérébral
B) IRM cérébrale
C) Scanner cérébral sans injection de produit de contraste
D) Angiographie cérébrale
E) Radiographie du crâne Pavil

39. En IRM , quelle est la séquence la plus sensible dans la détection des AVC ischémiques ? (RJ)

A) Séquence en pondération T2
B)Séquence de diffusion avec
C) Séquence T1 avec injection de gadolinium
D) Séquence T2
E) Toutes les réponses sont justes

40. Un hématome sous dural aigu se présente au scanner comme : (RJ)

A) Une collection biconcave hyperdense
B) Une collection biconcave hypodense
C) Une collection en croissant hypodense
D) Une collection en croissant hyperdense
E) Le plus souvent hyperdense quand il arrive à sa phase chronique

41. Les deux types d'enquêtes retenues en épidémiologie analytique à visée étiologique sont : (RJ)

A) Enquête de prévalence et enquête cas témoins
B) Enquête cas témoins et enquête de cohorte exposés / non exposés
C) Enquête en double aveugle et surveillance épidémiologique continue
D) Surveillance épidémiologique continue et enquête de prévalence .
E) Enquête de cohorte exposés / non exposés et surveillance épidémiologique continue

42. Si 400 nouveaux cas de maladie ont été recensés en deux ans parml une population de 100000 personnes le taux d'incidence de la maladie est de:

A)200 / 100000 / an
B) 800 / 100,000 personnes - années
C)400/100000 personnes - années
D) 20 / 100000 / an
E) 2000 / 100000 / an

43. Dans une toxi - infection alimentaire collective aux toxines de staphylococcus aureus , le laps de temps séparant l'apparition des premiers symptômes chez premier cas de ceux du dernier cas : (RJ)

A) Est égal environ à 11 heures
B) Est égal environ à 3 heureB
C) Est égal environ à 24 heures
D)Peut varier de 3 à 48 heures

44. Les signes clinques évocateurs d'une fièvre typhoïde : (RF)

A Une fièvre ondulante
B) Une fièvre en plateau
C) Une splénomégalie
D) Une dissociation pouls - température
E) Des taches rosées lenticulaires

45. Quel antibiotique est adapté à la prophylaxie des pneumocystoses chez les patients infectés par le VIH ? (RJ)

A) Doxycicline
B) Rifampicine
C) Clarithromycine D)Cotrimoxazole
E) Ciprofloxacine

46)Un patient porteur d'une insuffisance aortique :

A)Ne peut rester asymptomatique pendant une longue période
B) Le pincement de la pression artérielle différentielle est évocateur
C) Une hypertrophie ventriculaire gauche de type surcharge diastolique peut être notée à l'ECG
D)Une endocardite infectieuse ou une insuffisance cardiaque peuvent compliquer l'évolution
E)Un souffle systolique éjectionnel d'accompagnement est fréquent au foye aortique

47. Quel traitement anti - hypertenseur est à instaurer , en première intention et en l'absence de contre - indication , lorsque l'HTA est associée à une insuffisance coronarienne ?

A) Inhibiteur de l'enzyme de conversion
B) Inhibiteur calcique
C) Diurétique
D) Alpha - bloquant
E) Bêta - bloquant

48. L'exploration fonctionnelle respiratoire au cours d'un asthme peut montrer :

A) Un trouble ventilatoire obstructif avec un VEMS < 80 % / ou un rapport VEMS / CVF < 80 %
B) Un VEMS et un VEMS / CVF normaux
C) Un aspect concave de la courbe débit volume signifie l'existence d'un trouble ventilatoire obstructif J
D) Une diminution du VEMS qui s'améliore après inhalation de bronchodilatateurs E) Le test de réversibilité peut montrer une amélioration du VEMS de 16 % par rapport au VEMS de base .

49. Au cours d'une primo infection tuberculeuse patente , la radiologie thoracique de face peut montrer : (RF)

A) Des adénopathies hilaires polycycliques uni ou bilatérales
B) Des traînées linéaires reliant l'adénopathie hilaire au chancre d'inoculation
C) Une image de caverne tuberculeuse .
D) L'association adénopathie hilaire , chancre d'inoculation et lymphangite constitue le complexe primaire de tuberculose .
E) Image rétractile segmentaire .

50. En cas de rétinopathie diabétique , le traitement par photocoagulation au laser a pour but de : (RJ)

A) Détruire les microanévrysmes
B) Eclaircir le vitré en cas d'hémorragie
C) Détruire les zones de rétine ischémique
D) Eviter l'apparition d'une névrite optique
E) Aucune des propositions n'est exacte

51. La crise glaucome aigu par fermeture de l'angle survient le plus souvent chez des sujets biométriquement prédisposés . Quelle est la nature de cette prédisposition ? (RJ)

A) La myopie simple
B) La presbytie
C) L'astigmatisme
D) L'hypermétropie
E) La myopie maladie

52. Le polype saignant de la cloison est :

A) Plus fréquent chez la femme enceinte
B) Traité par la chirurgie
C) Une tumeur de la puberté masculine
D) Révélé souvent par des épistaxis
E) Développé au niveau de la cloison nasale

53. Quand on suspecte une maladie coeliaque l'examen à faire en intention pour asseoir le diagnostic est : (RJ)

A) Endoscopie oeso - gastroduodénale avec biopsies intestinales
B) Dosage pondéral des IgG anti transglutaminase
C) Recherche des IgA anti endomysium
D) Dosage pondéral des IgA anti transglutaminase
E) Génotypage HLA

54. Concernant l'atrésie de l'œsophage , toutes ces propositions sont justes sauf une : (RJ)

A) Le type la classification de oesophagienne fistule
B) Le diagnostic est suspecté devant des vomissements bilieux avec abdomen plat
C) Le diagnostic est suspecté en salle de naissance devant précoce avec hyper salivation D) Le diagnostic est confirmé par l'épreuve à la sonde
E) La radiographie thoraco - abdominale permet de déterminer le type de l'atrésie selon l'aération d'aval

55. La drépanocytose :

A) Est une maladie autosomique récessive
B) Caractérisée par la survenue de crises douloureuses osseuses
C)L'électrophorèse de l'Hb retrouve un taux d'HbS à 80 % chez l'hétérozygote
D) Chez les patients homozygotes , l'électrophorèse de l'hémoglobine montre une absence d'HbA
E) Caractérisée par une susceptibilité accrue aux infections

56. L'anémie de Cooley RJ)

A) Est la forme grave de la Béta - thalassémie
B) Est caractérisée par la déformation en faucille des hématies
C) Est due à un déficit de synthèse de chaines alpha de l'hémoglobine
D) Se complique souvent d'une atrophie splénique
E) La complication majeure est une carence en fer

57. Chez un hémophile en cas de saignement , l'une de ces localisations engage le pronostic vital immédiat , laquelle ? (RJ)

A) Hémarthrose cheville
B) Gingivorragies
C) Hématome de la base de la langue
D) Hématurie X
E) Epistaxis

58. Le diagnostic d'aplasie médullaire est confirmé par : (RJ)

A) Médullogramme .
B) Cytométrie en flux .
C) Biopsie ostéo - médullaire .
D) Hémogramme .
E) Frottis sanguin

59. L'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle : (RF)

A) Elle est secondaire à une diminution de la perfusion rénale
B) Elle est souvent réversible
C) Elle se complique d'une unnécrose tubulaire aiguë si retard de traitement
D) Elle survient sur un parenchyme rénale sain
E) La fraction d'excrétion de l'urée > 35 %

60. Concernant l'insuffisance rénale aiguë obstructive : (RF) A) Antécédents urologiques

B) Elle s'accompagne d'une dilatation des voies excrétricesu
C) Le drainage des urines constitue une urgence urologique
D) La correction du syndrome du levée d'obstacle est obligatoire
E) L'anurie est quasi constante

61. La sclérose en plaques :

A) Une affection inflammatoire exclusive du système nerveux central
B) Trois fois plus fréquente chez la femme
C) Ne touche jamais le sujet après 60 ans
D) Evolue souvent vers un handicap quand elle ' est pas traitée
E) La forme rémittente est la plus fréquente

62. Concernant le syndrome de Guillain - Barré : (RF)

A) Evolution en 3 phases
B) Augmentation isolée de la protéinorachie
C) La forme axonale est la plus fréquente
D) La forme axonale est de moins bon pronostic
E) L'évolution est favorable dans la majorité des cas

63. Le syndrome parkinsonien comporte : (RF)

A) Un tremblement de repos
B) Des troubles cognitifs débutants
C) Une rigidité plastique
D) Une akinésie
E) Le signe de l'oreiller psychique

64. Tous ces signes évoquent une hypertension intracrânienne (HIC) , sauf un : RJ)

A) Céphalées frontales réveillant le patient
B) Présence d'un cedème papillaire
C) Vomissements faciles
D) Nécessite toujours la mesure de la pression intracrânienne
E) La neuro - imagerie (TDM et IRM cérébrale) peut être normale

65. Le dosage de l'HCG plasmatique est utile dans : (RF)

A) Diagnostic précoce de la grossesse
B) Pronostic d'évolution d'une grossesse évolutive intra utérine
C) Diagnostic de la grossesse extra - utérine
D) Surveillance de la guérison des moles hydatiformes
E) Surveillance de certains cancers ovariens traités

66. Le profil hormonal de la ménopause : (RF)

A) La FSH est élevée
B) La LH est élevée
C) Le taux de prolactine est élevé
D) La progesterone est basse E) Les œstrogènes effondrées

copyMal

67. La phase hydro - électrolytique lors d'une brûlure thermique : (RJ)

1 Est la 2 ème phase de la brûlure
2) Dure 3 jour
3 Une augmentation des besoins métaboliques est observée cette phase
4) Engagé le pronostic vital
5)intérêt de remplissage vacsculaire a temps
A(2.3). B (4.5). C(1.4.5). D(3.5). E(1.2.3)

68. L'incision de décharge se fait : (RF)

A) Devant toute brûlure profonde
B) Sans anesthésie
C) En éventail avec respect des commissures de la main
D) Dans les brûlures profondes circonférentielles
E) Avant la 6ème heure villon

69. La complication la plus fréquente d'une fracture pertrochantérienne est : (RJ) :

A) La nécrose de la tête fémorale
B) La pseudarthrose du col du fémur
C) La coxarthrose
D) Le cal vicieux
E) La paralysie du nerf sciatique

70. La forme de luxation de hanche post traumatique la plus fréquente est : (RJ)

A) Illiaque
B) Ischiatique
C) Pubienne
D) Obturatrice
E) Centrale

71. La classification de NEER est : (RF)

A) Une classification basée sur le nombre de fragments L
B) Elle comprend uniquement les fractures articulaires ,
C) Dans chaque type , la fracture peut être associée à une luxation
D) Dans le type IV le tubercule majeur est atteint
E) La classification pour les fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus

72. Dans le traitement des fractures des deux os de l'avant - bras , il est indispensable de rétablir les critères de la prono - supination ; lequel de ces critères est incorrect : (RJ)

A) La continuité et l'inégalité des deux os de l'avant - bras
B) Intégrité des articulations radio - ulnaire supérieure et inférieure
C)Courbure pronatrice du radius
D) Courbure pronatrice de l'ulna E) Intégrité de la membrane interosseuse

73. Une ostéomyélite aiguë en l'absence de traitement peut évoluer en : (RJ)

A) Pandiaphysite
B) Nécrose osseuse
C) Abcès de Brodie
D) Guérison
E) A , B , C sont justes

74. La prévention des raideurs articulaires fait appel à toutes ces mobilisations : (RF)

A) Mobilisations passives intempestives
B) Mobilisations actives aidées
C) Contractions isométriques
D) Mobilisations actives
E) Mobilisation par arthromoteur

CopyWal Pavillon-18
-a l'interieur de la fac usdb (Pavillon-18)
-en face des amphis médecine (pav-29)

75. L'immobilisation prolongée est responsable de : (RF)

A) Diminution de la masse osseuse
B) Augmentation de la calciurie
C) Diminution de la calcémie . Peny
D) Prolifération du tissu fibro - graisseux intra articulaire
E) Fonte musculaire importante

76. Quelle affirmation concernant la famille thérapeutique de l'haloperidol est juste ? (RJ)

A) Il fait partie de la famille des tranquillisants (Benzodiazépines) .
B) Il fait partie de la famille des thymorégulateurs
C) Il fait partie de la famille des neuroleptiques
D) IIfait partie de la famille des antidépresseurs
E) Il fait partie de la famille des hypnotiques

77. Le syndrome de Cotard peut se retrouver dans : (RJ)

A) La paranoïa
B) La phobie
C) La mélancolie
D) Le trouble obsessionnel - compulsif
E) La psychopathie

78. Les phénomènes dyskinétiques oculo - faciaux sont couramment observés lors de l'introduction d'une chimiothérapie par : (RJ)

A) Antidépresseur I.M.A.Q
B) Sels de lithium
C) Neuroleptiques
D) Benzodiazépines
E)Hypnotiques

79. Parmi les classes thérapeutiques suivantes , laquelle peut entrainer un syndrome - malin : (RJ)

A) Les tranquillisants (Benzodiazépines)
B) Les antidépresseurs
C) Les thymorégulateurs
D) Les neuroleptiques
E) Les hypnotiques

80. L'état de stress post traumatique peut comporter les symptômes suivants (RF)

A) Les cauchemars
B) Les réactions de sursaut
C) Le flash back
D) Des conduites d'évitement
E) Une dissociation Pavillon

Cas clinique N ° 01

Un ouvrier se présente en consultation dans un tableau de toux et de dyspnér L'interrogatoire révèle qu'il s'occupe , des moules dans une fonderie . depuis 20 ans , du nettoyage du fourEt des moules dans une fonsses

81 - Cet ouvrier est exposé aux : (RJ)

A) Poussières d'amiante
B) Poussières de silice
C) Poussières de fer
D) Poussières de charbon
E) Toutes ces réponses sont fausses

82- Une radiographie thoracique réalisée montre la présence d'opacités micronodulaires bilatérales et une EFR montre un syndrome restrictif .
s'agit d'un tableau de : (RJ)

A) Bronchite chronique
B) Pneumoconiose au stade I
C) Pneumoconiose au stade II .
D) Pneumoconiose au stade III
E) D'un cancer bronchique

83- Devant ce tableau clinique et para - clinique , le médecin du travail est en droit de le déclarer : (RJ)

A) En maladie à caractère professionnelle
B) En maladie professionnelle N ° 30 .
C) En maladie professionnelle N ° 25
D) En maladie professionnelle N ° 44
E) En maladie professionnelle N ° 65

84 - Parmi les prérogatives du médecin du travail : (RJ)

1) Etablir un certificat initial de déclaration /
2) Préconiser une reprise du travail pour ce salarié avec port de moyens de protection
3) Ecarter le salarié de son poste de travail
4) Mettre en place un traitement symptomatique
5) Toutes les réponses sont justes
A (1 , 3 , 4) B (1 , 2 , 4) C (2 , A) D (1 , 3) E (5)

85- L'imprimé de déclaration de sa maladie professionnelle , établi par le médecin , doit comporter obligatoirement : (RJ)

1) les affections constatées figurant sur le tableau de la maladie professionnelle concernée
2) Le N ° du tableau
3) Il doit être établi en 2 exemplaires
4) La nature du travail ayant entrainé l'exposition au risque 5) Le délai de prise charge
A (1 , 2 , 4) B (1,2,3) C (1,2 , 3 , 4) D (1 , 2) E (1,2,4,5)

86- Diagnostics possibles , sauf : (RJ)

A) Un ulcère de cornée
B) Une uvéite antérieure
C) Un abcès de cornée
D) Une conjonctivite bactérienne
E) Une crise d'hypertonie oculaire

A l'examen ophtalmologique : cedème cornéen , une chambre antérieure étroite , une pupille en semi - mydriase aréflexique , un tonus oculaire à 45 mm d'Hg , des opacités cornéennes .

87 Le diagnostic retenu : (RJ)

A) Glaucome à angle ouvert
B) Uveite antérieure
C)Crise de glaucome aigu par fermeture de l'angle
D) Kératite virale
E) Endophtalmie

88 - Devant ce tableau clinique , le traitement est : (RJ)

A) D'emblée chirurgical
B) Basé sur une simple surveillance car la crise peut regresser spontanément
C) Médical dans le cadre de l'urgence
D) Physique (laser) ou chirurgical aprés normalisation du tonus oculaire
E) C + D

89- Le traitement : (RF)

A) Mannitol 20 % en IV , diamox en IV avec relai per os
B) Pilocarpine en collyre
C) Iridotomie au laser Yag
D) Hypotonisants en collyre
E) Mydriaticum villon

90- Au niveau de l'œil adelphe , il faut : (RF)

A) Examiner l'angle (gonioscopie)
B) Mesurer le tonus oculaire lors des contrôles
C) Faire une iridotomie préventive au laser
D) Surveiller régulièrement
E) Aucune mesure ne s'impose

CAS CLINIQUE N °03

Au cours d'une garde , un sujet âgé de 48 ans est évacué par sa famille au pavillon d'urgence à la suite d'un malaise subit . L'examen clinique retrouve un sujet inconscient avec pouls imprenable et tension artérielle effondrée .

91. Votre conduite à tenir est la suivante : (RJ)

A) Faire l'interrogatoire avec la famille à la recherche d'antécédents
B) Entreprendre une recherche étiologique
C) Rétablir les constantes hémodynamiques
D) Rechercher les signes précoces de la mort
E) Demander au préalable le consentement de la famille avant toute initiative

92. La réanimation est - elle justifiée dans ce cas sur le plan légal ? (RJ) .

A) La réanimation doit être poursuivie pendant au moins 15 min
B La réanimation doit être poursuivie pendant au moins 30 min
C) Il n'y a plus lieu de poursuivre une réanimation dans ce cas
D) La réanimation ne sera arrêtée qu'à l'apparition des signes précoces de la mort
E) Les réponses B et D sont justes

93. Malgré les mesures de réanimation entreprises , le patient décède . La conduite immédiate du praticien dans ce cas est la suivante : (RJ)

A) Rédaction du certificat médical du constat de décès
B) Annonce du famille du patient
C) Interrogatoire de la famille à propos des antécédents du patient
D) S'abstenir de toute démarche en attendant une réquisition judiciaire , la mort étant suspecte dans ce cas
E) Faire appel au service de médecine légale

94. La rédaction du certificat de constat de décès devra être établie : (RF)

A) Uniquement par le médecin ayant constaté le décès
B) Immédiatement après la constatation de la mort
C) 2 heures après la constatation de la mort
D) Obligatoirement après examen externe du cadavre
E) Sur un document spécial prévu à cet effet

95. Au cours de l'examen du corps , des traces de violences à type d'ecchymoses multiples et récentes sont retrouvées au niveau des avant - bras . Le certificat médical de constat de décès : (RJ)

A) Ne doit être établi dans ce cas que sur réquisition judiciaire
B) Doit être remis à l'administration hospitalière
C) Comporte un descriptif détaillé des traces de violences retrouvées
D) Doit être remis à la famille
E) Ne peut être établi que par un médecin légiste

Cas clinique N ° 04 Un nourrisson de 5 mois est amené aux urgences pour une diarrhée aiguë évoluant depuis la veille , précédée par une infection des voies aériennes supérieures . Il presente 6 selles liquides aqueuses par jour , Poids = 7 , 200 Kg pas de signes de déshydratation . Diététique : sous allaitement mixte et une soupe de légumes par jour . Le lait artificiel est reconstitué à raison d'une cuillère mesure pour 30 cc d'eau .

96. Le diagnostic . le plus probable est une : (RJ)

A)Diarrhée virale
B) Diarrhée à Esherichia coli entero - invasif
C) Diarrhée à shigella
D) Diarrhée à Esherichia coli enterotoxinique
E) Diarrhée en rapport avec une mauvaise reconstitution du lait

97) Vous prescrivez des sels de réhydratation ; quelles sont les modalités préparation de conservation d'administration :

A) Diluer le sachet dans un litre d'eau bouillie et refroidie
B) La solution doit être conservée au frais
C) La solution doit être renouvelée au bout de 24 heures
D)La solution est donnée à la cuillère , en petites quantités et à intervalles brefs
E) Avant son refroidieadministration à l'enfant la solution reconstituée doit être bouillie et refroidie

98. La quantité de sels de réhydratation à administrer est de : (RJ)

A) 50 100 cc après chaque selle liquide
B) 100-200 cc après chaque selle liquide
C) 200-300 cc après chaque selle liquide
D) 200-400 cc après chaque selle liquide
E) 400-600 cc après chaque selle liquide

99. Aux sels de réhydratation , vous associez le traitement suivant : (RJ)

A) Cotrimoxazole à raison de 10 mg / Kg / j de Trimethoprime
B) Ceftriaxone 50 mg / Kg / j
C) Azithromycine 10 mg / Kg / j
D) Ampicilline 100 mg / Kg / j
E) Aucun de ces traitements n'est indiqué Villon

100. Au plan diététique vous préconisez : (RJ)

A) L'arrêt de toute alimentation
B) L'arrêt du lait maternel et le maintien du lait artificiel en le diluant
C) L'arrêt du lait maternel et le maintien du lait artificiel à la même concentration
D)Le maintien de son régime actuel
E)La prescription d'un lait de régime Villon

Cas clinique N ° 05

Vous êtes de garde et vous recevez une vielle patiente de 75 ans diabétique hypertendue équilibrée qui vient de faire une chute de sa hauteur ayant occasionné un traumatisme fermé de sa hanche droite . C'est une patiente autonome auparavant . Le bilan clinique vous oriente vers un traumatisme de hanche droite ; la radiographie objective une fracture du col fémoral avec un de fracture oblique séparant la tête fémorale du col , les travées osseuses so décalées avec un déplacement important et complet avec un angle cervico diaphysaire inférieur à 120 °

101. il s'agit d'une : (RJ)

A) Fracture du col fémoral GARDEN II
B) Fracture du col fémoral GARDEN III
C) Fracture du col fémoral GARDEN IV - LAMAR 1
D) Fracture du col fémoral GARDEN I
E) Fracture du col fémoral GARDEN IV LAMAR 2

102. Vous décidez : (RJ)

A) De confier la malade en médecine pour traiter son HTA et diabète , c'est plus urgent
B) De traiter la fracture par une botte anti rotatoire , le traitement de ces fractures n'est que orthopédique
C) D'hospitaliser la patiente de la mettre sous traction vous avez le temps pour l'opérer
D) D'hospitaliser la patiente de la mettre dans des conditions idéales pour une intervention chirurgicale rapide
E) D'expliquer aux parents que cette patiente doit rentrer chez elle , la mettre dans un lit car la fracture consolide facilement

103. Le but du traitement chez cette patiente est : (RJ)

A) De faire consolider la fracture
B) Eviter l'ostéonécrose de la tête fémorale
C) De faire lever la patiente et éviter les complications du décubitus
D) De rétablir l'anatomie de l'extrémité supérieure de fémur
E) D'équilibrer son diabète et son hypertension

104. Quelle est la meilleure indication pour cette patiente : (RJ)

A) Mettre une prothèse cervico - céphalique de remplacement

B) Réduire le foyer de fracture et le fixer par une vis plaque type DHS

C) Réduire le foyer de fracture et le fixer par un vissage en triangulation

D)Faire un traitement radical et mettre une arthroplastie totale de la hanche

E) Réduction de la fracture et stabilisation par un clou plaque

105. Parmi ces complications une seule ne peut se voir dans ce type de traitement : (RJ)

A) Luxation de la prothèse

B) Escarres

C) Infection post - opératoire

D) Nécrose de la tête fémorale

E) Descellement de la prothèse

CAS CLINIQUE N ° 6 Un patient de 42 ans présente depuis 3 jours une tuméfaction sub mandibulaire gauche douloureuse . Elle est apparue lors d'un repas . Elle a partiellement régressé à la fin du repas , mais récidive depuis transitoirement chaque repas . L'interrogatoire ne met en évidence aucun antécédent particulier et n'apporte aucun élément d'information complémentaire .

106. Quel est l'examen clinique spécifique qui peut rattacher cette tuméfaction à la glande sub - mandibulaire : (RJ)

A) Examen du plancher buccal

B) Examen du cou

C) Examen échographique de la glande sub - mandibulaire

D) Le palper bidigital du plancher buccal et de la région sub - mandibulaire

E) La percussion de la région sub - mandibulaire

107. Ce tableau clinique correspond à : (RF)

A) Une colique salivaire due un arrêt transitoire de l'écoulement de la salive

B) Une hernie salivaire douloureuse

C)Une colique salivaire due à une lithiase du Sténon

D) Une tumefaction sub - mandibulaire qui change de volume et rythmée par les repas

E) Un spasme au niveau du canal de Wharton

108. Quels sont les examens complémentaires à demander initialement : (RJ)

A) Une TDM et une IRM .

B) Une échographie cervicale et IRM .

C) Un orthopantogramme et une sialographie .

D) Un orthopantogramme , une échographie cervicale et une sialographie

E) Une sialographie et une IRM

109. Quels sont les éléments qui seront négatifs à la radiologie standard et révélés à l'échographie cervicale : (RJ)

A) Un calcul au niveau du bassinet de la glande

B) Un calcul intra glandulaire

C) Une glande remaniée

D) Un calcul radiotransparent

E) C + D 1

110. Ce malade n'a pas été pris en charge à temps . II a fait toutes les complications de cette pathologie parmi ces traitements lequel ne correspe pas à ce cas :

A) Ablation du calcul par voie endobuccale

B) Drainage d'une cellulite sub - mandibulaire

C) Drainage d'une cellulite du plancher buccal

D) Sub - mandibulectomie et un curage ganglionnaire

E) Traitement antibiotique et une sub – mandibulectomie

DOSSIER CLINIQUE

Madame XY âgée de 38 ans , G3P0A2 , B RH * , enceinte de 35 SA consulte au pavillon des urgences métrorragies de petite abondance .

111- Quels sont les diagnostics à évoquer

1) Placenta prævia 1
2) Hématome retro placentaire
3) Menace d'accouchement prématuré
4) Hémorragie de benkiser.

A (1 , 2 , 3) B (1,2 .4) E (1.2) C (2 , 3 , 4) D (1 , 3 , 4)

pâleur cutanéo L'examen retrouve une patiente consciente coopérante avec muqueuse TA 14/09 cm Hg , pouls 90 bats / min . Des CU faibles avec mauvais relâchement , BCF absents

112. Quel est le diagnostic le plus probable ? (RJ)

A) Placenta prævia
B) Hématome retro placentaire C) Rupture utérine
D) Menace d'accouchement prématuré
E) Hémorragie de Benkiser

113- . Quelles sont les complications à redouter ?

1) COVID
2) insuffisance rénale
3) RCIU
4)Embolie pulmonaire
5)mort foetale

A(1.3.5). B(2.3.4). C(1.2.5). D(3.4.5). E(1.2.4)

114. Quels sont les gestes à faire dans l'immédiat ? (RJ)

1) Expectative
2) Voies d'abord
3) Mesures de réanimation
4) Césarienne V Har
5) Déclenchement artificiel du travail

A (1 , 2 , 3) B (2 , 3) C (2 , 3 , 4) D (3,5) E (1 , 2)

La patiente accouche à 14h d'un nouveau - né mort de sexe masculin pds 1800 gr ; à 18h l'infirmière appelle et signale que la post accouchée présente une pâleur extrême et des sueurs . L'examen retrouve une patiente consciente . TÄ : 10/05 cm Hg , un pouls à 120 bats / min . un saignement génital de moyenne abondance .

115. Quel est le diagnostic le plus probable ? (RJ)

A) CIVD
B) Rupture utérine
C) Hémorragie de la délivrance
D) Dechirure cervicale
E) Déchirure vaginale

116. Que va révéler l'examen gynécologique dans ce cas ? (RJ)

A) Le signe du matelas au TV
B) Une solution de continuité à la RU
C) Absence du globe utérin de sécurité à la palpation
D) Un col cerclé comme par un fil de fer au TV
E) Un utérus en sous ombilical

117. Quelle est votre conduite à tenir dans ce cas ? (RJ)

A) Massage utérin
B) Perfusion d'ocytociques
C) Réanimation médicale
D) Révision de la filière génitale E) Toutes les réponses sont justes

Le bilan biologique retrouve une hémoglobine à 7 g / dl , une créatininémie à 30 mg / l et TP à 40 % .

118- Quelles sont les complications à redouter ? (RJ)

1) Une embolie pulmonaire
2) Une insuffisance rénale aiguë
3) Une CIVD
4) Un choc hypovolémique
5) Une thrombose des membres inférieurs

A (1,2,3) B (1,3,4) C (3,4,5) D (2,3, 4) E (2 , 4 , 5)

La patiente est portée sortante 5 jours après son accouchement .

119) Quels sont les moyens de contraception que vous pouvez lui prescrire?

1) Une pilule cestro - progestative
2) Une pilule micro progestative
3) Les préservatifs
4) Une pilule macro progestative
5) Le DIU au cuivre

A (1,4 , 5) B (2 , 3 , 5) C (2 , 3) D (1,3 , 5) E (1,2,3)

12 mois après l'accouchement, la patiente est toujours en aménorrhée .

120. Quelle est la complication redoutée ? (RJ)

A) Synéchie utérine
B) Syndrome de Sheehan
C) Une endométrite
D) Une hyperprolactinémie
E) Une hypothyroïdie

CopyWal Pavillon-18
-a l'interieur de la fac usdb (Pavillon-18)
-en face des amphis médecine (pav-29)

CT Résidanat Février 2022

Question	Réponse	Question	Réponse	Question	Réponse	Question	Réponse
1	**B**	31	**B**	61	**C**	91	C
2	**A**	32	**E**	62	**C**	92	E
3	**D**	33	**B**	63	**B**	93	B
4	**A**	34	**A**	64	**A**	94	B
5	**D**	35	**E**	65	**B**	95	D
6	**C**	36	**E**	66	**C**	96	A
7	**D**	37	**D**	67	**B**	97	E
8	**C**	38	**C**	68	**A**	98	E
9	**D**	39	**B**	69	**D**	99	E
10	**A**	40	**D**	70	**A**	100	D
11	**C**	41	**B**	71	**B**	101	E
12	**E**	42	**A**	72	**D**	102	D
13	**B**	43	**B**	73	**E**	103	C
14	**D**	44	**B**	74	**A**	104	A
15	**A**	45	**D**	75	**C**	105	D
16	**E**	46	**AB !**	76	**C**	106	D
17	**A**	47	**E**	77	**C**	107	B
18	**B**	48	**B**	78	**C**	108	D
19	**B**	49	**C**	79	**D**	109	E
20	**E**	50	**C**	80	**E**	110	D
21	**D**	51	**D**	81	**B**	111	A
22	**A**	52	**C**	82	**C**	112	B
23	**E**	53	**D**	83	**C**	113	C
24	**C**	54	**B**	84	**A**	114	C
25	**B**	55	**C**	85	**A**	115	C
26	**A**	56	**A**	86	**D**	116	C
27	**A**	57	**C**	87	**C**	117	E
28	**A**	58	**C**	88	**E**	118	D
29	**E**	59	**E**	89	**E**	119	C
30	**C**	60	**E**	90	E	120	B

COPYMAI

Université Saad Dahlab Blida
Faculté de Médecine

Concours de Résidanat Session Mars 2021
Durée de l'épreuve : Trois heures

Note d'information

-Ce questionnaire comporte 120 QCM dont les pages sont numérotées de 1 a 22
-les QCM sont réparties de la maniéré suivante.
-les QCM comportent chacune cinq propositions de A a E.
-les candidat soit cocher sur le grille de réponses uniquement une proposition (réponse juste RJ ou réponse fausse –RF)

CopyWal Pavillon-18
-a l'interieur de la fac usdb (Pavillon-18)
-en face des amphis médecine (pav-29)

1. L'apoptose : (RF)

A) Est une mort cellulaire accidentelle

B) Est une mort cellulaire physiologique

C) Est une mort cellulaire programmée

D) Touche un groupe de cellules E) Est génétiquement déterminée

2. La transformation d'un tissu en un autre tissu de morphologie et de fonc différentes correspond à : (RJ) A) Une dystrophie

B) Une hétérotopie

C) Une métamorphose

D) Une dégénérescence Une métaplasie .

3. Les anti - oncogènes agissent : (RJ)

A) En phase M

B) En phase G1 / S

C) En phase S

D) En phase GO <

E) En phase G1 .

4. Parmi les colorations spéciales suivantes , quelle est celle qui doit étudiée en lumière polarisée : (RJ)

A)Trichrome de Masson

B) Rouge Sirius

C) Acide Périodique de Schiff D)Rouge Congo

E) Bleu Alcian

5. L'étude microscopique d'un revêtement cutané retrouve une collection d macrophages contenant dans leur cytoplasme un pigment coloré en bleu p coloration de Paris. L'étiologie la plus probable de ce pigment est : (RJ)

A) Une accumulation anormale de protéines

B) Un pigment lipofushinique

C)Un traumatisme antérieur responsable d'hémorragies

D) Des résidus de tatouage

E) Une accumulation normale de mélanine

06. En Immuno - histochimie tous cas anticorps sont à expression cytoplasmique , sauf un loquel ? : (RJ)

A) Desmine

B) Neurofilament

C) Vimentine

D) Cytokératine

E) CD3

07 - Les vraies cordes vocales du taryas: (RF)

A) Ce sont les cordes vocales inférieures .

B)Sont tapissées d'épithélium cylindrique Elite .

C) Contiennent des formations lymphoïdes

D)Contiennent des formations glandulaires .

08- La parel des bronchioles pulmonaires : (RF)

A) Comporte un épithélium simple cilié .

B)Comporte des cellules de Clara .

C) Comporte des fibres musculaires lisses .

D) Comporte des glandes de type moqueux .

E) Ne comporte pas du cartilage .

09 - Dans le système artériel : (RF)

A)La média des grosses artères élastiques ne comporte pas de muscle lisse .

B) Les artères musculaires comportent deux limitantes élastiques.

C) Les vasa vasorum irriguent

D) Les artères élastiques sont des vaisseaux de conduction . E)intima de l'artère élastique comporte une couche mucoide.

.

10- Les peroxysomes : (RF)

A) Libèrent de la chaleur .

B) Ont des fonctions anaboliques et cataboliques .

C)Produisent de l'H_2O_2 .

D)Assurent la dégradation des acides biliaires .

E)Peuvent causer l'adrénoleucodystrophie

11 - Les antibiotiques ayant une bonne concentration au niveau des méni ..... et efficaces pour le traitement des méningites purulentes sont : (RJ) .

A) Aminosides .

B) Glycopeptides .

C) Cephalosporines 3G .

D)Macrolides .

E) Fluoroquinolones .

12 - La présence d'un bacille à Gram négatif dans un LCR pratiqué chez un nouveau - né hospitalisé depuis 04 jours vous oricate vers l'étiologle bactérienne suivante : (RJ) .

A) Staphylocoque aureux .

B)Escherichia coli .

C)Pseudomonas aeruginosa .. D)Heamophilus influenzae .

E)Chlamydia trachomalis .

13. L'Infection nosocomiale se transmet le plus souvent par : (RJ)

A) Voie aéro - portée

B) Vole manu - portée

C) L'intermédiaire d'instruments mat stérilisés

D) L'intermédiaire d'une eau souillée

E)Toutes ces propositions sont justes

13. L'Infection nosocomiale se transmet le plus souvent par : (RJ)

A) Voie aéro - portée

B) Vole manu - portée

C) L'intermédiaire d'instruments mat stérilisés

D) IL'intermédiaire d'une eau souillée

E)Toutes ces propositions sont justes

15. Le diagnostic de Tania saginata so fait le plus souvent par : (RJ)

A) La présence d'œufs du parasite dans les selles

B) La présence d'œufs du parasite sur un scotch test La présence d'anneaux trouvés dans les selles

D) La présence d'anneaux éliminés par le malade en dehors des selles

E) La vue du scolex du tænia

16. La bilharziose Schistosome) urogénitale est une parasitose : (RF)

A) Anthropologique retrouvée en Algérie .

B) Due à Schistosome hæmatobium .

C) Dont le diagnostic pendant la phase de migration larvaire repose sur la recherche des ceufs à éperon terminal au niveau des urines .

D) Se traduit sur le plan clinique essentiellement par une hématurie .

E) Contractée par voie transcutanée active .

17. La distomatose à Fasciola hepatica est une trématodose : (RJ)

A) Qui se manifeste cliniquement par une hépatite toxi - infectieuse au cours de la phase d'invasion .

B) Contactée par vole transcutanée.

C) Caractérisée par une hyper éosinophilie sanguine évoluant en dents de scie .

D) Dont le diagnostic est coproparasitologique pendant la phase d'invasion par la mise en évidence des œufs operculés au niveau des selles .

E) Non retrouvée en Algérie .

18. A propos des pédiculoses : (RF)

A) Sont des ectoparasitoses prurigineuses , contagieuses et cosmopolites .

B) La pédiculose de la tête touche surtout les enfants entrainant un prurit du cuir chevelu à prédominance rétro auriculaire et / ou occipitale .

C) La phthiriose due au Phthirius pubis est une infection sexuellement transmissible .

D)La pédiculose corporelle due au Pediculus capitis touche essentiellement E sujets sans domicile fixe (SDF).

E) leur diagnostic est assuré par la mise en évidence direct de l'ectoparasite cause .

19. Les parasitoses secondaires à une transmission transcutanée sont : (RF)

A)La distometose

B) La nécatorose

C) L'ankylostomiase

D) L'anguillulose

E) La bilharziose

20. Une des hormones suivantes interagit avec un récepteur à protéine G : (RJ)

A) L'insuline

B) L'atriopeptine

C) L'hormone de croissance

D)Le glucagon

E) La prolactine

21. Le facteur de stimulation de la sécrétion de rénine est : (RJ)

A) L'atriopeptine

B) Le facteur natriurétique auriculaire

C) l'angiotensine.

D) Les ß - mimétiques

E) L'augmentation du flux potassique

22 , La prostaglandine E2 exorce l'action biologique suivante : (RJ)

A) Abaisse le débit de filtration glomérulaire

B) Augmente la perméabilité vasculaire

C) Stimule la lipolyse

D) Induit le relâchement des muscles intestinaux et utérin

E) Provoque la contraction des muscles bronchiques et vasculaires

23. La baisse du volume du liquide extracellulaire entraîne une : (RJ)

A) Baisse de la sécrétion de l'arginine - vasopressine

B) Natriurèse

C) Antidiurèse

D) Baisse de l'osmolarité du liquide extracellulaire

E) Augmentation du volume sanguin efficace

24. Le Fibroblast Growth Factor - 23 (FGF - 23) : (RJ)

A) Est une hormone principalement sécrétée par le tissu adipeux

B) A une action phosphaturiante tubulaire proximale

C) Stimule la sécrétion de calcitriol

D) Sa sécrétion est inhibée par les phosphates

E) Se lie au récepteur sensible au calcium (CaSR)

25. L'élimination urinaire de potassium est stimulée par : (RF)

A) L'hyperkaliémie .

B) L'aldostérone .

C) Un pH alcalin

D)Un pH acide .

E) Un débit urinaire élevé .

26. Los signes ECG d'une hypokaliémie sont : (RF)

A) Affaissement de l'onde T

B) Onde T haute , pointue et symétrique

C) Augmentation d'amplitude de l'onde

D) Allongement de l'espace QU

E) Elargissement des complexes QRS .

27. Le principal mécanisme compensateur au cours du choc hypovolémie est : (RJ)

A) La baisse du débit cardiaque B)L'hyperréactivité adrénergique C) La libération de prostaglandines

D) La libération des kinines.

E) L'activation du facteur dépresseur myocardique

28. L'insuffisance rénale aigué est définie par une : (RF)

A)Diminution brutale de la filtration glomérulaire

B)Augmentation de la créatinine plasmatique .

C) Augmentation de l'urée sanguine

D)Anurie

E)Anémia

29. Les effets indésirables des médicaments de type A : (RJ) A) Sont dose dépendants

B) Sont rares mais mortels

C)Nécessitent l'arrêt définitif du médicament chez le patient

D) Ne sont pas détectés dans les essais pré cliniques et cliniques .

E) Surviennent après une prise chronique du médicament .

30. L'intoxication par l'Amanita Muscaria donne les signes suivants , sau lequel ? : (RJ)

A)La mydriase

B)Le myosis

C) La diarrhée

D) Les nausées et vomissements

E) La sudation .

31 , Les myorelaxants curarisants sont indiqués dans les ((situations)) . sauf une , laquelle ? : (RJ)

A)Les crises d'asthme

B) Les interventions chirurgicales pour éviter une anesthésie trop profonde

C) L'intubation endotrachéale

D) Le traitement du tétanos

E) Chez les patients en ventilation artificielle contrôlée .

32. Chez un sujet diabétique , Indiquer le signe biologique qui caractérise précocement l'atteinte glomérulaire : (RJ)

A) Diminution de la clairance de la créatinine

B) Présence de germes dans les urines

C)Hématurie

D)Micro albuminurie

E) Augmentation des leucocytes plasmatiques

33. Le diabète de type 1 est lié à une diminution de la capacité de cellules bête du pancréas à produire l'insuline . Si une personne présente un DID oublie ses Injections d'insuline , elle présentera une : (RJ)

A) Augmentation de la synthèse des acides gras à partir du glucose dans le foie

B) Diminution de la conversion des acides gras en corps cétoniques

C)Augmentation des stocks de triglycérides dans le tissu adipeux

D) Augmentation de la conversion de l'acéto - acétate en acétone

E) Aucune réponse exacte

34. Le syndrome de détresse respiratoire du nourrisson prématuré est lié au déficit pulmonaire en : (RJ)

A) Gangl oside

B) Sphingomyéline C)Prostaglandines

D) Cérébroside

E) Phosphatidyl – choline

35. La définition du stade SIDA Inclut : (RJ)

A)Un taux de lymphocytes T CD4 + inférieur à 200 / µ

B) Une forte concentration en IFN

C) Un taux d'immunoglobulines sériques supérieur à 30 g / l

D) Une activité NK très élevée

E) Un taux de ₂ macroglobuline inférieur à 2 mg /

36. Les Corécepteurs du VIH : (RF)

A) Sont représentés par le CXCR4 (fusine) sur les lymphocytes T CD4 +

B) Sont aussi représentés par le CCR5 sur les macrophages

C) Interagissent avec la glycoprotéine 120 du virus après sa liaison avec la molécule CD4

D) Sont des récepteurs des chimiokines permettant la fusion des membranes virale et cellulaire

E)Ne sont pas indispensables à l'infection de la cellule par le virus

37. Dans la maladie de Kahler , les géodes sont : (RJ)

A) Réparties préférentiellement sur les os des membres

B) Entourées d'une zone condensée

C)De contour irrégulier

D)Arrondie à limites nettes et à l'emporte pièce /

E) Aucune de ces propositions n'est juste

38. Parmi les examens complémentaires suivants , lequel n'expose pas médecin aux radiations lonisantes ? (RJ)

A) Coronarographie

B) Artériographie

C) Echographie

D) Cathétérisme cardiaque

E) Transit gastroduodénal

39. La tomodensitométrie (TDM) est un examen : (RF) A)De première ligne en cas de suspicion d'embolie pulmonaire chez une ferr-- enceinte

B) De première intention en pédiatrie

C) De choix dans le cadre de l'urgence

D) Très performant en pathologie utérine et annexielle

E) Qui ne représente pas la source majeure d'exposition aux rayonnements dans la population générale

40. A la radiographie standard tous les signes suivants sont en faveur e arthrose , sauf : (RJ) A)L'ostéocondensation sous chondrale

B) Le pincement articulaire

C) L'ostéophytose

D) Les géodes .

E)La déminéralisation péri - articulaire

41 - Afin de rechercher les facteurs de risque du cancer du poumon , une étude épidémiologique a inclus des malades atteints d'un cancer du poumon dans le premier groupe , un deuxième groupe est composé des sujets non cancéreux ; on a recherché les habitudes tabagiques chez les sujets cancéreux et les non cancéreux . Il s'agit d'une étude : (RJ)

A) Prospective

B) Descriptive

C)Essai thérapeutique

D)Cas témoins

E) De cohorte

42 - Si le taux d'incidence du cancer du poumon est de 285 pour 100 000 chez les gros fumeurs et de 15 pour 100 000 chez les non fumeurs . Quel est le risque relatif de faire un cancer du poumon chez les gros fumeurs par rapport aux non - fumeurs ? (RJ)

A) 15

B) 25

C) 19

D) 10

E) Aucune des valeurs précédentes

CopyWal
-a l'interieur de la fac usdb (Pavillon-18)
-en face des amphis médecine (pav-29)

43. Quels sont , parmi les éléments suivants , l'élément le plus spécifique du diagnostic de Covid - 19 chez une personne qui consulte pour une toux fébrile ? (RJ)

A) Une fièvre supérieure à 39 °

B) Des images pulmonaires atypiques en tomodensitométrie.

C) L'anosmie

D) Une PCR Sars - CoV - 2 naso - pharyngée positive

E) Une lymphopénie

44. La fièvre boutonneuse méditerranéenne : (RF)

A) Est une éruption maculo - papuleuse

B) Est Transmise par piqûre de tique de chien .

Est une maladie saisonnière hivernale

D) La fièvre est présente à 100 %

E) La présence de la tache noire permet le diagnostic

45. Les septicémles à staphylocoque : (RJ)

A) Ont un point de départ digestif

B) Il n'existe pas de porte d'entrée

C)Les métastases septiques sont d'apparition rapide

D)Nécessite un traitement antibiotique urgent à base d'Amoxicilline

E) Sont des sepsis bénins dans leur évolution .

46. Où recherchez - vous le signe de Koplik qui affirme la rougeole ? (RJ)

A) Sur les piliers des amygdales

B) Sur le voile du palais

C) Sur la paroi antérieure du pharynx

D)A la face inférieure de la langue

E)A la face interne des joues

47. L'Impétigo : (RJ)

A) Est une affection peu fréquente chez l'enfant

B) Son aspect clinique est non spécifique

C) Réalise des lésions bulleuses au niveau des zones de frottement

D) Sa localisation au niveau des mains doit faire suspecter une gale humaine

E) Est une affection immunisante .

48. Le rétrécissement aortique donne à l'auscultation : (RJ)

A) Souffle systolique en jet de vapeur , timbre doux , apexien , irradiant à l'aisselle .

B) Souffle systolique , timbre doux , xiphoidien , augmente l'inspiration profonde irradie peu .

C) Souffle diastolique , timbre algu , 2me espace intercostal droit , irradiant à la point et la xipholde .

D) Souffle systolique éjectionnel , rude , râpeux , maximum au 2e espace intercostal droit , irradiant aux valsseaux du cou et à la pointe .

E) Roulement diastolique , timbre grave , apexien .

49. Le roulement de Flint est : (RF)

A) Un souffle diastolique . B)Audible au 2e espace intercostal droit .

C) En rapport avec une sténose mitrale fonctionnelle

D) Un des signes auscultatoires possibles en cas d'insuffisance aortique .

E) Le témoin de la sévérité de la valvulopathie .

50. Le Diagnostic clinique de la phlébite sous - poplitée ou surale : (RF)

A) Signes unilatéraux au niveau d'un mollet et d'installation progressive , douleur à 1 marche

B) Douleur spontanée et provoquée (Homans)

C)Palpation des masses musculaires recherchant un cordon veineux

D) œdème discret , rétro malléolaire

E) Fièvre très élevée

51. Le marqueur BNP (Peptide Natriurétique de type B) est élevé dans toutes ses situations sauf une : (RJ)

A) Insuffisance cardiaque
B) Anémie
C)Péricardite aiguë
D) Syndrome coronarien aigu
E) Embolie pulmonaire

52. Dans quelle affection trouve - t - on une réticulocytose élevée ? (RJ)

A) Carence vitamine B12 .
B) Leucémie aigue
C) Sphérocytose héréditaire
D) Aplasie médullaire
E) Myélome multiple

53. Chez un hémophile , quel est le signe clinique le plus Invalidant ? (RJ)

A) Bulles sanglantes B)Hématomes fessiers
C) Hémarthrose
D) Hématome de la cuisse
E) Hémorragie dentaire

54. La transfusion sanguine par du sang conservé est responsable de modifications biologiques : (RF) .

A) Hyperkaliémie
B) Hypercalcémie
C) Acidose
D) Diminution du pouvoir de coagulation
E) Hypoplaquettose

55. Quel est le marqueur biologique utilisable chez un patient opéré pour un cancer thyroïdien différencié : (RJ)

A) Antigène - carcino - embryonnaire ACC
B) Alpha - foetoprotéine
C) Thyrocalcitonine
D)Thyroglobuline
E) CA 19-9

56. Les anti - inflammatoires non stéroïdiens peuvent être responsables de toutes ces atteintes rénales sauf une , laquelle ? (RJ)

A) Une atteinte glomérulaire
B) Une atteinte tubuio - interstitielle aiguë
C)Une atteinte vasculaire
D) Une atteinte interstitielle
E)Une insuffisance rénale aigué fonctionnelle .

57. Tous ces signes appartiennent à la sémiologie cérébelleuse , sauf : (RJ)

A) Ataxie
B) Hypotonie
C) Adiadococinésie
D) Exagération des réflexes de posture
E) Dyschronométrie

58. Le maitre symptôme de la maladie de Parkinson est : (RJ) A)La rigidité extrapyramidale

B) Le tremblement de repos unilatéral
C)L'akinésie
D) La paralysie verticale de l'oculomotricité surtout vers le bas
E) Une démarche fostinante

59. Parmi les complications suivantes , laquelle n'est pas évocatrice d'une maladie de Horton ? (RJ)

A) Cécité brutale unilatérale
B)Glaucome aigu par fermeture de l'angle
C) Oblitération de l’artère centrale de la rétine
D) Neuropathie optique ischémique antérieure aigué
E) AVC ischémique dans le territoire vertébro - basilaire

60. L'hyphéma : (RF)

A)Est la présence du sang dans la chambre antérieure de l'œil ,

B)Est la présence de pus dans la chambre antérieure de l'œil C) Est la principal motif d'hospitalisation lors d'une contusion oculaire

D) A pour origine riris ou le corps cillaire

E) Son évolution est favorable dans 95 % des cas

61. Devant une tuméfaction cervicale módlane , Juxta hyoidienne ascensionne à la déglutition , quel diagnostic évoquer - vous? RJ)

A) Un kyste dermoïde .

B) Un llpome .

C)Un kyste du tractus thyréoglosse .

D) Une tumeur laryngée .

E) Une lithiase salivaire .

62. L'examen d'une parotidite algue peut objectiver du pus en regard : (RJ)

A) D'une fistule cutanée au niveau de la région parotidienne B) De l'ostium du canal de Sténon

C) De l'ostium du canal de Warthon

D) De l'amygdale pharyngée

E)Du conduit auditif externe

63. Un adulte Jeune présente l'association , trismus et otalgie , quel est le premier diagnostic à évoquer : (RJ)

A) Un tétanos

B)Un accident d'évolution de dent de sagesse

C) Una parotidite

D) Une otite moyenne

E) Un cancer de la pointe de la langue

64. Une lymphangite mammaire est responsable de tous les signes suivant sauf : (RJ)

A) Température à 40 ° C

B) Rougeur localisée en trainée rouge

C) Ganglions axillaires sensibles

D)Existence du pus dans le lait

E) Seins douloureux

65. Quel traitement préventif préconisez - vous à un nouveau - né de mère Ag Hb et Ag Hbg : (RJ)

A) Aucun traitement

B) Immunoglobulines polyvalente

C) Vaccination seule

D) Immunoglobulines spécifiques seules

E) Sérovaccination

66. Les substances suivantes sont susceptibles d'induire une hyperproiactinémie , sauf une laquelle ? (RJ)

A) Benzamides (Primpéran)

B) Phénotiazines (Largactil)

C) Analgésiques morphiniques

D) L dopa

E) Cimétidine

67. Pour préparer un biberon de 240 cc chez un nourrisson de 8 mois , is quantité de lait artificiel nécessaire est de : (RJ)

A) 8 cuillères -mesures de jalt de suite

B) 5 cuillères mesures de préparation pour nourrisson

C) 8 cuillères -mesures de préparation pour nourrisson

D) 4 cuillères mesures de préparation pour nourrisson

E) 8 cuillères - mesures de lait de croissance

68. Parmi toutes ces propositions concernant la progression du poids , de la taille et du périmètre crânien (PC) de l'enfant , laquelle est juste ? (RJ)

A) La taille augmente de 35 cm la première année

B) L'enfant double son poids de naissance à 5 mois et le triple à 12 mois

C) Le PC augmente de 1 cm par.mols les 6 premiers mois

D) La taille augmente de 50 cm la deuxième année

E) Le PC augmente de 0,5 cm par mois la première année de vie

Copy Mal

69. Chez un nouveau - né présentant une hypothermie , un ictère , des Pétéchies et un examen neurologique perturbé , le diagnostic que vous devez évoquer est : (RJ)

A) Une iso immunisation foeto - maternelle
B)Un ictère nucléaire
C)Une infection néonatale
D) Une asphyxie néonatale
E) Une maladie hémorragique du nouveau-né.

70-ilisble.

71. Concernant les méningiomes : (RF)

A) il s'agit d'une tumeur généralement bénigne
B)Ils o développent aux dépend des cellules arachnoïdiennes
C) Ils ne peuvent pas être à l'origine d'un syndrome de queue de cheva
D) Le plus souvent asymptomatiques
E) Le risque principal de affection est la récidive .

72. Le signe de Tinnel - Hoffman est un test permettant : (RF)

A) D'apprécier l'efficacité d'une réparation nerveuse
B) De suivre la récupération
C) D'évaluer la repousse axonale.
D) De faire un pronostic
E) De se passer d'un EMG

73. Devant un kyste hydatique du foie stade I de Gherbi , le diagnose différentiel se pose avec : (RJ)

A) Un kyste biliaire
B) Un abcès hépatique
C)Un cancer primitif du foie
D)Un angiome hépatique
E) Un abcès amibien

74. Une patiente de 21 ans ayant ingéré de façon volontaire un verre de décapant , se présente aux urgences , quelle est la complication imméd pouvant être observée ? (RF) A) Sténose œsophagienne

B) Hémorragie digestive
C) Médiastinite
D) Péritonite
E) CEdème de la glotte

75. Lors d'une intoxication benzène seul des métabolites urinairesci - dessous est retrouvé , lequel ? (RJ)

A) Coproporphyrines
B) Métallothic éine
C) Phénol
D) Albumine
E) Acide delta amino - lévulinique

76) illisible.
77) illisible.
78) illisible.
79) illisible.
80) illisible.

CAS CLINIQUE N ° 01 Patiente / Agée de 23 ans , consulte pour altération de l'état général avec dyspnée récente . L'examen clinique met en évidence des adénomégalies cervicales , une circulation veineuse collatérale pariétale thoracique et un adème en pèlerine . La radiographie du thorax de face montre une opacité dense homogène à limites internes noyées dans le médiastin , à limites externes nettes polycycliques s'effaçant à sa partie supérieure droite .

81. De quels syndromes s'agit - il ? (RJ)

1) Syndrome cave supérieur
2) Syndrome de condensation pulmonaire
3) Syndrome médiatisnal
4) Syndrome d'épanchement pleural aérien
5) Syndrome de Pancoast Tobias

A)11 + 3 B) 2 + 5 C) 3 + 5 D) 2 + 3 E) 4 + 5

82. Où siège précisément l'opacité : (RJ)

A Médiastin antérieur
B) Lobe supérieur droit
C) Médiastin postérieur
D) Lobe supérieur droit et moyen
E) Médiastin moyen

83. Quels diagnostics évoquez - vous : (RJ)

1. Lymphome
2. Pneumonie
3. Pleurésie enkystée
4. Thymome
5. Schwannome .

A) 1 + 3 B) 4 + 5 C) 1+4 D) 1 + 5 E) 2 + 4

CopyWal
-a l'interieur de la fac usdb (Pavillon-18)
-en face des amphis médecine (pav-29)

84. demander en priorité : (RJ)

A) Echocardlodoppler
B) IRM thoracique .
C) TDM thoracique .
D) ECG
E) Anticorps anti - récepteur à l'acétylcholine .

85. L'envahissement structure anatomique permettrait d'expliquer tableau clinique : (RJ)

A) La paroi thoracique
B) Tronc veineux brachio - céphalique
C)Veine cave supérieure
D) Artère pulmonaire
E) Veine azygos .

CAS CLINIQUE NO Patient âgé de 17 ans consulte en hématologie pour asthénie importante , fièvre , syndrome - hémorragique & type d'épistaxis et de gingivorragies évoluant

Examen clinique : Etat général médiocre , pâleur cutané muqueuse , Purpura pétéchial et ecchymotique prédominant aux membres inférieurs ; épistaxis et depuis un mols . ATCD : RAS gingivorragies Polvadénopathies généralisées de 0.5 à 3 cm de diamètre . TA : 120/80 mm Hg , Température : 37 ° 9 C. Roste de l'examen sans particularité .

86. Quel diagnostic évoquerez - vous ? (RJ)

A) Aplasie médullaire .
B) Purpura thrombopénique auto - immun
C)Maladie de Willebrand . D)Leucémie aigué .
E)Leucémie lymphoïde chronique .

87. Quels sont les examens que vous effectuerez en première intention ? (RJ)

A) Hémogramme , VS , réticulocytose .
B)Hémogramme , frottis sanguin , réticulocytes .
C) Hémogramme , temps de saignement .
D)Hémogramme , IDR , ponction ganglionnaire .
E) .TS , TQ , TCA

88. Los examens pratiqués chez ce patient nous donnent les résultats suivants : GR : 2 M / mm3 , Hb : 7g / dl , Hte : 21 % , GB : 60.000 / mm³ , plaquettes : 10.000 / mm³ . Le diagnostic évoqué Initialement est - il maintenu ? Sinon donnez votre nouveau diagnostic : (RJ)

A) Aplasie médullaire .
B) Purpura thrombopénique auto - immune
C) Maladie de Willebrand D)Leucémie algue
E)Leucémie lymphoïde chronique

89. Quels sont les examens nécessaires pour confirmer le diagnostic : (RJ)

A) Frottis sanguin
B)Frottis sanguin + médullogramme + colorations cytochimies
C) Dosage du facteur Willebrand + temps de saignement
D) Sérologie HIV
E) Anticorps Anti - DNA

90. Le traitement chez ce patient consiste à donner : (RJ)

A) Corticothérapie à raison de 1mg / kg / jour pendant 21 jours
B) Androgénothérapie ou ciclosporine
C) Plasma frais congelé et / ou facteur Willebrand D)Polychimiothérapie de type CHOP
E)Chimiothérapie de leucémie aigué

CAS CLINIQUE N ° 03 Nourrisson âgé de 6 mois présente une diarrhée aigue depuis la veille faite de selles) , plusieurs épisodes de vomissements , il est fébrile à 39 ° C et son poids est de 5 kg , il présente les signes cliniques suivants : globes oculaires excavés , plis cutanés , fontanelle antérieure déprimée , tachycardie , polypnée myosis , marbrures , TRC à 3 secondes .

lonogranime sanguin retrouve une natrémie à 142 mEq /l ;

91. Que présente ce nourrisson ? (RJ)

A) Déshydratation aigue isonatrémique estimée à 10 %
B) Déshydratation aigua isonatrémique estimée à 15 %
C)Déshydratation sigue isonatrémique estimée à 10 % avec acidose
D) Déshydratation algue Isonatrémique estimée à 10 % sans acidose
E) Déshydratation aigué isonatrémique estimée à % avec acidose

92. Quel soluté allez - vous utiliser au cours des 2 premières heures et à quelle quantité ? (RJ)

A)100 cc de SBI
B) 250 cc SSL
C) 250 cc SG à 5 %
D) 250 cc SIR
E) 100 cc SSI

93. Au cours de la déshydratation aigue Isonatrémique estimée à 10 % quels solutés peut - on utiliser au cours des 30 premières minutes ? (RJ)

1) SBI
2)SSI
3) SG à 5 %
4) SIR

A)12 B) 72-3 C) 1-344 D)2-3-4 E) 1-3

94. Après 2 heures de réhydratation bien conduite le nourrisson n'a pas uriné , quelle est votre attitude ? (RJ)

A) Administrer 1mg / kg de furosémide en intraveineux BY
B) Administrer 50 cc de SSI en perfusion sur 1 heure
C) Administrer 50 cc de SBI en perfusion sur 1 heure
D) Administrer 50 cc de SIR en perfusion sur 1 heure
E) Arrêter les perfusions

95. Quels sont les éléments de surveillance les plus importants , après 2 heures de réhydratation ? (RJ)

1) Poids
2) Obtention de la diurèse
3) Créatinémie
4) Urée
5) Densité urinaire

A) 1-2 B) 1-5 C) 2-5 D) 1-8-4 E) 3-4-5

CAS CLINIQUE N ° 04 Un malade victime d'un accident de la circulation est hospitalisé aux urgences . l'examen objective : -Réponse verbale à la douleur -Réponse motrice en flexion à gauche et extension à droite - Ouverture des yeux nulle

96. Vous scorez le malade à : (RJ)

A) 9/15
B) 8/15
C) 6/15
D) 4/15
E) 11/15

97. Après les gestes d'urgence habituels , vous demanderez les examens suivants : (RJ)

A) Rx du crâne + Rx du rachis cervical

B) EEG

C) Scanner cérébral

D) Ponction lombaire

E) Fond d'œil

98. Le diagnostic chez ce patient est celui d'un hématome sous - dural algue. Quel traitement vous préconisez : (RJ)

A) Anti - oedèmes en « flash >>

B)Surveillance sous monitoring

C)Opérer le patient

D Hospitalisation et oxygénothérapie

E) Surveiller et opérer si le malade s'aggrave

99. Après 48 h , ce patient présente une altération de son état de conscience , vous pratiquez : (RJ)

A) Une ponction ventriculaire

B Une dérivation externe

C) Une valve de dérivation VP D) Une endoscopie cérébrale

E) Un scanner cérébral

100. Une amélioration est notée , mais il existe une anisocorie à droite . Vous pensez d'abord à : (RJ)

A)Une reprise de l'hématome sous - dural aigu

B) Un hématome sous - dural chronique

C) Un Œdème cérébral

D) Une atteinte du III iatrogène

E) Aucune de ces réponses

DOSSIER CLINIQUE N ° 01 Mr M - A âgé de 65 ans , évacué à l'UMC pour une dyspnée de repos avec agitation l'obligeant à se mettre opposition demi - assise . L'interrogatoire de l'accompagnateur retrouve une notion de douleurs thoraciques évoluant depuis 8 heures . Par ailleurs on retrouve une notion de tabac à chiquer depuis une durée indéterminée , aussi le patient est sous comprimés pour son diabète datant depuis plus de 10 ans . L'examen clinique retrouve une TA à 71/43 mm Hg , avec des râles crépitant aux 2/3 des champs pulmonaires .

101 30ml est l'examen complémentaire à faire en urgence ? (RJ)

A) Une radiographie du thorax de face .

B) Un angloscanner thoracique

C)Une scintigraphie myocardique .

D) Un électrocardiogramme .

E) Une échographie cardiaque

102. Entre temps le patient doit être : (RJ)

A) Evacué vers un service de réanimation polyvalente .

B) Rassuré car il s'agit d'une pneumopathie bénigne

C) Mis sous diurétiques oraux

D) Hospitalisé en unité de soins intensifs cardiologiques avec mise en œuvre d'uns traitement diurétique injectable .

E) Hospitalisé en unité de soins intensifs , double voie d'abord , monitoring électrique et hémodynamique avec une SPO2

103. Le tracé électrique du patient retrouve une onde Q avec un sus - décalage du segment ST de V1 à V6 et en D1 et AVL , Il s'agit de : (RJ)

A) Un syndrome coronarien aigu ST + en postérieur étendu compliqué de choc cardiogénique .

B) Un syndrome coronarien aigu ST + septal profond avec hypotension .

C) Un syndrome coronarien aigu ST + en antérieur étendu compliqué de choc cardiogénique .

D) Un choc septique secondaire à sa pneumopathie .

E) Un infarctus du ventricule droit en état de choc

104. Quelques minutes après l'admission le patient présente une crist convulsive avec un tracé électrique chaotique , il s'agit de : (RJ)

A) Une hypoglycémie .

B) Une crise d'épilepsie

C)Une crise de tétanie

D) Une fibrillation auriculaire rapide

E)Une fibrillation ventriculaire

105. Quelle est votre conduite immédiate ? (RJ)

A) Injection rapide d'un sérum glucosé hypertonique .
B) Injection intraveineuse de benzodiazépines
C) Injection de carbonate de calcium
D) Injection de Bétabloquants intraveineux
E) Choc électrique extrême

106. L'évènement étant jugulé , quelle serait votre attitude thérapeutique en urgence ? (RJ)

A) Doses de charge de bithérapie anti agrégante + fibrinolyse + inotropes positifs B) Doses de charge de bithérapie anti agrégante + angioplastie primaire + assistance circulatoire .
C) Doses de charge de bithérapie anti agrégante + inotropes positifs
D) Doses de charge de bithérapie anti agrégante antibiotiques + fibrinolyse + assistance circulatoire .
E) Doses de charge de bithérapie anti agrégante + antibiotiques

107. L'efficacité thérapeutique est attestée par : (RJ)

A) Une diminution de la douleur .
B) Une diminution de la dyspnée
C) Une réduction du sus - décalage
D) Un flux TIMI 3 agiographique
E) Une pression artérielle > 80 mm Hg

108. Le bilan du lendemain retrouve une clearance de la créatinine à 30 ml / min avec une urbée à 1 , 6 g / l , une HbA1c à 9 , 2 % , il s'agit de :

A) Une insuffisance rénale chronique nécessitant une hémofiltration en urgence
B) Une insuffisance rénale aigué secondaire à l'état de choc
C) Une infection urinaire qui doit être mise sous antibiotiques
D) Une insuffisance rénale aiguë secondaire au traitement anti épileptique
E) Une insuffisance rénale chronique secondaire au diabète .

109. La prise en charge consiste en : (RJ)

A) Aune dialyse en urgence
B) Une réhydratation avec surveillance du bilan rénal
C) Une dialyse péritonéale
D) Une injection de digitaliques à forte dose
E) Une greffe rénale .

110. L'ordonnance de sortie comportera obligatoirement tous ces éléments sauf un , lequel ? (RJ)

A) Une insulinothérapie .
B) De la metformine .
C) Un arrêt du tabac
D) IEC + bithérapie antiagrégante + statines
E) Une réadaptation cardiaque avec éducation thérapeutique du patient .

DOSSIER CLINIQUE N ° 02 Madame M. est une femme de 35 ays , mariée à l'âge de 18 ans , G5P2 A3 (2 enfants vivants et 3ABBT curetés) . Elle n'a jamais été opérée et s'est fait poser Il y a un an un DIU (dispositif intra utérin) au cuivre . Elle se présente chez vous pour une consultation de routine .

111. Au sujet du DIU au cuivre ? (RJ)

1. Il est contre - indiqué chez les patientes après un ABRT
2. Il est valable 5 ans
3. Il peut être utilisé comme contraception d'urgence
4. Il bloque l'ovulation
5. Les anticoagulants sont contre - indiqués

A) 1 + 2 + 5 B)2 + 3 + 5 C) 2 + 344 D) 1 + 3 + 5 E) 1 + 2 + 3

112. La patiente consulte pour des leucorrhées verdâtres fétides dans un contexte apyrétique . Ces signes vous font penser à une : (RJ)

A) Infection à HPV
B) infection à chlamydia
C) Infection à trichomonas .
D) Infection à Candida albicans E) Infection à streptocoque

113. Quel traitement allez - vous donner en première Intention ? (RJ)

A) Amoxicilline
B) Métronidazole
C) Fluconazole
D) AINS
E) Corticoïdes

114. La patiente n'a jamais fait de frottis cervico - utérin , quelle est la réponse juste ? (RJ)

A) ll est recommandé dès 25 ans
B) Il se fait tous les 2-3 ans
C) C'est une analyse histologique de l'endocol et de l'exocol
D) Peut - être interprétable juste après un rapport sexuel
E) Interprétable lors d'une infection génitale basse

115. Après traitement la patiente revient pour un frottis . Voici le résultat : CIN1 . Que proposez - vous en premier ? (RJ)

A Contrôle après un mois
B) Conisation
C) Colposcopie
D) PCR à la recherche de HPV oncogène
E) Abstention

116. Quelle est la réponse juste ? (RJ

1. C'est un virus de la famille Herpès
2. Il faut réaliser une colposcopie
3.MadameM. a des facteurs de risque d'infection par HPV
4. On peut traiter par crème topique
5. Toutes les réponses sont justes

A) 1 + 2 B2 + 3 C) 3 + 4 D) 2 + 4 E) 5

117. La colposcopie met en évidence des lésions suspectes biopslées . Quelle est votre prise en charge ? (RJ)

A) Hystérectomie
B) Conisation
C) Contrôle colposcopique dans 2 mois
D) Cures à l'acide acétique
E) Toutes les réponses sont justes

118. Deux ans plus tard , les FCV de contrôle sont normaux et Madame Ma souhaité garder sont DIU . Elle se présente aux urgences pour des douleurs de la fosse iliaque droite évoluant depuis 02 jours avec fièvre et leucorrhées Jaunâtros à l'examen . A quoi pensez - vous à ce stade ? (RJ)

A) Appendicite
B) Infection génitale haute
C) Grossesse extra utérine
D) Pyélonéphrite Toutes les réponses sont justes

119. L'échographie réalisée retrouve une masse latéro - utérine droite de 4 cm , avasculaire , et un épanchement minime du Douglas . Les ß - hCG sont négatives , la CRP = 120 , les leucocytes = 14000 / mm³ . Quel est le diagnostic le plus probable ? (RJ)

A) Appendicite
B) Infection génitale haute
C) Grossesse extra utérine
D) Kyste de l'ovaire
E) Toutes les réponses sont justes

120. Quelle conduite adoptez - vous vis - à - vis du DIU

A) Laisser en place pendant encore 2 ans
B Retrait immédiat
C) Contre - indication définitive à la pause d'un deuxième
D) Laisser en place et contrôle avec prélèvements bactériologiques dans 2 semaines
E) Retrait immédiat et le remplacer par un système intra utérin (SIU) à la progestérone.

CT Examen Résidanat Mars 2021

Question	Réponse	Question	Réponse	Question	Réponse	Question	Réponse
1	**A**	33	**D**	65	**E**	97	**C**
2	**E**	34	**E**	66	**D**	98	**C**
3	**B**	35	**A**	67	**A**	99	**E**
4	**D**	36	**E**	68	**B**	100	**A**
5	**C**	37	**D**	69	**C**	101	**F**
6	**E**	38	**C**	70	**D**	102	**E**
7	**B**	39	**D**	71	**C**	103	**C**
8	**D**	40	**E**	72	**E**	104	**E**
9	**A**	41	**D**	73	**A**	105	**E**
10	**D**	42	**C**	74	**A**	106	**B**
11	**C**	43	**D**	75	**C**	107	**D**
12	**B**	44	**C**	76	**E**	108	B
13	**B**	45	**C**	77	**C**	109	B
14	**C**	46	**E**	78	**B**	110	B
15	**D**	47	**D**	79	**A**	111	B
16	**C**	48	**D**	80	**E**	112	C
17	**A**	49	**B**	81	**A**	113	B
18	**D**	50	**E**	82	**A**	114	B
19	**A**	51	**C**	83	**C**	115	D
20	**D**	52	**C**	84	**C**	116	B
21	**D**	53	**C**	85	**C**	117	B
22	**B**	54	**B**	86	**D**	118	E
23	**C**	55	**D**	87	**B**	119	B
24	**B**	56	**C**	88	**D**	120	B
25	**D**	57	**D**	89	**B**		
26	**B**	58	**C**	90	**E**		
27	**B**	59	**B**	91	**C**		
28	**E**	60	**B**	92	**B**		
29	**A**	61	**C**	93	**A**		
30	**A**	62	**B**	94	**/**		
31	**A**	63	**B**	95	**C**		
32	**D**	64	**D**	96	**C**		

Copyright